Optimal Untuk Negeri

optimal

Buku Ajar

RISET KEPERAWATAN DAN EVIDENCE-BASED NURSING

Ni Luh Kompyang Sulisnadewi • Nur Fadhilah • Aemilianus Mau
Ina Debora Ratu Ludji • Mellia Silvy Irdianty • Septina Boru Saragih

Editor: Prof. Ferry Efendi, S.Kep., Ns., M.Sc., Ph.D.



BUKU AJAR
RISET KEPERAWATAN DAN EVIDENCE-BASED NURSING

Penulis:

Ns. Ni Luh Kompyang Sulisnadewi, M.Kep., Sp.Kep., An.

Nur Fadhilah, S.Kep., M.Kes., Ph.D.

Dr. Aemilianus Mau, S.Kep., Ns., M.Kep.

Dr. Ina Debora Ratu Ludji, SKp., M.Kes.

Ns. Mellia Silvy Irdianty, M.PH.

Septina Boru Saragih S.Kep., Ners., M.Kep.

Editor:

Prof. Ferry Efendi, S.Kep., Ns., M.Sc., Ph.D.

Optimal Untuk Negeri

Buku Ajar Riset Keperawatan dan Evidence-Based Nursing

Penulis:
Ns. Ni Luh Kompyang Sulisnadewi, M.Kep., Sp.Kep., An.
Nur Fadhilah, S.Kep., M.Kes., Ph.D.
Dr. Aemilianus Mau, S.Kep., Ns., M.Kep.
Dr. Ina Debora Ratu Ludji, SKp., M.Kes.
Ns. Mellia Silvy Irdianty, M.PH.
Septina Boru Saragih S.Kep., Ners., M.Kep.

Editor:
Prof. Ferry Efendi, S.Kep., Ns., M.Sc., Ph.D.

Desain Sampul: Ivan Zumarano
Penata Letak: Muhammad Ilham

ISBN: 978-634-7756-80-0
Cetakan Pertama: Agustus, 2026
Hak Cipta 2026
Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
Copyright © 2026
by Penerbit PT Optimal Untuk Negeri
All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.
Website : optimaluntuknegeri.com
Instagram : @bimbel.optimal
Tiktok : @maskokooo

PENERBIT:
PT OPTIMAL UNTUK NEGERI
Kencana Tower Lt. Mezzanine
Jl. Raya Meruya Ilir No. 88
RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta
Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, *Buku Ajar Riset Keperawatan dan Evidence-Based Nursing* dapat disusun sebagai bahan pembelajaran bagi mahasiswa keperawatan dalam memahami konsep, prinsip, dan penerapan riset keperawatan secara ilmiah. Buku ini hadir untuk mendukung proses pembelajaran yang menekankan pentingnya kemampuan berpikir kritis, etika penelitian, integritas ilmiah, serta penerapan *Evidence-Based Nursing* dalam pengambilan keputusan klinis dan peningkatan mutu pelayanan keperawatan.

Materi dalam buku ini disusun secara bertahap mulai dari konsep dasar riset keperawatan dan *Evidence-Based Nursing*, etika dan integritas ilmiah, cara menemukan masalah serta merumuskan pertanyaan dan tujuan penelitian, hingga telaah pustaka dan manajemen referensi. Pembaca juga diarahkan untuk memahami penyusunan kerangka teori, kerangka konsep, hipotesis, desain penelitian kuantitatif, populasi, sampel, dan teknik sampling. Selain itu, buku ini dilengkapi dengan pembahasan mengenai strategi pencarian literatur, penggunaan database ilmiah, teknik sitasi, perangkat lunak manajemen referensi, pencegahan plagiarisme, serta integrasi referensi dalam penulisan ilmiah.

Penulis berharap buku ajar ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, peneliti pemula, dan praktisi keperawatan dalam mengembangkan kemampuan melakukan riset yang sistematis, etis, dan relevan dengan kebutuhan praktik keperawatan. Melalui aktivitas pembelajaran, studi kasus, latihan, praktikum, portofolio, rangkuman materi, dan daftar pustaka yang tersedia pada setiap bab, buku ini diharapkan mampu mendorong pembaca untuk menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas serta menerapkan bukti ilmiah terbaik dalam pelayanan keperawatan. Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan pada edisi berikutnya.

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA iii
DAFTAR ISI iv

BAB 1 KONSEP DASAR RISET KEPERAWATAN DAN EVIDENCE-BASED NURSING (EBN) 1
A. Konsep Dasar Riset Keperawatan 4
B. Konsep *Evidence-Based Nursing (*EBN) 13
C. Etika dan Integritas Ilmiah 20
D. Rangkuman Materi 32
E. Daftar Pustaka 34

BAB 2 MENEMUKAN MASALAH DAN MERUMUSKAN PERTANYAAN PENELITIAN 37
A. Pengertian Masalah Penelitian dalam Keperawatan 39
B. Masalah Penelitian dan Sumbernya di Berbagai Area Keperawatan 39
C. Cara Mendapatkan Masalah (Sumber Masalah) 42
D. Identifikasi & Perumusan Pertanyaan Penelitian 43
E. Merumuskan Tujuan Penelitian 46
F. Matriks Kriteria Kelayakan Masalah (FINER) 57
G. Rangkuman Materi 57
H. Soal Latihan & Kasus (CBL) 57
I. Daftar Pustaka 61

BAB 3 TELAAH PUSTAKA DAN MANAJEMEN REFERENSI 63
A. Peran Manajemen Referensi Dalam Evidence-Based Nursing (Ebn) 73
B. Jenis dan Sumber Referensi Ilmiah 74
C. Database Literatur Ilmiah 75
D. Pentingnya Pemanfaatan Database Ilmiah Yang Tepat 77
E. Teknik Sitasi Dalam Penulisan Ilmiah 78
F. Software Manajemen Referensi 78
G. Format File Referensi: Ris dan Bibtex 79
H. Plagiarisme dan Integritas Akademik 80
I. Integrasi Referensi Dengan Microsoft Word 80
J. Strategi Pencarian Literatur 82

K. Manajemen Referensi dan Sintesis Literatur 85
L. Aktivitas 1 — Knows How (Mini Case) 87
M. Aktivitas 2 — Shows How (Praktikum) 87
N. Latihan 87
O. Rangkuman Materi 87
P. Daftar Pustaka 88
Q. Glosarium 88

BAB 4 KERANGKA TEORI, KERANGKA KONSEP, DAN HIPOTESIS 89
A. Pengertian Kerangka Teori Penelitian 93
B. Teori Health Belief Model (HBM) 96
C. Kerangka Konsep Penelitian 102
D. Hipotesis Penelitian 105
E. Aktivitas 1 — Knows How Mini-Case Tertulis 111
F. Rangkuman Materi 120
G. Daftar Pustaka 120

BAB 5 DESAIN PENELITIAN KUANTITATIF 123
A. Konsep Dasar Desain Penelitian Kuantitatif 126
B. Jenis-Jenis Desain Penelitian Kuantitatif 126
C. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 128
D. Variabel Penelitian dan Operasionalisasi dalam Keperawatan 129
E. Instrumen Penelitian Kuantitatif dalam Keperawatan 130
F. Sekilas Validitas dan Reliabilitas Instrumen 130
G. Prosedur Pengumpulan Data 130
H. Teknik Analisis Data Kuantitatif 131
I. Konsep Dasar Desain Penelitian Kuantitatif dalam Keperawatan 131
J. Jenis-Jenis Desain Penelitian Kuantitatif dalam Keperawatan 132
K. Variabel Penelitian dan Operasionalisasi dalam Keperawatan 134
L. Instrumen Penelitian Kuantitatif dalam Keperawatan 135
M. Sekilas Validitas dan Reliabilitas Instrumen 136
N. Prosedur Pengumpulan Data dalam Penelitian Keperawatan 136
O. Teknik Analisis Data Kuantitatif Dasar 137
P. Latihan Soal 138
Q. Daftar Pustaka 145

BAB 6 POPULASI, SAMPEL DAN TEKNIK SAMPLING 147
A. Populasi 156

B. Sampel 157
C. Teknik Sampling 158
D. Aktivitas 1 — Knows How (Mini Case) 160
E. Aktivitas 2 — Shows How (Praktikum) 160
F. Portofolio 174
G. Rangkuman Materi 176
H. Tabel Red Flags & Eskalasi 178
I. Daftar Pustaka 181

PROFIL PENULIS 183

BAB 1

KONSEP DASAR RISET KEPERAWATAN DAN EVIDENCE-BASED NURSING (EBN)

Capaian Pembelajaran

CPL-1

Menguasai konsep riset keperawatan dan Evidence-Based Nursing (EBN), termasuk etika, integritas ilmiah, dan hirarki bukti sebagai landasan praktik.

CPL-2

Mampu mengidentifikasi masalah keperawatan/praktik, merumuskan pertanyaan penelitian/EBN, serta menetapkan tujuan yang terukur.

CPL-3

Mampu merancang metode penelitian (kuantitatif/kualitatif) termasuk desain, populasi–sampel, sampling, instrumen, dan prosedur pengumpulan/manajemen data secara sistematis.

CPL-4

Mampu melakukan analisis data dasar (kuantitatif/kualitatif) dan menyajikan temuan secara ilmiah, jelas, dan dapat ditindaklanjuti

CPL-5

Mampu melakukan critical appraisal bukti dan merancang penerapan EBN di praktik dengan indikator evaluasi yang terukur dan kolaboratif.

CPL-6

Mampu menyusun proposal/skripsi/manuskrip ilmiah, mengelola referensi, dan menyampaikan hasil secara profesional untuk perbaikan mutu layanan.

CPMK

CPMK-1

Menjelaskan konsep dasar riset keperawatan dan EBN, termasuk etika–integritas ilmiah, keselamatan partisipan, dan prinsip penggunaan bukti.

Sub-CPMK

- Menjelaskan langkah inti riset dan siklus EBN (ask–acquire–appraise–apply–assess) sebagai alur kerja berbasis bukti.

- Mengidentifikasi prinsip etika, integritas ilmiah, dan perlindungan partisipan pada penelitian keperawatan.

CPMK-2

Merumuskan masalah, tujuan, dan pertanyaan penelitian/EBN yang fokus, terukur, dan feasible sesuai konteks keperawatan

Sub-CPMK

- Mengidentifikasi gap praktik/masalah prioritas dan menyusun latar belakang berbasis data awal.
- Merumuskan pertanyaan penelitian/EBN (mis. PICOT/SPIDER) dan tujuan yang terukur

CPMK-7

Melakukan critical appraisal dan menetapkan tingkat bukti, merancang implementasi EBN di praktik, serta menyusun proposal/skripsi/manuskrip sesuai kaidah ilmiah.

Sub-CPMK

- Menetapkan populasi sasaran, kriteria inklusi–eksklusi, dan kebutuhan ukuran sampel secara rasional.
- Memilih teknik sampling (probability/non-probability) dan justifikasi kesesuaian dengan desain

Pendahuluan

Perkembangan keperawatan modern menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari praktik yang berorientasi pada pengalaman menuju praktik yang berbasis pada bukti ilmiah (*evidence-based practice*). Transformasi ini tidak terlepas dari meningkatnya kompleksitas kebutuhan pelayanan kesehatan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang aman, efektif, dan bermutu tinggi. Dalam kondisi tersebut, perawat dituntut untuk mampu mengambil keputusan klinis yang tidak hanya cepat, tetapi juga akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Riset keperawatan merupakan fondasi utama dalam pengembangan ilmu dan praktik keperawatan. Melalui riset, perawat dapat menghasilkan pengetahuan baru yang disusun secara sistematis, logis, dan berbasis metode ilmiah, sehingga memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi. Riset juga berfungsi sebagai sarana untuk menguji efektivitas intervensi keperawatan, mengidentifikasi masalah kesehatan yang aktual, serta memberikan solusi berbasis data terhadap berbagai permasalahan dalam praktik klinis maupun komunitas.

Peran riset keperawatan menjadi semakin penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar dalam

menyusun standar operasional prosedur (SOP), pedoman praktik klinis, serta kebijakan kesehatan yang lebih tepat sasaran. Selain itu, riset juga berkontribusi dalam meningkatkan keselamatan pasien (*patient safety*) melalui identifikasi risiko, pencegahan kesalahan medis, dan penerapan intervensi yang telah terbukti efektif. Dengan demikian, praktik keperawatan tidak lagi bersifat trial and error, melainkan berbasis pada bukti yang teruji.

Sejalan dengan hal tersebut, *Evidence-Based Nursing* (EBN) hadir sebagai pendekatan yang mengintegrasikan tiga komponen utama, yaitu bukti ilmiah terbaik (*best evidence*), keahlian klinis perawat (*clinical expertise*), serta nilai dan preferensi pasien (*patient values*). Pendekatan ini menekankan bahwa keputusan klinis yang optimal tidak hanya didasarkan pada hasil penelitian semata, tetapi juga mempertimbangkan kondisi klinis pasien secara individual serta aspek budaya, sosial, dan psikologis yang melatarbelakanginya.

Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif mengenai konsep dasar riset keperawatan dan *Evidence-Based Nursing* merupakan kompetensi fundamental yang harus dimiliki oleh mahasiswa maupun praktisi keperawatan. Penguasaan kompetensi ini tidak hanya akan meningkatkan kemampuan dalam menghasilkan dan menggunakan bukti ilmiah, tetapi juga memperkuat profesionalisme perawat dalam memberikan pelayanan yang aman, etis, dan berkualitas tinggi. Ke depan, perawat diharapkan tidak hanya menjadi pengguna hasil penelitian, tetapi juga berperan aktif sebagai peneliti yang berkontribusi dalam pengembangan ilmu keperawatan secara berkelanjutan.

Uraian Materi

A. Konsep Dasar Riset Keperawatan

1. Definisi Riset Keperawatan

a. Definisi Riset

Riset adalah suatu proses ilmiah yang dilakukan secara sistematis, logis, empiris, dan terkontrol untuk memperoleh pengetahuan baru atau menguji pengetahuan yang telah ada. Riset melibatkan tahapan yang terstruktur mulai dari perumusan masalah, pengumpulan data, analisis, hingga interpretasi hasil guna menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah tertentu. Berikut adalah beberapa definisi riset menurut beberapa ahli:

1) John W. Creswell (2018)

Menurut Creswell, riset adalah suatu proses sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi guna meningkatkan pemahaman terhadap suatu fenomena atau masalah.

2) Polit & Beck (2019)

Riset didefinisikan sebagai penyelidikan yang sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis terhadap fenomena alam atau sosial yang bertujuan untuk mengembangkan atau menguji pengetahuan.

3) Kerlinger (2000)

Riset adalah penyelidikan yang sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis terhadap proposisi hipotesis mengenai hubungan antar fenomena.

4) Sugiyono (2022)

Riset merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, yang dilakukan melalui prosedur sistematis dan logis.

b. Definisi Riset Keperawatan

Riset keperawatan merupakan bentuk khusus dari riset yang berfokus pada pengembangan ilmu dan praktik keperawatan. Riset ini tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan pengetahuan, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan, keselamatan pasien, serta efektivitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Riset keperawatan memiliki karakteristik yang kontekstual, karena berkaitan

langsung dengan kebutuhan pasien, keluarga, dan masyarakat. Berikut adalah beberapa definisi riset menurut beberapa ahli:

1) **Denise F. Polit & Cheryl Tatano Beck (2021)**

   Riset keperawatan adalah penyelidikan sistematis yang dirancang untuk mengembangkan pengetahuan tentang isu-isu yang penting bagi praktik keperawatan, termasuk promosi kesehatan, pencegahan penyakit, dan perawatan pasien.

2) **LoBiondo-Wood & Judith Haber (2025)**

   Riset keperawatan adalah proses ilmiah yang bertujuan untuk menghasilkan pengetahuan baru yang dapat meningkatkan praktik keperawatan dan hasil kesehatan pasien.

3) **Burns & Grove (2019)**

   Riset keperawatan merupakan proses ilmiah yang sistematis untuk mengembangkan pengetahuan yang relevan dengan praktik keperawatan, termasuk pendidikan, administrasi, dan pelayanan kesehatan.

4) **Nursalam (2020)**

   Riset keperawatan adalah proses sistematis dalam mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, dan menganalisis data untuk meningkatkan mutu pelayanan keperawatan serta pengembangan ilmu keperawatan.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa riset dan riset keperawatan memiliki kesamaan dalam prinsip ilmiah, namun berbeda dalam ruang lingkup dan aplikasinya. Riset keperawatan menempatkan praktik keperawatan sebagai fokus utama, sehingga hasilnya harus relevan, aplikatif, dan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

2. Tujuan Riset Keperawatan

Tujuan riset secara umum adalah untuk memperoleh pengetahuan baru, menguji teori, serta memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi manusia melalui pendekatan ilmiah yang sistematis. Berdasarkan berbagai pendapat ahli, tujuan riset keperawatan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bagian utama sebagai berikut:

a. Menghasilkan Bukti Ilmiah (*Scientific Evidence*)

Riset keperawatan bertujuan untuk menghasilkan bukti ilmiah yang valid dan dapat dipercaya sebagai dasar dalam praktik keperawatan. Bukti ini menjadi landasan dalam meningkatkan mutu pelayanan serta

memastikan tindakan keperawatan yang diberikan bersifat rasional dan terukur.

b. Mengembangkan Ilmu dan Dasar Teori Keperawatan

Riset berperan dalam mengembangkan pengetahuan dan teori keperawatan melalui proses ilmiah, termasuk pengujian konsep, model, dan intervensi keperawatan, sehingga memperkuat keilmuan profesi keperawatan.

c. Meningkatkan Kualitas Praktik dan Pelayanan Keperawatan

Salah satu tujuan utama riset adalah untuk memperbaiki praktik keperawatan dengan mengidentifikasi intervensi yang paling efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan pasien, sehingga kualitas pelayanan kesehatan dapat meningkat secara berkelanjutan.

d. Mendukung Pengambilan Keputusan Klinis

Hasil riset digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan klinis yang tepat, berbasis bukti (*evidence-based*), serta mempertimbangkan kondisi pasien secara individual.

e. Meningkatkan Keselamatan dan Outcome Pasien

Riset keperawatan bertujuan untuk meningkatkan keselamatan pasien (*patient safety*), kualitas hidup, serta outcome kesehatan melalui penerapan intervensi yang telah terbukti efektif dan aman.

f. Mengembangkan Intervensi Keperawatan yang Efektif

Melalui riset, berbagai tindakan atau intervensi keperawatan dapat diuji efektivitasnya, sehingga diperoleh metode yang paling tepat dalam meningkatkan kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat.

g.* Mengintegrasikan Hasil Penelitian ke dalam Praktik (*Evidence-Based Practice)

Riset keperawatan bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat diimplementasikan dalam praktik nyata, sehingga terjadi integrasi antara ilmu pengetahuan dan pelayanan keperawatan profesional.

3. Karakteristik Riset Keperawatan

Riset keperawatan merupakan proses ilmiah yang memiliki karakteristik utama yaitu: sistematis, logis dan rasional, empiris, replikatif, serta objektif. Kelima karakteristik tersebut saling berkaitan dan membentuk suatu kerangka metodologis yang menjamin kualitas dan kredibilitas penelitian.

a. Sistematis

Sistematis berarti penelitian mengikuti prosedur ilmiah yang jelas dan terstruktur. Riset keperawatan dilakukan melalui tahapan yang

terstruktur dan berurutan, mulai dari identifikasi masalah, penyusunan kerangka konsep, pengumpulan data, analisis, hingga penarikan kesimpulan. Polit & Beck (2021) dalam buku *Nursing Research: Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice*, menjelaskan bahwa penelitian keperawatan mengikuti langkah-langkah sistematis yang dirancang untuk memastikan hasil yang valid dan dapat dipercaya. Penelitian harus dilaksanakan secara terencana dan berurutan agar menghasilkan data yang bermakna dan dapat dipertanggungjawabkan (Nursalam, 2020)

b. Logis dan Rasional

Logis dan rasional berarti penelitian dapat diterima akal dan didukung teori yang kuat. Riset keperawatan harus didasarkan pada penalaran ilmiah yang masuk akal, baik dalam penyusunan masalah, kerangka teori, maupun interpretasi hasil. Creswell & Creswell (2018) dalam *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* menekankan bahwa penelitian harus dibangun atas dasar logika ilmiah dan argumentasi rasional. Seluruh proses penelitian harus dapat dijelaskan secara rasional dan konsisten dengan teori yang mendasari (Burns & Grove, 2019)

c. Empiris (Berbasis Data)

Empiris berarti penelitian bersumber dari data nyata, bukan opini atau spekulasi. Penelitian keperawatan didasarkan pada fakta nyata yang diperoleh melalui observasi, pengukuran, atau pengalaman langsung, bukan asumsi semata. Polit & Beck (2021) menjelaskan bahwa bukti dalam penelitian keperawatan harus berasal dari data empiris yang dapat diamati dan diukur. Penelitian ilmiah harus berbasis data nyata yang dapat diverifikasi (Sugiyono, 2019)

d. Replikatif

Replikatif berarti penelitian dapat diuji ulang untuk memastikan keandalan hasil. Riset keperawatan harus dapat diulang oleh peneliti lain dengan metode yang sama untuk menguji konsistensi hasil. Polit & Beck (2021) menyatakan bahwa penelitian yang baik memungkinkan replikasi untuk memperkuat validitas temuan. Transparansi prosedur penelitian memungkinkan studi direplikasi dalam konteks berbeda (Creswell & Creswell, 2018)

e. Objektif

Objektif berarti hasil penelitian mencerminkan kondisi sebenarnya tanpa manipulasi. Penelitian keperawatan harus bebas dari bias pribadi

peneliti dan berfokus pada fakta serta data yang diperoleh. Burns & Grove (2019) menjelaskan bahwa objektivitas merupakan prinsip utama agar hasil penelitian tidak dipengaruhi oleh subjektivitas peneliti. Penelitian harus didasarkan pada data yang jujur dan apa adanya.

4. Jenis Penelitian

Riset keperawatan merupakan suatu proses ilmiah yang dapat dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yaitu kuantitatif, kualitatif, dan mixed methods. Berikut adalah perbedaan ketiga jenis penelitian:

Tabel 1.1: Perbedaan Ketiga Jenis Penelitian

Aspek	Riset Kuantitatif	Riset Kualitatif	Mixed Methods
Pengertian	Penelitian yang menggunakan data numerik dan analisis statistik untuk menguji hipotesis, hubungan, perbedaan, atau pengaruh antarvariabel.	Penelitian yang bertujuan memahami makna, pengalaman, persepsi, dan fenomena sosial secara mendalam dari perspektif partisipan.	Penelitian yang mengintegrasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam satu studi untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap suatu fenomena.
Tujuan	Menguji teori atau hipotesis, mengidentifikasi hubungan antarvariabel, serta menghasilkan generalisasi.	Mengeksplorasi dan memahami fenomena, pengalaman, makna, dan konteks sosial secara mendalam.	Menggabungkan kekuatan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih lengkap dan mendalam.
Jenis Data	Data numerik atau angka yang dapat diukur dan dianalisis secara statistik.	Data non numerik berupa narasi, kata-kata, perilaku, dokumen, atau hasil observasi.	Kombinasi data numerik dan non numerik.
Instrumen Penelitian	Kuesioner, tes, skala pengukuran, dan instrumen terstandar lainnya.	Peneliti sebagai instrumen utama yang didukung pedoman	Kombinasi instrumen kuantitatif dan

		wawancara, observasi, dokumentasi, dan catatan lapangan.	kualitatif sesuai desain penelitian.
Teknik Sampling	Probability sampling, seperti simple random sampling, stratified sampling, cluster sampling, dan systematic sampling.	Nonprobability sampling, seperti purposive sampling, snowball sampling, dan theoretical sampling.	Kombinasi probability dan nonprobability sampling sesuai kebutuhan penelitian.
Analisis Data	Analisis statistik deskriptif dan inferensial.	Analisis tematik, content analysis, naratif, grounded theory analysis, atau teknik analisis lain sesuai desain penelitian.	Integrasi analisis statistik dan analisis kualitatif melalui pendekatan konvergen, sekuensial, atau embedded.
Pendekatan Penelitian	Deduktif, terstruktur, empiris, dan berorientasi pada objektivitas.	Induktif, interpretatif, naturalistik, fleksibel, dan kontekstual.	Pragmatik, integratif, dan komplementer antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif.
Hubungan Peneliti dengan Partisipan	Peneliti berupaya meminimalkan bias dan menjaga objektivitas selama proses penelitian.	Peneliti berinteraksi langsung dan membangun hubungan dengan partisipan untuk memperoleh pemahaman mendalam.	Peneliti menjalankan peran objektif sekaligus interpretatif sesuai tahapan penelitian.
Hasil Penelitian	Menghasilkan generalisasi, prediksi, dan pengujian teori.	Menghasilkan pemahaman mendalam dan kontekstual terhadap fenomena tertentu.	Menghasilkan temuan yang lebih lengkap, mendalam, dan saling melengkapi.
Ciri Utama	Uji hipotesis, pengukuran	Eksplorasi makna, pengalaman,	Integrasi data, validasi silang

	variabel, kontrol variabel, validitas, reliabilitas, dan generalisasi.	interpretasi, fleksibilitas, dan kedalaman data.	antarpendekatan, dan pemahaman fenomena secara menyeluruh.
Desain Penelitian Umum	Cross-sectional, cohort, case-control, eksperimen, quasi eksperimen, dan survei.	Fenomenologi, grounded theory, etnografi, studi kasus, dan naratif.	Sequential explanatory, sequential exploratory, convergent, dan embedded design.
Keabsahan Data	Validitas, reliabilitas, objektivitas, dan uji statistik.	Credibility, dependability, confirmability, dan transferability.	Menggunakan kombinasi validitas kuantitatif dan trustworthiness kualitatif.

Riset kuantitatif menurut John W. Creswell (2023) merupakan pendekatan yang digunakan untuk menguji teori secara objektif melalui pengukuran hubungan antar variabel dengan menggunakan instrumen terstandar dan analisis statistik. Pandangan ini diperkuat oleh Denise F. Polit dan Cheryl Tatano Beck (2021) yang menyatakan bahwa riset kuantitatif berfokus pada pengukuran fenomena, pengujian hubungan, serta identifikasi hubungan sebab-akibat. Sementara itu, Burns dan Grove (2021) menekankan bahwa penelitian kuantitatif memiliki kekuatan dalam aspek kontrol, prediksi, dan generalisasi hasil penelitian.

Sementara riset kualitatif lebih menekankan pada pemahaman makna dan pengalaman manusia. John W. Creswell (2023) menjelaskan bahwa pendekatan ini digunakan untuk mengeksplorasi makna dari suatu fenomena sosial atau pengalaman individu. Selanjutnya, Patricia L. Munhall (2019) menegaskan bahwa riset kualitatif dalam keperawatan berfokus pada pengalaman hidup pasien secara mendalam. Pendapat ini juga didukung oleh Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln (2018) yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan menafsirkan fenomena berdasarkan makna yang diberikan oleh individu.

Sementara itu, pendekatan *mixed methods* merupakan integrasi dari kedua metode tersebut. John W. Creswell (2023) menyebutkan bahwa *mixed methods* mengombinasikan data kuantitatif dan kualitatif untuk menghasilkan pemahaman yang lebih lengkap. Hal ini diperkuat oleh Abbas Tashakkori dan Charles Teddlie (2010) yang menjelaskan bahwa metode ini

mengintegrasikan teknik kuantitatif dan kualitatif dalam satu kerangka penelitian. Selain itu, Jennifer C. Greene (2007) menambahkan bahwa penggunaan metode campuran memungkinkan triangulasi data sehingga meningkatkan validitas dan kedalaman hasil penelitian.

Ketiga jenis riset keperawatan memiliki karakteristik yang berbeda namun saling melengkapi. Riset kuantitatif unggul dalam pengujian teori dan generalisasi, riset kualitatif unggul dalam eksplorasi makna dan pengalaman, sedangkan mixed methods memberikan pendekatan yang paling komprehensif dengan menggabungkan keunggulan keduanya. Oleh karena itu, pemilihan metode penelitian harus disesuaikan dengan tujuan, jenis masalah, serta kedalaman informasi yang ingin dicapai dalam penelitian keperawatan.

5. Langkah Inti Riset Keperawatan

Riset keperawatan merupakan suatu proses ilmiah yang sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan, yang disusun secara berurutan dan saling berkaitan mulai dari identifikasi masalah hingga diseminasi hasil penelitian. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan pengetahuan baru, tetapi juga memastikan bahwa setiap temuan memiliki nilai guna dalam meningkatkan praktik keperawatan.

Secara umum, langkah-langkah riset keperawatan terbagi ke dalam lima fase utama, yaitu fase konseptual, desain dan perencanaan, empirik, analisis, dan diseminasi. Setiap fase memiliki peran yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan, karena keseluruhan proses tersebut menentukan kualitas hasil penelitian. Melalui tahapan yang sistematis ini, riset keperawatan mampu menghasilkan data yang valid, reliabel, serta dapat diaplikasikan secara nyata dalam praktik keperawatan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

a. Fase Konseptual (*Conceptual Phase*)

Fase konseptual merupakan tahap awal yang sangat krusial karena menjadi dasar keseluruhan penelitian. Pada tahap ini, peneliti mulai merumuskan arah penelitian secara sistematis. Fase konseptual mencakup pengembangan masalah penelitian, tinjauan literatur, serta kerangka konseptual sebagai dasar penelitian (Denise F. Polit & Cheryl Tatano Beck, 2021)

1) Identifikasi Masalah

Peneliti mengidentifikasi fenomena atau masalah yang terjadi di praktik keperawatan, baik di klinik, komunitas, maupun sistem

pelayanan kesehatan. Masalah harus relevan, aktual, dan memiliki dampak terhadap kualitas pelayanan.

2) Studi Literatur

Peneliti melakukan kajian pustaka untuk memahami teori, konsep, dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah. Studi literatur membantu menghindari duplikasi penelitian dan memperkuat landasan teori.

3) Perumusan Tujuan dan Hipotesis

Peneliti merumuskan tujuan penelitian secara jelas dan spesifik. Pada penelitian kuantitatif, hipotesis juga dirumuskan sebagai dugaan sementara yang akan diuji secara statistik.

b. Fase Desain dan Perencanaan (*Design and Planning Phase*)

Tahap ini berfokus pada penyusunan strategi penelitian agar dapat dilaksanakan secara sistematis dan valid. Tahap perencanaan meliputi pemilihan desain penelitian, penentuan sampel, serta pengembangan instrumen untuk menjamin validitas dan reliabilitas data (Nieswiadomy, 2018)

1) Menentukan Desain Penelitian

Peneliti memilih pendekatan penelitian (kuantitatif, kualitatif, atau mixed methods) serta desain spesifik seperti *cross-sectional, eksperimen*, atau fenomenologi.

2) Menentukan Populasi dan Sampel

Menentukan subjek penelitian yang representatif sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi.

3) Menyusun Instrumen Penelitian

Mengembangkan alat ukur seperti kuesioner, lembar observasi, atau pedoman wawancara yang valid dan reliabel.

c. Fase Empirik (*Empirical Phase)*

Fase ini merupakan tahap implementasi dari rencana penelitian yang telah disusun. fase empirik melibatkan pengumpulan data secara sistematis dan pelaksanaan penelitian sesuai standar ilmiah dan etika (Burns & Susan K. Grove, 2021)

1) Pengumpulan Data

Data dikumpulkan sesuai metode yang telah ditentukan, baik melalui survei, wawancara, observasi, maupun pengukuran klinis.

2) Pelaksanaan Penelitian

Peneliti menjalankan prosedur penelitian sesuai dengan protokol, termasuk memperhatikan aspek etika seperti informed consent dan kerahasiaan data.

d. Fase Analisis (*Analytic Phase*)

Tahap ini bertujuan untuk mengolah dan memahami data yang telah dikumpulkan. analisis data merupakan proses sistematis untuk mengorganisasi, menginterpretasi, dan memberikan makna terhadap data penelitian (Creswell, 2018)

1) Analisis Data

Data dianalisis menggunakan metode statistik (kuantitatif) atau analisis tematik/konten (kualitatif).

2) Interpretasi Hasil

Peneliti menafsirkan hasil analisis dengan mengaitkannya pada teori dan penelitian sebelumnya.

e. Fase Diseminasi (*Dissemination Phase*)

Fase terakhir adalah penyebarluasan hasil penelitian agar dapat dimanfaatkan secara luas. Diseminasi merupakan tahap penting untuk memastikan hasil penelitian dapat diadopsi dalam praktik keperawatan dan kebijakan Kesehatan (Gerrish & Lacey , 2013)

1) Publikasi Hasil Penelitian

Peneliti menyebarluaskan hasil penelitian melalui jurnal ilmiah, seminar, atau konferensi.

2) Implementasi dalam Praktik

Hasil penelitian diterapkan dalam praktik keperawatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan outcome pasien.

B. Konsep *Evidence-Based Nursing (*EBN)

1. Definisi EBN

EBN merupakan pendekatan dalam praktik keperawatan yang menekankan penggunaan bukti ilmiah terbaik dalam pengambilan keputusan klinis untuk meningkatkan kualitas asuhan (Polit & Beck (2021). EBN dilakukan secara sistematis untuk memecahkan masalah klinis dengan mengintegrasikan bukti penelitian terbaik, keahlian klinis, serta nilai dan preferensi pasien (Melnyk & Fineout-Overholt, 2019).

EBN adalah pendekatan sistematis dalam praktik keperawatan yang mengintegrasikan bukti ilmiah terbaik, kompetensi klinis, dan nilai pasien untuk menghasilkan keputusan yang efektif, aman, dan berpusat pada pasien.

2. Komponen EBN

Evidence-Based Nursing (EBN) dibangun atas tiga komponen utama yang saling terintegrasi dan tidak dapat dipisahkan, yaitu bukti ilmiah terbaik (*best evidence*), keahlian klinis (*clinical expertise*), dan nilai serta preferensi pasien (*patient values*)**.** Ketiga komponen ini harus digunakan secara simultan untuk menghasilkan keputusan klinis yang optimal.

Menurut Melnyk & Fineout-Overholt (2019)**,** praktik berbasis bukti tidak akan efektif jika salah satu komponen diabaikan, karena kualitas keputusan klinis ditentukan oleh keseimbangan ketiganya.

a. Bukti Ilmiah Terbaik (*Best Evidence*)

Bukti ilmiah terbaik adalah hasil penelitian yang memiliki validitas tinggi, reliabel, dan relevan dengan masalah klinis yang dihadapi. Bukti ini diperoleh melalui metode ilmiah yang ketat dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Polit & Beck (2021**)**, bukti ilmiah dalam keperawatan harus melalui proses evaluasi kritis (critical appraisal) untuk memastikan kualitasnya sebelum diterapkan. Urutan kekuatan bukti dari yang tertinggi ke terendah adalah:

1) Systematic review & meta-analysis
2) Randomized Controlled Trial (RCT)
3) Quasi-experimental study
4) Cohort / case-control study
5) Descriptive study
6) Expert opinion

b. Keahlian Klinis (*Clinical Expertise*)

Keahlian klinis adalah kemampuan perawat dalam menggunakan pengalaman, keterampilan, dan pengetahuan untuk membuat keputusan klinis secara tepat. Keahlian klinis berkembang melalui pengalaman dan refleksi praktik, dari tingkat pemula hingga ahli (Benner, 2001). Beberapa komponen keahlian klinis diantaranya; Pengalaman praktik langsung, Keterampilan teknis, Kemampuan berpikir kritis, *Clinical judgment*, dan *Clinical decision-making*.

Contoh kasus di klinik; Pasien sesak napas (COPD, bukti menyarankan terapi oksigen, namun perawat berpengalaman: Menyesuaikan aliran O_2 (tidak terlalu tinggi) dan menghindari retensi CO_2. Ini menunjukkan peran *clinical expertise* dalam mengadaptasi bukti. Contoh kasus di komunitas; lansia dengan risiko jatuh, Bukti: latihan fisik efektif, dalam kondisi ini perawat menyesuaikan: Kondisi fisik lansia, Lingkungan rumah, sehingga intervensi menjadi lebih aman dan realistis.

Tanpa keahlian klinis, maka bukti sehebat apapun tidak dapat diterapkan secara optimal sehingga risiko kesalahan meningkat. Dengan keahlian klinis: Intervensi lebih kontekstual dan keputusan lebih tepat

c. Nilai dan Preferensi Pasien (*Patient Values*)

Nilai pasien mencakup keyakinan, budaya, kebutuhan, dan harapan pasien terhadap pelayanan kesehatan. Menurut Sackett et al. (2000), keputusan klinis harus mempertimbangkan nilai pasien agar intervensi dapat diterima dan efektif. Beberapa komponen nilai pasien diantaranya adalah; budaya, agama, preferensi pribadi, kondisi sosial ekonomi dan harapan terhadap terapi.

Contoh kasus di tatanan Klinik; Pasien menolak transfusi darah, padahal secara ilmiah transfusi diperlukan, namun pasien memiliki keyakinan agama tertentu. Dalam hal ini Perawat harus tetap menghormati keputusan pasien dan mencari alternatif terapi. Sebuah kasus pengobatan tradisional pada pasien hipertensi, dimana masyarakat lebih percaya pengobatan herbal. Dalam situasi ini, sikap terbaik perawat adalah: tidak langsung menolak, tetapi bisa juga mengintegrasikan edukasi medis dengan pendekatan budaya.

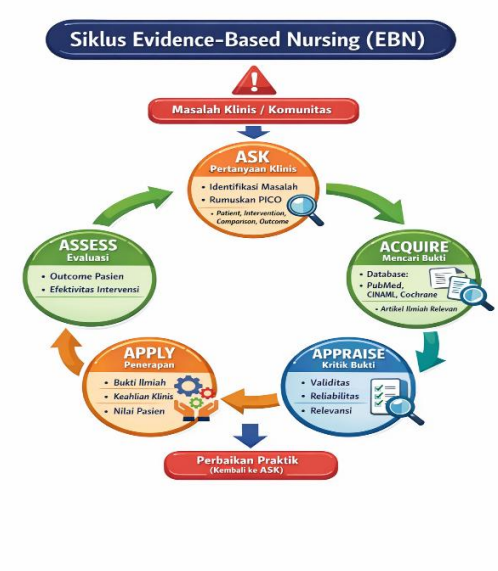
Dari kasus di atas kita menyadari bahwa tanpa mempertimbangkan nilai pasien, maka cenderung akan terjadi kepatuhan rendah, konflik meningkat. Sebaliknya dengan mempertimbangkan nilai pasien, maka kepuasan meningkat dan hasil terapi lebih optimal.

Komponen Evidence-Based Nursing terdiri dari tiga pilar utama, yaitu bukti ilmiah terbaik, keahlian klinis, dan nilai pasien. Ketiga komponen ini saling melengkapi dan harus diintegrasikan secara simultan dalam praktik keperawatan. Berdasarkan pandangan Melnyk, Polit, dan Sackett, keberhasilan implementasi EBN sangat ditentukan oleh kemampuan perawat dalam menyeimbangkan ketiga aspek tersebut. Tanpa integrasi yang baik, praktik keperawatan berisiko menjadi tidak efektif, tidak kontekstual, dan tidak berpusat pada pasien.

3. Siklus Evidence-Based Nursing

Siklus Evidence-Based Nursing (EBN) merupakan suatu proses sistematis yang digunakan oleh perawat dalam pengambilan keputusan klinis berbasis bukti. Menurut Melnyk & Fineout-Overholt (2019) dalam *Evidence-Based Practice in Nursing & Healthcare: A Guide to Best Practice* (Wolters Kluwer, Philadelphia), siklus ini terdiri dari lima tahapan utama, yaitu Ask, Acquire, Appraise, Apply, dan Assess. Kelima tahap ini bersifat dinamis dan

berkelanjutan, artinya setelah evaluasi dilakukan, perawat dapat kembali ke tahap awal untuk melakukan perbaikan praktik secara terus-menerus.



Gambar 1.1: Siklus EBN

a. Ask (Merumuskan Pertanyaan Klinis)

Tahap pertama merupakan fondasi utama dalam EBN, yaitu mengidentifikasi masalah klinis dan merumuskannya menjadi pertanyaan yang terstruktur. Pertanyaan yang baik akan menentukan kualitas proses EBN selanjutnya. Untuk mempermudah, digunakan format **PICO**, yaitu:

1) **P (Patient/Problem)**: siapa pasien atau masalah yang dihadapi
2) **I (Intervention)**: intervensi yang akan diberikan
3) **C (Comparison)**: pembanding (jika ada)
4) **O (Outcome)**: hasil yang diharapkan

Contoh kasus;

Seorang pasien stroke mengalami kelemahan ekstremitas dan berisiko jatuh.

Rumusan PICO:

- P: Pasien stroke dengan risiko jatuh
- I: Balance training
- C: Perawatan standar tanpa latihan
- O: Penurunan risiko jatuh

Pertanyaan klinis:

"Apakah balance training efektif menurunkan risiko jatuh pada pasien stroke dibandingkan perawatan standar?"

Makna Tahap Ini

Tanpa pertanyaan yang jelas, maka pencarian bukti menjadi tidak terarah dan intervensi cenderung tidak tepat

b. Acquire (Mencari Bukti Terbaik)

Setelah pertanyaan dirumuskan, langkah selanjutnya adalah mencari bukti ilmiah yang relevan dan berkualitas tinggi.

Sumber Pencarian

1) PubMed
2) CINAHL
3) Cochrane Library
4) Google Scholar (terbatas, perlu seleksi ketat)

Strategi Pencarian; menggunakan kata kunci dari PICO dan atau menggunakan filter (tahun, jenis penelitian, dll.)

Contoh kasus 1;

Perawat mencari jurnal dan menemukan:

- Systematic review: balance training efektif menurunkan risiko jatuh
- Studi RCT: Tai Chi meningkatkan keseimbangan pasien stroke

Bukti terkumpul untuk dianalisis.

Contoh kasus 2;

Masalah: rendahnya penemuan kasus TBC

Rumusan PICO:

- P: Masyarakat risiko TB
- I: Edukasi e-poster
- O: Peningkatan penemuan suspek

Perawat mencari jurnal, kemudian ditemukan bahwa edukasi digital meningkatkan deteksi dini TB.

c. Appraise (Menilai Kualitas Bukti)

Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa bukti yang ditemukan benar-benar valid dan dapat dipercaya sebelum diterapkan. Adapun aspek yang dinilai adalah:

1) **Validitas** → apakah penelitian dilakukan dengan metode yang benar
2) **Reliabilitas** → apakah hasilnya konsisten
3) **Relevansi** → apakah sesuai dengan kondisi pasien

Contoh kasus;

Perawat membandingkan beberapa jurnal:

- RCT; artikel dengan kualitas tinggi
- Studi deskriptif; kualitas lebih rendah

Dalam hal ini perawat memilih bukti terbaik (systematic review & RCT).

Makna Tahap Ini

Bahwa tanpa appraisal, berdampak pada risiko menggunakan bukti yang salah dan intervensi bisa tidak efektif atau berbahaya

d. Apply (Menerapkan Bukti)

Tahap ini merupakan inti dari praktik EBN, yaitu mengimplementasikan bukti ke dalam praktik keperawatan dengan mempertimbangkan tiga hal, yaitu; Kondisi pasien, Keahlian perawat, dan Nilai pasien

Contoh Kasus 1

Pasien stroke diberikan: latihan keseimbangan, Tai Chi sederhana, dan pendampingan mobilisasi. Dimana pelaksanaanya disesuaikan dengan kondisi pasien (tidak langsung intensif).

Contoh kasus 2

Seorang perawata menjalankan program edukasi TB, menggunakan e-poster dengan pemilihan Bahasa disesuaikan dengan bahasa local, serta melibatkan kader kesehatan

Makna Tahap Ini

Bukti tidak bisa diterapkan secara "mentah", tetapi harus dilakukan secara adaptif, kontekstual, dan berpusat pada pasien

e. Assess (Evaluasi Hasil)

Tahap terakhir adalah mengevaluasi apakah intervensi yang dilakukan memberikan hasil yang diharapkan. Beberapa indikator evaluasi:

- Outcome pasien, Kepuasan pasien
- Penurunan risiko/komplikasi
- Efektivitas intervensi

Contoh Kasus 1

Seorang pasien, umur 56 tahun, menderita stroke, setelah perawatan 2 minggu, didapatkan hasil;

- Pasien lebih stabil saat berjalan
- Tidak terjadi jatuh

Berdasarkan hasil evaluasi, intervensi ini dinilai efektif.

Contoh Kasus 2

Setelah edukasi TB:

- Jumlah suspek meningkat
- Masyarakat lebih sadar TB

Program dinilai berhasil.

Makna Tahap Ini

Jika hasil belum optimal, maka harus kembali ke tahap **Ask,** artinya **s**iklus berulang.

Siklus Evidence-Based Nursing merupakan proses sistematis yang memungkinkan perawat mengambil keputusan klinis secara rasional, terukur, dan berbasis bukti. Setiap tahapan, mulai dari perumusan masalah hingga evaluasi, memiliki peran penting dan saling berkesinambungan. Keberhasilan penerapan EBN sangat ditentukan oleh kemampuan perawat dalam menjalankan setiap tahap secara kritis dan konsisten. Dengan demikian, EBN tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan, tetapi juga menjamin keselamatan pasien serta efektivitas intervensi yang diberikan.

4. Tantangan dan Implementasi EBN

a. Tantangan dan Hambatan

1) Kurangnya kemampuan literasi ilmiah
2) Keterbatasan waktu kerja
3) Akses jurnal terbatas
4) Budaya kerja yang belum berbasis bukti
5) Minimnya dukungan manajemen

b. Strategi Mengatasi Hambatan

1) Pelatihan EBN secara berkala
2) Penyediaan akses jurnal ilmiah
3) Dukungan kebijakan rumah sakit
4) Pembentukan tim EBN
5) Integrasi dalam SOP dan clinical pathway.

5. Peran Perawat dalam Riset dan EBN

Evidence-Based Nursing (EBN) adalah pendekatan praktik keperawatan yang mengintegrasikan: Bukti penelitian terbaik, Keahlian klinis perawat, dan Preferensi pasien. Artinya, perawat tidak hanya "melakukan tindakan", tetapi juga menggunakan hasil riset ilmiah dan menjadi pengambil keputusan klinis berbasis bukti. Berikut adalah beberapa peran perawata dalam riset dan EBN:

a. Perawat sebagai *Consumer of Research* (Pengguna Hasil Riset)

Perawat berperan membaca, memahami, dan menerapkan hasil penelitian dalam raktik. Perawat harus mampu mencari, menilai, dan menggunakan bukti ilmiah dalam praktik klinis (Melnyk & Fineout-Overholt, 2023).

Contoh kasus;

Kasus TB di komunitas, dalam hal ini perawat membaca jurnal tentang edukasi berbasis e-poster meningkatkan kepatuhan pengobatan TB.

kemudian berdasarkan bukti jurnal tersebut, perawata menerapkan edukasi berbasis e-poster dalam program di desa, sehingga meningkatkan kepatuhan minum obat

b. Perawat sebagai *Producer of Research* (Peneliti)

Perawat melakukan penelitian untuk menghasilkan ilmu baru. Perawat berperan dalam mengembangkan praktik melalui penelitian dan evaluasi pelayanan keperawatan (**Rofii, 2022)**.

Bentuk penelitian:

- Penelitian klinis (misal: efektivitas intervensi luka)
- Penelitian komunitas (misal: pencegahan TB)
- Penelitian pendidikan (misal: metode pembelajaran keperawatan)

Contoh kasus

Seorang perawat melakukan sebuah penelitian berjudul "Efektivitas edukasi keluarga terhadap penerimaan TPT pada kontak serumah TB". Hasil penelitian tersebut digunakan untuk program puskesmas

c. Perawat sebagai *Change Agent* (Agen Perubahan)

Perawat mendorong perubahan praktik berdasarkan hasil riset. Perawat adalah agen perubahan dalam sistem kesehatan berbasis populasi

Contoh kasus;

- Praktik sebelumnya: luka dirawat dengan kasa kering
- Setelah riset: menggunakan **moist wound healing**
- Perawat mengubah SOP, sehingga proses penyembuhan lukan lebih cepat.

d. Perawat sebagai *Educator dan Disseminator*

Perawat menyebarkan hasil penelitian kepada: Pasien, Keluarga, dan Tenaga kesehatan lain. **Contoh;** Perawat memberikan edukasi DM berbasis hasil riset terbaru atau Presentasi hasil penelitian di seminar keperawatan.

C. Etika dan Integritas Ilmiah

1. Pendahuluan

Penelitian keperawatan merupakan salah satu pilar penting dalam pengembangan ilmu dan praktik keperawatan yang berbasis bukti (*evidence-based nursing*). Dalam pelaksanaannya, penelitian tidak hanya berorientasi pada pencapaian tujuan ilmiah, tetapi juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, moral, dan profesionalisme. Hal ini menjadi sangat penting karena subjek dalam penelitian keperawatan adalah manusia yang memiliki hak, martabat, dan kebutuhan yang harus dihormati serta dilindungi.

Oleh karena itu, penerapan prinsip etika, integritas ilmiah, dan perlindungan partisipan menjadi landasan utama dalam setiap tahapan penelitian, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan hasil. Tanpa adanya penerapan prinsip-prinsip tersebut, penelitian berpotensi menimbulkan kerugian bagi partisipan serta menurunkan kualitas dan kredibilitas hasil penelitian. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam terhadap prinsip etik dalam penelitian keperawatan merupakan suatu keharusan bagi setiap peneliti agar dapat menghasilkan penelitian yang tidak hanya valid secara ilmiah, tetapi juga bertanggung jawab secara moral dan sosial.

2. Prinsip Etik

a. Respect For Persons (Menghormati Martabat Manusia)

Prinsip *respect for persons* merupakan fondasi utama dalam etika penelitian keperawatan yang menekankan bahwa setiap individu memiliki martabat, nilai intrinsik, dan hak otonomi yang harus dihormati tanpa pengecualian. Menurut Beauchamp dan Childress (2019) dalam *Principles of Biomedical Ethics*, prinsip ini berakar pada konsep otonomi, yaitu kemampuan individu untuk membuat keputusan secara sadar, bebas, dan berdasarkan informasi yang memadai. Dalam konteks penelitian keperawatan, penghormatan terhadap individu menjadi sangat penting karena partisipan sering berada dalam kondisi rentan, seperti sakit, lansia, atau memiliki keterbatasan pengetahuan kesehatan. Oleh karena itu, peneliti tidak hanya dituntut untuk menghormati keputusan partisipan, tetapi juga memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar diambil secara sukarela tanpa adanya tekanan, manipulasi, atau ketergantungan terhadap tenaga kesehatan.

Implementasi nyata dari prinsip ini terlihat dalam proses *informed consent*, yang bukan sekadar dokumen administratif, melainkan suatu proses komunikasi etis yang berkelanjutan antara peneliti dan partisipan. Menurut Polit dan Beck (2018) informed consent harus mencakup penjelasan yang jelas mengenai tujuan penelitian, prosedur, risiko, manfaat, serta hak partisipan untuk menolak atau mengundurkan diri kapan saja tanpa konsekuensi. Dalam praktiknya, sering terjadi penyimpangan di mana informed consent hanya dianggap formalitas, sehingga partisipan menandatangani tanpa benar-benar memahami isi penelitian. Hal ini bertentangan dengan esensi respect for persons, karena penghormatan terhadap individu tidak cukup hanya dengan memberikan

informasi, tetapi juga memastikan pemahaman melalui komunikasi dua arah, misalnya dengan metode *teach-back*.

Selain itu, prinsip ini juga menuntut perlindungan khusus terhadap kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, atau pasien dengan gangguan kognitif. Dalam situasi tersebut, peneliti harus melibatkan wali atau keluarga serta menggunakan pendekatan komunikasi yang sesuai dengan kondisi partisipan. Sebagai contoh, dalam penelitian terapi pencegahan tuberkulosis (TPT) di komunitas, peneliti perlu menjelaskan secara sederhana mengenai efek samping obat, memberikan waktu bagi keluarga untuk berdiskusi, serta menghormati keputusan mereka meskipun bertentangan dengan tujuan program kesehatan. Dengan demikian, respect for persons tidak hanya mencerminkan penghormatan terhadap hak individu, tetapi juga mencerminkan nilai kemanusiaan dalam praktik keperawatan yang menjunjung tinggi empati, advokasi, dan keadilan dalam hubungan antara peneliti dan partisipan.

b. Justice (Keadilan)

Prinsip justice dalam penelitian keperawatan menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi manfaat dan beban penelitian, serta perlakuan yang setara terhadap seluruh partisipan tanpa diskriminasi. Menurut Neuman (2021) dalam *Social Research Methods*, keadilan berarti bahwa tidak ada kelompok tertentu yang dieksploitasi sebagai objek penelitian, sementara kelompok lain menikmati manfaatnya. Prinsip ini memiliki relevansi yang sangat kuat dalam penelitian kesehatan, terutama di negara berkembang, di mana kelompok dengan status sosial ekonomi rendah sering kali menjadi sasaran penelitian karena dianggap lebih mudah diakses.

Secara konseptual, justice mencakup keadilan dalam pemilihan sampel, pelaksanaan penelitian, dan distribusi hasil. Dalam pemilihan sampel, peneliti harus memastikan bahwa kriteria inklusi dan eksklusi didasarkan pada pertimbangan ilmiah, bukan kemudahan atau bias tertentu. Dalam pelaksanaan penelitian, semua partisipan harus mendapatkan perlakuan yang sama, termasuk dalam pemberian informasi, intervensi, dan perlindungan. Sedangkan dalam distribusi hasil, manfaat penelitian seharusnya dapat dirasakan oleh kelompok yang berpartisipasi, bukan hanya oleh peneliti atau institusi.

Dalam praktiknya, pelanggaran prinsip justice dapat terjadi dalam bentuk *sampling bias*, di mana peneliti hanya memilih responden yang

kooperatif atau mudah dijangkau, sehingga hasil penelitian tidak representatif. Contoh lainnya adalah eksploitasi kelompok rentan, seperti masyarakat miskin atau pasien dengan keterbatasan akses layanan kesehatan, yang dijadikan objek penelitian tanpa mendapatkan manfaat yang setara. Oleh karena itu, prinsip justice menuntut adanya keseimbangan antara risiko yang ditanggung partisipan dan manfaat yang mereka peroleh.

Dalam penelitian keperawatan, penerapan prinsip ini dapat dilihat pada upaya untuk melibatkan berbagai kelompok populasi secara proporsional, termasuk laki-laki, perempuan, lansia, dan kelompok marginal. Selain itu, hasil penelitian sebaiknya digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi kelompok yang diteliti, sehingga tercipta keadilan sosial dalam praktik kesehatan. Dengan demikian, justice bukan hanya tentang kesetaraan, tetapi juga tentang tanggung jawab moral peneliti untuk memastikan bahwa penelitian memberikan kontribusi yang adil bagi masyarakat.

c. Beneficence Dan Non-Maleficence (Manfaat Dan Tidak Merugikan)

Prinsip *beneficence* dan *non-maleficence* merupakan inti tanggung jawab moral peneliti dalam memastikan bahwa penelitian memberikan manfaat maksimal dan meminimalkan risiko bagi partisipan. Prinsip ini ditegaskan dalam *The Belmont Report* (National Commission, 1979) sebagai dasar perlindungan subjek penelitian. Selain itu, Principles of Biomedical Ethics menjelaskan bahwa *beneficence* mengacu pada kewajiban melakukan kebaikan dengan memaksimalkan manfaat, sedangkan *non-maleficence* menekankan kewajiban untuk menghindari atau meminimalkan bahaya dalam praktik kesehatan dan penelitian..

Secara mendalam, penerapan prinsip ini menuntut adanya analisis *risk-benefit ratio*, yaitu perbandingan antara potensi risiko dan manfaat yang mungkin diperoleh dari penelitian. Penelitian dikatakan etis apabila manfaat yang dihasilkan lebih besar dibandingkan risiko yang mungkin terjadi, dan risiko tersebut telah diminimalkan semaksimal mungkin. Risiko dalam penelitian keperawatan tidak hanya terbatas pada efek fisik, tetapi juga mencakup dampak psikologis seperti kecemasan, stres, atau bahkan stigma sosial, terutama pada penyakit seperti tuberkulosis atau HIV. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki sensitivitas etik yang tinggi untuk mengidentifikasi risiko yang tidak tampak secara langsung.

Dalam praktik nyata, prinsip ini dapat dilihat pada penelitian keperawatan komunitas yang menggunakan intervensi edukasi sebagai pendekatan utama, karena memiliki risiko minimal namun manfaat yang signifikan dalam meningkatkan pengetahuan dan perilaku kesehatan. Sebaliknya, pelanggaran terhadap prinsip ini dapat terjadi ketika peneliti mengabaikan potensi dampak psikologis atau sosial, misalnya dengan membuka identitas pasien TB yang dapat menimbulkan stigma di masyarakat. Oleh karena itu, setiap penelitian harus melalui proses *ethical clearance* untuk memastikan bahwa desain penelitian telah mempertimbangkan aspek keamanan partisipan secara komprehensif.

Lebih jauh, prinsip beneficence dan non-maleficence juga menuntut adanya monitoring selama penelitian berlangsung, sehingga jika muncul risiko yang tidak terduga, peneliti dapat segera mengambil tindakan untuk melindungi partisipan. Dalam konteks keperawatan, hal ini sejalan dengan nilai profesional perawat yang berfokus pada keselamatan pasien (*patient safety*). Dengan demikian, prinsip ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman etis, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan yang memastikan bahwa penelitian benar-benar memberikan kontribusi positif tanpa mengorbankan kesejahteraan manusia.

d. Confidentiality Dan Privacy (Kerahasiaan Dan Privasi)

Prinsip confidentiality dan privacy merupakan aspek penting dalam etika penelitian keperawatan yang berkaitan dengan perlindungan informasi pribadi partisipan. Menurut Polit dan Beck (2019), privacy mengacu pada hak individu untuk mengontrol informasi pribadi mereka, sedangkan confidentiality merupakan kewajiban peneliti untuk menjaga kerahasiaan informasi yang telah diberikan oleh partisipan. Dalam penelitian kesehatan, data yang dikumpulkan sering kali bersifat sensitif, seperti kondisi penyakit, status sosial, dan riwayat kesehatan, sehingga pelanggaran terhadap prinsip ini dapat menimbulkan dampak serius, baik secara psikologis maupun sosial.

Dalam era digital, tantangan dalam menjaga kerahasiaan semakin kompleks karena data penelitian sering disimpan dalam bentuk elektronik yang rentan terhadap kebocoran. Oleh karena itu, peneliti harus menerapkan langkah-langkah keamanan seperti penggunaan kode identitas (coding), penyimpanan data dengan password, serta pembatasan akses hanya kepada pihak yang berwenang. Selain itu, peneliti juga harus

memastikan bahwa data yang dipublikasikan tidak dapat mengidentifikasi partisipan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pelanggaran terhadap confidentiality dapat menimbulkan konsekuensi serius, seperti stigma sosial, diskriminasi, dan kehilangan kepercayaan terhadap tenaga kesehatan. Misalnya, dalam penelitian tentang HIV atau tuberkulosis, pengungkapan identitas partisipan dapat menyebabkan mereka dikucilkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki kesadaran etik yang tinggi untuk menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh partisipan.

Dalam praktik keperawatan, prinsip ini sejalan dengan kode etik profesi yang menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan pasien. Peneliti tidak hanya bertanggung jawab secara ilmiah, tetapi juga secara moral untuk melindungi informasi yang diperoleh. Dengan demikian, confidentiality dan privacy merupakan bentuk penghormatan terhadap hak individu sekaligus upaya untuk menjaga integritas hubungan antara peneliti dan partisipan.

e. Veracity Dan Integritas Ilmiah (Kejujuran Ilmiah)

Prinsip veracity dan integritas ilmiah merupakan landasan utama dalam menjaga kredibilitas dan kepercayaan terhadap hasil penelitian keperawatan. Veracity mengacu pada komitmen untuk mengatakan kebenaran, sedangkan integritas ilmiah mencerminkan konsistensi antara nilai moral dan praktik penelitian. Menurut Creswell (2018), integritas ilmiah mencakup kejujuran, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam seluruh proses penelitian, mulai dari perencanaan hingga publikasi.

Dalam praktiknya, pelanggaran terhadap prinsip ini dapat terjadi dalam bentuk fabrikasi data (membuat data palsu), falsifikasi (memanipulasi data), dan plagiarisme (mengambil karya orang lain tanpa atribusi). Pelanggaran ini tidak hanya merusak reputasi peneliti, tetapi juga dapat berdampak luas terhadap kebijakan kesehatan yang didasarkan pada hasil penelitian tersebut. Misalnya, jika data penelitian tentang efektivitas suatu intervensi dimanipulasi, maka keputusan klinis yang diambil berdasarkan data tersebut dapat merugikan pasien.

Tekanan untuk publikasi sering menjadi faktor yang mendorong terjadinya pelanggaran integritas ilmiah, terutama dalam lingkungan akademik. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki komitmen moral yang kuat untuk tetap jujur, meskipun hasil penelitian tidak sesuai dengan harapan atau hipotesis. Dalam konteks ini, melaporkan hasil yang tidak

signifikan tetap merupakan bentuk integritas ilmiah, karena memberikan gambaran yang objektif tentang realitas.

Dalam penelitian keperawatan, integritas ilmiah juga mencakup transparansi dalam metode penelitian, termasuk pelaporan keterbatasan studi dan potensi bias. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat dievaluasi secara kritis oleh komunitas ilmiah. Selain itu, penggunaan teknologi seperti perangkat lunak anti-plagiarisme dan sistem *peer review* dapat membantu menjaga kualitas dan kejujuran penelitian.

Dengan demikian, veracity dan integritas ilmiah tidak hanya merupakan kewajiban profesional, tetapi juga merupakan tanggung jawab moral peneliti terhadap masyarakat dan ilmu pengetahuan. Tanpa integritas, penelitian kehilangan makna dan tidak dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan dalam praktik keperawatan.

3. Perlindungan Partisipan Penelitian

Perlindungan partisipan dalam penelitian keperawatan merupakan aspek fundamental yang tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral, profesional, dan ilmiah seorang peneliti dalam menjaga hak, keselamatan, dan martabat manusia sebagai subjek penelitian. Dalam konteks ilmu keperawatan, partisipan bukan sekadar sumber data, melainkan individu yang memiliki nilai kemanusiaan, pengalaman hidup, serta kerentanan tertentu yang harus dihormati secara utuh. Oleh karena itu, perlindungan partisipan menjadi inti dari seluruh proses penelitian, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga diseminasi hasil penelitian.

Menurut Polit & Beck (2018), perlindungan partisipan mencakup upaya sistematis untuk menjamin hak individu seperti hak menentukan pilihan (*self-determination*), hak atas privasi, hak untuk bebas dari bahaya, serta hak atas informasi yang jelas sebelum berpartisipasi. Penelitian yang melibatkan manusia harus menjunjung tinggi tiga prinsip utama, yaitu *respect for persons, beneficence,* dan *justice*, yang secara keseluruhan bertujuan untuk melindungi partisipan dari eksploitasi dan risiko yang tidak perlu. Dalam implementasinya, perlindungan partisipan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual, artinya peneliti harus mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan psikologis partisipan selama penelitian berlangsung.

Salah satu aspek utama dalam perlindungan partisipan adalah *informed consent*, yaitu proses pemberian informasi yang lengkap, jujur, dan dapat

dipahami oleh calon partisipan sebelum mereka memutuskan untuk ikut serta dalam penelitian. Informed consent bukan sekadar dokumen administratif, melainkan proses komunikasi etis yang memastikan bahwa partisipan memahami tujuan penelitian, prosedur yang akan dilakukan, potensi risiko dan manfaat, serta hak mereka untuk menolak atau mengundurkan diri kapan saja tanpa konsekuensi negatif. Dalam praktik keperawatan, hal ini sangat penting karena hubungan antara perawat dan pasien seringkali bersifat hierarkis, sehingga ada risiko partisipan merasa "tidak enak menolak". Oleh karena itu, peneliti harus memastikan bahwa keputusan partisipan benar-benar bersifat sukarela. Sebagai contoh riil, dalam penelitian tentang Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT), peneliti harus menjelaskan secara rinci kemungkinan efek samping obat kepada keluarga pasien, memberikan waktu untuk mempertimbangkan, serta menegaskan bahwa penolakan tidak akan mempengaruhi pelayanan kesehatan yang diterima.

Selain informed consent, perlindungan partisipan juga mencakup perlindungan dari bahaya (protection from harm), baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi. Menurut Polit & Beck (2003), partisipan memiliki hak untuk bebas dari ketidaknyamanan dan eksploitasi, sehingga peneliti wajib meminimalkan segala bentuk risiko yang mungkin timbul selama penelitian. Dalam penelitian keperawatan, risiko tidak selalu bersifat fisik; seringkali risiko psikologis seperti stres, kecemasan, atau munculnya kembali trauma justru lebih dominan, terutama dalam penelitian kualitatif yang menggali pengalaman mendalam partisipan. Sebagai contoh, dalam penelitian tentang pengalaman pasien kanker stadium lanjut, wawancara mendalam dapat memunculkan emosi yang kuat seperti kesedihan atau ketakutan terhadap kematian. Dalam situasi ini, peneliti harus memiliki sensitivitas klinis, mampu menghentikan wawancara jika partisipan merasa tidak nyaman, serta menyediakan dukungan emosional atau rujukan profesional jika diperlukan.

Aspek penting lainnya adalah kerahasiaan (*confidentiality*) dan anonimitas (anonymity). Dalam penelitian keperawatan, data yang dikumpulkan seringkali bersifat sangat sensitif, seperti status penyakit, kondisi psikologis, atau masalah keluarga. Oleh karena itu, peneliti memiliki kewajiban etis untuk menjaga kerahasiaan identitas partisipan dan memastikan bahwa informasi yang diperoleh tidak disalahgunakan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengganti nama partisipan dengan kode, menyimpan data dalam sistem yang aman, serta membatasi akses hanya kepada pihak yang berwenang. Jika prinsip ini dilanggar, konsekuensinya

tidak hanya merugikan partisipan secara pribadi, tetapi juga dapat menimbulkan stigma sosial, diskriminasi, bahkan masalah hukum. Sebagai contoh riil, dalam penelitian HIV/AIDS, pengungkapan identitas partisipan dapat menyebabkan stigma sosial yang berat, sehingga perlindungan data menjadi sangat krusial.

Perlindungan partisipan juga mencakup hak untuk mengundurkan diri (right to withdraw) tanpa tekanan atau konsekuensi negatif. Prinsip ini merupakan bentuk nyata penghormatan terhadap otonomi individu. Dalam praktiknya, peneliti harus secara eksplisit menyampaikan bahwa partisipan dapat berhenti kapan saja, bahkan setelah memberikan persetujuan awal. Hal ini penting untuk mencegah adanya coercion atau tekanan terselubung, terutama dalam setting pelayanan kesehatan di mana pasien mungkin merasa bergantung pada tenaga kesehatan. Contoh riil dapat dilihat pada penelitian lansia dengan diabetes mellitus, di mana partisipan diberikan kebebasan untuk berhenti mengikuti sesi edukasi jika merasa lelah atau tidak nyaman, tanpa mempengaruhi pelayanan yang mereka terima di puskesmas.

Lebih lanjut, perlindungan partisipan juga harus memperhatikan kelompok rentan (vulnerable groups) seperti lansia, anak-anak, pasien dengan gangguan mental, atau pasien terminal. Kelompok ini memiliki keterbatasan dalam kemampuan mengambil keputusan atau mempertahankan haknya, sehingga memerlukan perlindungan tambahan. Menurut Emanuel et al. (2000), penelitian yang melibatkan kelompok rentan harus memenuhi standar etika yang lebih ketat, termasuk adanya persetujuan dari wali, penilaian risiko yang lebih cermat, serta justifikasi ilmiah yang kuat mengapa kelompok tersebut harus dilibatkan. Dalam penelitian keperawatan komunitas, misalnya pada lansia dengan penurunan kognitif, peneliti tidak hanya meminta persetujuan dari partisipan, tetapi juga dari anggota keluarga sebagai caregiver.

Secara keseluruhan, perlindungan partisipan dalam penelitian keperawatan merupakan proses yang dinamis dan berkelanjutan, bukan hanya langkah administratif di awal penelitian. Peneliti harus terus melakukan refleksi etik sepanjang proses penelitian untuk memastikan bahwa hak dan kesejahteraan partisipan tetap terjaga. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa penelitian keperawatan tidak hanya bertujuan menghasilkan pengetahuan, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata tanpa mengorbankan nilai kemanusiaan. Dengan demikian, perlindungan partisipan menjadi indikator utama kualitas etika dan integritas suatu penelitian.

4. Keselamatan Partisipan

a. Konsep Dasar Keselamatan Partisipan

Keselamatan partisipan merupakan prinsip fundamental dalam penelitian keperawatan yang menekankan bahwa setiap individu yang terlibat sebagai subjek penelitian harus dilindungi dari segala bentuk risiko, baik fisik, psikologis, sosial, maupun hukum selama proses penelitian berlangsung. Dalam perspektif etik penelitian kesehatan, keselamatan partisipan bukan hanya sekadar upaya menghindari cedera, tetapi merupakan bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia dan martabat individu sebagai subjek yang memiliki nilai intrinsik. Menurut Polit dan Hungler (1999) yang kemudian diperkuat oleh Polit dan Beck serta diperbarui dalam edisi terbaru oleh Flanagan dan Beck (2024), penelitian keperawatan wajib memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu melalui prinsip self-determination, anonymity, confidentiality, dan protection from harm, yang semuanya bermuara pada jaminan keselamatan partisipan selama penelitian berlangsung (Flanagan & Beck, 2024). Dalam praktiknya, keselamatan partisipan mencakup berbagai dimensi yang kompleks, karena penelitian keperawatan seringkali melibatkan individu yang berada dalam kondisi rentan, seperti pasien dengan penyakit kronis, lansia, atau pasien terminal. Oleh karena itu, keselamatan partisipan tidak dapat dipahami hanya sebagai pencegahan cedera fisik, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap dampak psikologis seperti kecemasan, stres, atau stigma sosial yang mungkin timbul akibat keterlibatan dalam penelitian. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa etika penelitian harus memastikan bahwa penelitian "tidak merugikan partisipan dan justru memberikan manfaat yang seimbang" sebagaimana ditegaskan dalam metodologi penelitian keperawatan modern.

Lebih lanjut, keselamatan partisipan juga berkaitan erat dengan konsep manajemen risiko dalam penelitian. Setiap penelitian harus melalui proses ethical clearance yang bertujuan untuk menilai apakah risiko yang mungkin timbul telah diminimalkan dan sebanding dengan manfaat yang diharapkan. Dalam hal ini, keselamatan partisipan menjadi indikator utama apakah suatu penelitian layak dilakukan atau tidak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keselamatan partisipan merupakan inti dari seluruh prinsip etik penelitian, karena tanpa jaminan keselamatan, penelitian tidak hanya menjadi tidak etis tetapi juga kehilangan legitimasi ilmiahnya.

b. Dimensi Keselamatan Partisipan (Fisik, Psikologis, Sosial, Dan Hukum)

Keselamatan partisipan dalam penelitian keperawatan memiliki dimensi yang luas dan multidimensional, meliputi aspek fisik, psikologis, sosial, dan hukum yang semuanya harus diperhatikan secara komprehensif oleh peneliti. Secara fisik, keselamatan partisipan berkaitan dengan upaya untuk mencegah terjadinya cedera atau efek samping akibat intervensi penelitian. Misalnya, dalam penelitian intervensi keperawatan seperti pemberian terapi atau latihan fisik, peneliti harus memastikan bahwa intervensi tersebut tidak menimbulkan risiko yang lebih besar dibandingkan manfaat yang diharapkan. Prinsip ini sejalan dengan konsep patient safety yang menekankan pencegahan insiden yang dapat menyebabkan cedera atau komplikasi pada individu.

Namun, keselamatan partisipan tidak berhenti pada aspek fisik saja. Aspek psikologis juga menjadi perhatian penting, terutama dalam penelitian yang melibatkan wawancara mendalam atau pengungkapan pengalaman pribadi, seperti pada pasien dengan penyakit kronis atau trauma. Penelitian menunjukkan bahwa partisipan dapat mengalami tekanan emosional atau gangguan psikologis selama proses penelitian, terutama ketika harus mengingat pengalaman yang tidak menyenangkan. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki keterampilan komunikasi terapeutik serta strategi untuk mengurangi distress psikologis, seperti memberikan waktu istirahat, menghentikan wawancara jika diperlukan, atau merujuk ke tenaga profesional.

Dimensi sosial juga tidak kalah penting, terutama dalam konteks penyakit yang memiliki stigma tinggi seperti tuberkulosis atau HIV/AIDS. Partisipasi dalam penelitian dapat menyebabkan individu mengalami diskriminasi atau penurunan status sosial jika identitasnya terbuka. Oleh karena itu, perlindungan terhadap kerahasiaan data menjadi bagian integral dari keselamatan partisipan. Selain itu, aspek hukum juga harus diperhatikan, karena partisipan memiliki hak yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, termasuk hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk menolak, dan hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan yang merugikan.

Dengan demikian, keselamatan partisipan harus dipahami sebagai konsep holistik yang mencakup seluruh aspek kehidupan individu, bukan hanya sekadar bebas dari cedera fisik. Peneliti keperawatan dituntut

untuk memiliki sensitivitas etik yang tinggi dalam mengidentifikasi dan mengelola berbagai potensi risiko ini.

c. Implementasi Keselamatan Partisipan Dalam Proses Penelitian

Implementasi keselamatan partisipan dalam penelitian keperawatan dimulai sejak tahap perencanaan hingga tahap pelaporan hasil penelitian, yang semuanya harus dirancang dengan mempertimbangkan prinsip perlindungan partisipan secara maksimal. Pada tahap awal, peneliti harus melakukan analisis risiko secara sistematis untuk mengidentifikasi potensi bahaya yang mungkin timbul selama penelitian. Analisis ini kemudian menjadi dasar dalam menyusun prosedur penelitian yang aman, termasuk pemilihan metode, instrumen, dan teknik pengumpulan data yang minim risiko.

Selanjutnya, keselamatan partisipan diwujudkan melalui proses informed consent, yaitu pemberian informasi yang lengkap dan jujur kepada calon partisipan mengenai tujuan, prosedur, manfaat, dan risiko penelitian. Persetujuan ini harus diberikan secara sukarela tanpa adanya tekanan atau paksaan, dan partisipan memiliki hak penuh untuk mengundurkan diri kapan saja tanpa konsekuensi negatif. Proses ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan bentuk komunikasi etik yang memastikan bahwa partisipan benar-benar memahami keterlibatannya dalam penelitian.

Selama pelaksanaan penelitian, peneliti harus melakukan monitoring secara terus-menerus terhadap kondisi partisipan untuk memastikan tidak terjadi efek samping atau dampak negatif yang tidak diinginkan. Jika ditemukan risiko yang meningkat, peneliti wajib menghentikan atau memodifikasi penelitian demi keselamatan partisipan. Selain itu, peneliti juga harus menjaga kerahasiaan data dengan menggunakan kode atau inisial serta menyimpan data secara aman agar tidak disalahgunakan.

Pada tahap akhir, keselamatan partisipan juga mencakup tanggung jawab peneliti dalam melaporkan hasil penelitian secara jujur tanpa merugikan partisipan. Misalnya, dalam publikasi hasil penelitian, identitas partisipan harus tetap dirahasiakan dan tidak boleh ada informasi yang dapat mengarah pada identifikasi individu. Dengan demikian, implementasi keselamatan partisipan merupakan proses berkelanjutan yang harus dijaga pada setiap tahap penelitian.

Contoh kasus;

Dalam praktik nyata, penerapan keselamatan partisipan dapat dilihat pada berbagai penelitian keperawatan, misalnya pada penelitian tentang pasien tuberkulosis di komunitas. Dalam penelitian ini, peneliti tidak hanya fokus pada pengumpulan data mengenai kepatuhan pengobatan, tetapi juga memastikan bahwa identitas pasien dirahasiakan untuk menghindari stigma sosial yang masih tinggi di masyarakat. Peneliti menggunakan kode khusus untuk setiap partisipan dan tidak mencantumkan alamat atau informasi yang dapat mengungkap identitas mereka.

Contoh lain dapat dilihat pada penelitian lansia dengan diabetes mellitus, di mana peneliti memberikan intervensi berupa edukasi kesehatan. Dalam penelitian ini, keselamatan partisipan dijaga dengan memastikan bahwa materi edukasi tidak menimbulkan kebingungan atau kecemasan, serta dilakukan pemantauan kondisi kesehatan selama penelitian berlangsung. Jika ditemukan adanya kelelahan atau penurunan kondisi, intervensi dihentikan sementara demi keselamatan partisipan.

Pada penelitian kualitatif yang melibatkan pengalaman emosional, seperti pasien paliatif, peneliti juga harus memperhatikan kondisi psikologis partisipan. Wawancara dilakukan secara empatik dan fleksibel, serta memberikan kesempatan kepada partisipan untuk berhenti kapan saja jika merasa tidak nyaman. Hal ini menunjukkan bahwa keselamatan partisipan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memerlukan sensitivitas interpersonal dari peneliti.

D. Rangkuman Materi

Riset keperawatan dan *Evidence-Based Nursing* (EBN) pada hakikatnya bukan sekadar instrumen metodologis dalam menghasilkan dan menerapkan pengetahuan, melainkan merupakan refleksi dari upaya ilmiah dan moral profesi keperawatan dalam memahami serta merespons kompleksitas pengalaman manusia dalam konteks kesehatan. Keperawatan, sebagai disiplin ilmu sekaligus praktik profesional, tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab epistemologis untuk menghasilkan pengetahuan yang valid, sekaligus tanggung jawab etik untuk memastikan bahwa pengetahuan tersebut digunakan secara bermakna dan berkeadilan.

Perkembangan EBN menandai pergeseran paradigma dari praktik berbasis pengalaman menuju praktik berbasis bukti yang mengintegrasikan hasil penelitian terbaik, keahlian klinis, serta nilai dan preferensi pasien. Namun,

dominasi pendekatan berbasis bukti juga memerlukan sikap kritis agar tidak mereduksi manusia menjadi sekadar objek data yang terlepas dari konteks sosial, budaya, dan eksistensialnya. Oleh karena itu, EBN harus dipahami sebagai pendekatan integratif yang tidak hanya menekankan validitas ilmiah, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Dalam kerangka tersebut, riset keperawatan berfungsi sebagai jembatan antara teori dan praktik, sekaligus sebagai ruang reflektif untuk menguji, mengembangkan, dan mentransformasikan pengetahuan ke dalam tindakan nyata yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup individu dan masyarakat. Proses penelitian yang sistematis bukan sekadar prosedur teknis, melainkan suatu siklus intelektual yang menuntut kemampuan berpikir kritis, analitis, dan transformatif. Dengan demikian, kualitas riset tidak hanya ditentukan oleh kekuatan metodologinya, tetapi juga oleh relevansi sosial dan integritas moral yang melandasinya.

Dimensi etika dan integritas ilmiah menjadi fondasi yang memastikan bahwa penelitian keperawatan tidak kehilangan arah kemanusiaannya. Prinsip-prinsip seperti penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan, kejujuran, serta tanggung jawab ilmiah menegaskan bahwa ilmu pengetahuan tidak bersifat netral, melainkan selalu memiliki implikasi moral. Dalam konteks ini, keselamatan dan perlindungan partisipan merupakan manifestasi konkret dari komitmen etik tersebut, di mana partisipan diposisikan sebagai subjek yang memiliki hak, otonomi, dan kerentanan yang harus dijaga secara utuh.

Lebih jauh, integrasi antara riset keperawatan dan EBN menempatkan perawat sebagai agen perubahan yang tidak hanya mengimplementasikan bukti ilmiah, tetapi juga berperan dalam menghasilkan, mengkritisi, dan mentransformasikan pengetahuan dalam praktik. Perawat dituntut untuk mampu menyeimbangkan antara rasionalitas ilmiah dan sensitivitas etik, antara objektivitas dan empati, serta antara efisiensi pelayanan dan keadilan sosial.

Dengan demikian, esensi dari riset keperawatan dan EBN terletak pada upaya menyatukan ilmu dan nilai dalam suatu praktik yang reflektif, kritis, dan transformatif. Tantangan utama bukan hanya pada penguasaan metode atau akses terhadap bukti, tetapi pada kemampuan menjaga keseimbangan antara dimensi ilmiah dan kemanusiaan. Dalam keseimbangan inilah keperawatan menemukan maknanya yang paling mendalam, sebagai profesi yang tidak hanya berorientasi pada penyembuhan, tetapi juga pada pemanusiaan manusia secara utuh.

E. Daftar Pustaka

Abbas Tashakkori & Charles Teddlie. 2010. *SAGE Handbook of Mixed Methods in Social & Behavioral Research (2nd Edition)*. SAGE Publications. Thousand Oaks, California.

Burns, Nancy, & Grove, Susan K. (2019). *Understanding Nursing Research: Building an Evidence-Based Practice* (7th ed.) St. Louis: Elsevier.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Sage Publications, New York.

Cheryl N. Poth. 2018. *Innovations in Mixed Methods Research: Integrating Qualitative and Quantitative Approaches*. SAGE Publications. Thousand Oaks, California.

Denise F. Polit & Cheryl Tatano Beck. 2021. *Nursing Research: Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice (11th Edition)*. Wolters Kluwer. Philadelphia.

Flanagan, Jane M., & Beck, Cheryl Tatano.2024. *Polit & Beck's Nursing Research: Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice* (12th ed.). Wolters Kluwer, Philadelphia.

Flanagan, Jane M., & Beck, Cheryl Tatano. (2026). *Polit & Beck's Essentials of Nursing Research: Appraising Evidence for Nursing Practice* (11th ed.). Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia.

Jennifer C. Greene. 2007. *Mixed Methods in Social Inquiry*. Jossey-Bass. San Francisco.

John W. Creswell & J. David Creswell. 2023. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (6th Edition)*. SAGE Publications. Thousand Oaks, California.

Kementerian Kesehatan RI (2022). Pedoman Nasional Etik Penelitian Kesehatan Kemenkes RI, Jakarta

Kerlinger, F. N., & Lee, H. B. (2000). *Foundations of Behavioral Research* (4th ed.). Harcourt College Publishers, Fort Worth.

LoBiondo-Wood, Geri, & Haber, Judith. (2025). *Nursing Research: Methods and Critical Appraisal for Evidence-Based Practice* (11th ed.). St. Louis: Elsevier.

Melnyk, B. M., & Fineout-Overholt, E. (2023). *Evidence-Based Practice in Nursing & Healthcare: A Guide to Best Practice (5th Edition).*Wolters Kluwer. Philadelphia

Nancy Burns & Susan K. Grove. 2021. *Understanding Nursing Research: Building an Evidence-Based Practice (7th Edition)*. Elsevier. St. Louis.

Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln. 2018. *The SAGE Handbook of Qualitative Research (5th Edition)*. SAGE Publications. Thousand Oaks, California.

Neuman, W. Lawrence. (2021). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (8th Edition). Pearson Education Limited. Harlow, United Kingdom

Nursalam. (2020). *Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan*. Salemba Medika, Jakarta.

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2019). *Nursing Research: Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice* (11th ed.). Wolters Kluwer, Philadelphia.

Polit, Denise F., & Beck, Cheryl Tatano. (2021). *Nursing Research: Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice* (11th ed.).Philadelphia: Wolters Kluwer (Lippincott Williams & Wilkins).

Patricia L. Munhall. 2019. *Nursing Research: A Qualitative Perspective (6th Edition)*. Jones & Bartlett Learning. Burlington, Massachusetts.

Patricia E. Benner (2001). *From Novice to Expert: Excellence and Power in Clinical Nursing Practice* Prentice Hall. New Jersey

Polit, Denise F., & Beck, Cheryl Tatano. (2019). *Resource Manual for Nursing Research: Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice.*Lippincott Williams & Wilkins. Philadelphia.

Polit, Denise F., & Beck, Cheryl Tatano. (2021). *Nursing Research: Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice* (11th ed.). Wolters Kluwer, Philadelphia.

Rofii, M. (2022). *Manajemen Asuhan Keperawatan*. Semarang: Undip Press.

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung.

BAB 2

MENEMUKAN MASALAH DAN MERUMUSKAN PERTANYAAN PENELITIAN

Identitas Bab

- **Mata kuliah:** Riset Keperawatan dan *Evidence-Based Nursing* (EBN)
- **Bab/Modul:** 2
- **CPMK terkait:** CPMK-2 (Merumuskan masalah, tujuan, dan pertanyaan penelitian/EBN yang fokus, terukur, dan *feasible*).
- **CPL terkait:** CPL-2 (Mampu mengidentifikasi masalah keperawatan dan merumuskan pertanyaan penelitian).

Capaian Pembelajaran Bab (Sub-CPMK)

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa mampu:

- **(S2.1)** Mengidentifikasi *gap* praktik atau masalah prioritas dan menyusun latar belakang berbasis data awal.
- **(S2.2)** Merumuskan pertanyaan penelitian/EBN (mis. PICOT/SPIDER) dan tujuan yang terukur.

Indikator Ketercapaian

- Ketepatan struktur pertanyaan (komponen lengkap).
- Keterukuran tujuan/outcome dan kelayakan (*feasibility*) (skor rubrik ≥ 3/4).

Peta Konsep Bab

Fenomena Klinis Identifikasi *Gap* (Harapan vs Kenyataan) Analisis Masalah Spesifik Per Area Keperawatan Rumusan Masalah Pertanyaan Penelitian (PICOT/SPIDER) Penetapan Tujuan (SMART).

Kata Kunci

Masalah Penelitian, *Gap Analysis*, PICOT, SPIDER, Tujuan Penelitian, Area Keperawatan.

Pendahuluan

Tahap awal yang paling menentukan dalam sebuah riset adalah menemukan masalah. Masalah penelitian bukan sekadar "pertanyaan", melainkan adanya kesenjangan (*gap*) antara apa yang seharusnya terjadi berdasarkan teori atau standar prosedur operasional (SOP) dengan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan (Polit & Beck, 2022). Dalam keperawatan, masalah riset harus memiliki relevansi klinis yang bertujuan meningkatkan kualitas asuhan, keselamatan pasien, atau efisiensi layanan.

Proses memilih dan mendefinisikan masalah penelitian diawali dengan identifikasi berbagai masalah potensial, kemudian berlanjut hingga dirumuskan menjadi pertanyaan penelitian atau hipotesis yang jelas. Proses ini tidak terlepas dari kegiatan penelusuran literatur secara komprehensif serta analisis kritis terhadap berbagai sumber ilmiah.

Masalah penelitian yang telah diidentifikasi selanjutnya perlu disempurnakan agar layak untuk diteliti secara empiris. Proses penyempurnaan ini membutuhkan waktu, ketelitian, serta kemampuan berpikir kritis dari peneliti.

Bab ini akan membahas secara mendalam mengenai cara merumuskan dan mengevaluasi pernyataan masalah, serta langkah-langkah dalam melakukan tinjauan literatur sebagai dasar pengembangan penelitian.

Uraian Materi

A. Pengertian Masalah Penelitian dalam Keperawatan

Masalah penelitian keperawatan adalah suatu kondisi atau situasi yang membutuhkan solusi, perbaikan, atau pemahaman yang lebih dalam melalui metode ilmiah (Gray & Grove, 2021). Menurut penelitian oleh Smith et al. (2023), masalah penelitian yang berkualitas adalah masalah yang memiliki nilai *Significance* (penting), *Researchability* (dapat diteliti), dan *Feasibility* (mungkin dilakukan).

B. Masalah Penelitian dan Sumbernya di Berbagai Area Keperawatan

Menentukan masalah penelitian sering kali menjadi tahap yang menantang, terutama bagi peneliti pemula. Kesulitan yang muncul bukan karena kurangnya masalah, melainkan karena banyaknya pilihan yang tersedia sehingga diperlukan kemampuan untuk memilih masalah yang relevan dan dapat diteliti. Menurut Fein (2017) dan Nieswiadomy & Bailey (2018), langkah awal dalam memilih masalah penelitian adalah mengidentifikasi area masalah umum yang sesuai dengan bidang keahlian atau minat peneliti. Area ini menjadi titik awal untuk mengembangkan topik penelitian yang lebih spesifik.

1. **Keperawatan Dasar & Manajemen**
   a. **Masalah:** Ketidakpatuhan perawat terhadap protokol *hand hygiene* yang menyebabkan peningkatan infeksi nosokomial.
   b. **Sumber:** Laporan insiden infeksi di RS, observasi kepatuhan staf, dan evaluasi kepemimpinan kepala ruang.
2. **Keperawatan Medikal Bedah (KMB)**
   a. **Masalah:** Tingginya angka kejadian luka tekan (*pressure injury*) pada pasien tirah baring lama meskipun sudah dilakukan alih baring setiap 2 jam.
   b. **Sumber:** Rekam medis pasien, tren data *patient safety*, dan literatur terbaru mengenai efektivitas jenis alas tidur tertentu.
3. **Keperawatan Maternitas**
   a. **Masalah:** Rendahnya efikasi diri ibu primipara dalam melakukan inisiasi menyusui dini (IMD) karena nyeri pasca-caesar.
   b. **Sumber:** Wawancara dengan ibu nifas dan data cakupan ASI eksklusif di rumah sakit.
4. **Keperawatan Anak**
   a. **Masalah:** Kecemasan hospitalisasi yang ekstrem pada anak usia prasekolah saat prosedur pemasangan infus.

b. **Sumber:** Observasi perilaku anak (menangis, agresif) dan kuesioner skala cemas anak.

5. Gadar & Kritis

a. **Masalah:** Penundaan waktu (*door-to-needle time*) pada pasien STEMI di IGD yang melebihi standar 30 menit.

b. **Sumber:** Logbook IGD, audit mutu klinis, dan standar *American Heart Association* (AHA).

6. Keperawatan Jiwa

a. **Masalah:** Tingginya angka kekambuhan (*relapse*) pada pasien skizofrenia akibat kurangnya dukungan keluarga (ekspresi emosi tinggi).

b. **Sumber:** Data rawat jalan, kunjungan rumah (*home visit*), dan studi literatur psikososial.

7. Keperawatan Keluarga, Gerontik, & Komunitas

a. **Masalah:** Isolasi sosial dan depresi pada lansia yang tinggal di panti wreda selama masa transisi pasca-pandemi.

b. **Sumber:** Skrining kesehatan jiwa lansia (GDS), observasi aktivitas harian, dan kebijakan pembatasan kunjungan.

Beberapa sumber utama dalam menemukan masalah penelitian (Fein, 2017):

1. Praktik Keperawatan

Praktik keperawatan merupakan sumber utama yang paling relevan dalam menemukan masalah penelitian. Pengalaman klinis sehari-hari memungkinkan perawat mengidentifikasi berbagai fenomena yang memerlukan kajian lebih lanjut. Dengan mengembangkan kemampuan observasi dan analisis, perawat dapat menemukan berbagai pertanyaan penelitian yang bermakna secara klinis.

Contoh:

Dalam praktik pengukuran tekanan darah, lengan atas merupakan lokasi standar. Namun, dalam kondisi tertentu digunakan lengan bawah sebagai alternatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa tekanan darah yang diukur di lengan bawah cenderung lebih tinggi dibandingkan lengan atas. Namun, perbedaan ini belum sepenuhnya dijelaskan, terutama terkait pengaruh karakteristik individu. Hal ini menjadi peluang penelitian yang penting untuk dikaji lebih lanjut.

2. Tinjauan Literatur

Literatur ilmiah merupakan sumber penting lainnya dalam menemukan masalah penelitian. Melalui penelusuran literatur, peneliti dapat:

a. Mengidentifikasi kesenjangan penelitian (*research gap*),
b. Menemukan hasil yang belum konsisten, atau
c. Mengembangkan penelitian sebelumnya.

Studi-studi yang telah dipublikasikan sering kali menyajikan rekomendasi penelitian lanjutan yang dapat dijadikan dasar untuk merumuskan masalah baru.

3. Teori

Teori juga menjadi sumber penting dalam pengembangan masalah penelitian, terutama untuk memperluas pemahaman konseptual dalam keperawatan. Masalah yang berasal dari teori umumnya bersifat lebih abstrak dan tidak selalu langsung berkaitan dengan praktik klinis, tetapi berkontribusi pada pengembangan ilmu.

Peneliti dapat menggunakan pendekatan deduktif dengan cara:

a. Menelaah teori atau model konseptual,
b. Kemudian menguji apakah teori tersebut dapat menjelaskan fenomena tertentu.

Contoh:

Penelitian tentang pasien HIV dapat mengkaji hubungan antara harapan, dukungan sosial, ketidakpastian penyakit, dan spiritualitas terhadap persepsi kesehatan. Model konseptual dibangun berdasarkan teori yang ada, kemudian diuji secara empiris menggunakan analisis statistik.

Pemilihan masalah penelitian memerlukan proses yang tidak singkat. Peneliti perlu melakukan banyak kegiatan: membaca, menelaah literatur, serta meluangkan waktu yang cukup untuk merencanakan penelitian secara matang.

Langkah berikutnya adalah mempersempit area masalah yang masih bersifat umum menjadi masalah penelitian yang spesifik dan terfokus. Hal ini penting karena masalah yang terlalu luas akan menimbulkan beberapa kendala, antara lain:

a. Memerlukan penelusuran literatur yang sangat banyak dan tidak selalu relevan,
b. Meningkatkan beban kerja dalam proses pengumpulan dan pengolahan data,
c. Menyulitkan dalam mengorganisasi hasil penelitian,
d. Serta menyulitkan dalam perumusan hipotesis.

Selain itu, masalah yang terlalu umum cenderung melibatkan banyak variabel, sehingga hasil penelitian menjadi sulit diinterpretasikan secara jelas dan mendalam. Oleh karena itu, peneliti perlu memastikan bahwa masalah

yang dipilih bersifat spesifik, terfokus, dan dapat diteliti secara empiris, sehingga menghasilkan temuan yang bermakna dan dapat diaplikasikan dalam praktik keperawatan.

4. Replikasi Penelitian

Replikasi merupakan proses pengulangan suatu penelitian dengan menggunakan prosedur yang sama atau serupa untuk menguji apakah hasil penelitian sebelumnya dapat diperoleh kembali secara konsisten. Dengan kata lain, replikasi bertujuan untuk memastikan keandalan dan validitas temuan penelitian.

Dalam bidang keperawatan, kurangnya studi replikasi menjadi salah satu hambatan dalam penerapan hasil penelitian ke dalam praktik. Hal ini menunjukkan bahwa temuan penelitian belum sepenuhnya diuji ulang dalam berbagai konteks dan populasi.

Sebagian peneliti menganggap bahwa replikasi memiliki nilai ilmiah yang lebih rendah dibandingkan penelitian original. Namun, pandangan ini tidak sepenuhnya tepat. Replikasi justru memiliki peran penting karena:

1. Dapat mengonfirmasi keabsahan hasil penelitian sebelumnya,
2. Mengidentifikasi kemungkinan hasil yang berbeda atau bertentangan,
3. Serta memberikan peluang untuk menguji kembali atau bahkan merevisi teori yang telah mapan.

Dengan demikian, replikasi merupakan bagian integral dari pengembangan ilmu pengetahuan yang berbasis bukti (*evidence-based practice*).

C. Cara Mendapatkan Masalah (Sumber Masalah)

Menurut Polit & Beck (2022) dan diperkuat oleh temuan Jones & Brown (2024), peneliti dapat menggali masalah melalui:

1. **Pengalaman Klinis:** Masalah yang ditemukan sehari-hari saat memberikan asuhan.
2. **Studi Literatur:** Membaca jurnal penelitian 5 tahun terakhir untuk menemukan rekomendasi penelitian selanjutnya (*research gap*).
3. **Teori Keperawatan:** Menguji apakah teori tertentu (misal: Teori Self-Care Orem) masih relevan diterapkan pada populasi tertentu.
4. **Isu Sosial & Global:** Masalah kesehatan yang muncul akibat perubahan gaya hidup atau teknologi (misal: *Cyberbullying* pada remaja).

Pedoman pemilihan masalah penelitian

Masalah penelitian yang dipilih sebaiknya memenuhi beberapa kriteria berikut:

1. Memberikan manfaat potensial bagi klien, perawat, komunitas kesehatan, maupun masyarakat luas.
2. Hasil penelitian dapat diaplikasikan dalam praktik keperawatan, pendidikan, dan/atau manajemen pelayanan kesehatan.
3. Memiliki relevansi secara teoretis dan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan.
4. Temuan penelitian mampu:
   a. Mendukung asumsi teoretis yang belum teruji,
   b. Menantang teori yang sudah ada, atau
   c. Menjelaskan ketidakkonsistenan dalam literatur.
5. Berpotensi menghasilkan perubahan atau pengembangan dalam praktik maupun kebijakan keperawatan.

D. Identifikasi & Perumusan Pertanyaan Penelitian

1. Pernyataan Masalah Penelitian

Merumuskan dan mendefinisikan masalah merupakan tahap awal sekaligus paling krusial dalam proses penelitian. Pernyataan masalah berfungsi sebagai dasar dalam menentukan arah dan desain penelitian, serta umumnya disajikan pada bagian awal laporan penelitian atau artikel ilmiah (Fein, 2017).

Bagian pembuka pernyataan masalah biasanya menggambarkan fenomena yang diteliti dan menegaskan fokus kajian. Selain itu, pernyataan masalah juga memberikan justifikasi pentingnya penelitian melalui penyajian informasi latar belakang yang relevan, baik yang berkaitan dengan praktik, pengembangan teori, maupun keduanya. Dengan demikian, pernyataan masalah tidak hanya menjelaskan apa yang akan diteliti, tetapi juga mengapa penelitian tersebut perlu dilakukan (Fein, 2017).

Pernyataan masalah yang dirumuskan secara jelas dan sistematis akan menjadi landasan dalam penyusunan tujuan penelitian serta mempermudah pelaksanaan tahapan penelitian selanjutnya. Dengan kata lain, kualitas pernyataan masalah sangat menentukan keberhasilan keseluruhan proses penelitian (Fein, 2017).

Secara umum, pernyataan masalah disusun dalam beberapa paragraf yang memuat identifikasi masalah yang signifikan dan dapat diteliti, serta didukung oleh sumber literatur yang relevan sebagai dasar argumentasi ilmiah (Fein, 2017).

a. Contoh Pernyataan Masalah

Kanker payudara merupakan salah satu masalah kesehatan utama pada perempuan. Data dari *American Cancer Society* menunjukkan bahwa kanker payudara adalah jenis kanker yang paling sering didiagnosis pada wanita, dengan risiko sekitar satu dari delapan wanita mengalaminya sepanjang hidup. Laporan *Cancer Facts and Figures* memperkirakan ratusan ribu kasus baru setiap tahunnya, dengan angka kematian yang tetap tinggi.

Diagnosis kanker payudara membawa dampak yang signifikan terhadap kehidupan perempuan, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Bahkan, banyak wanita melaporkan ketakutan yang lebih besar terhadap diagnosis kanker payudara dibandingkan penyakit jantung, meskipun secara statistik penyakit jantung memiliki tingkat kematian yang lebih tinggi.

Pengalaman menghadapi kanker payudara tidak hanya menimbulkan berbagai tantangan, tetapi juga dapat menjadi titik balik bagi individu untuk mengalami perubahan positif dan pertumbuhan diri. Tingkat kelangsungan hidup yang semakin meningkat menunjukkan bahwa banyak perempuan hidup lebih lama setelah diagnosis, sehingga aspek kualitas hidup, termasuk kesejahteraan spiritual, menjadi semakin penting.

Konsep transendensi diri diyakini berperan dalam membantu individu menghadapi kondisi penyakit dan menemukan makna hidup. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perempuan dengan kanker payudara dapat mengalami peningkatan kesejahteraan, menemukan tujuan hidup, serta membangun hubungan yang lebih bermakna dengan orang lain selama proses pemulihan.

Namun demikian, aspek kesejahteraan spiritual dan praktik spiritual yang dilakukan oleh perempuan penyintas kanker payudara masih belum banyak dijelaskan dalam literatur ilmiah. Padahal, pemahaman terhadap aspek ini sangat penting dalam mendukung pendekatan keperawatan holistik.

Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mengkaji secara mendalam mengenai kesejahteraan spiritual dan praktik spiritual pada perempuan yang pulih dari kanker payudara, sehingga dapat menjadi dasar bagi intervensi keperawatan yang lebih komprehensif dan bermakna

b. Karakteristik Pernyataan Masalah

Secara konseptual, pernyataan masalah menggambarkan suatu fenomena atau isu yang memerlukan penyelidikan ilmiah. Salah satu syarat utama dari masalah penelitian adalah bahwa masalah tersebut harus dapat

diteliti (researchable), yaitu memungkinkan untuk dikaji melalui pengumpulan dan analisis data.

Melalui pendekatan ilmiah, peneliti berupaya menarik kesimpulan berdasarkan data empiris yang berkaitan dengan konsep-konsep utama dalam penelitian. Oleh karena itu, peneliti perlu merumuskan definisi operasional, yaitu penjelasan yang jelas mengenai bagaimana suatu variabel diukur atau diamati dalam penelitian.

Definisi operasional memiliki peran penting terutama dalam penelitian kuantitatif, karena memastikan bahwa konsep yang diteliti dapat diukur secara objektif. Misalnya, konsep seperti transendensi diri, kesejahteraan spiritual, dan praktik spiritual perlu diterjemahkan ke dalam indikator yang terukur agar dapat dianalisis secara ilmiah. Dalam artikel ilmiah, definisi operasional umumnya dijelaskan pada bagian metode, khususnya pada subbagian instrumen atau pengumpulan data.

Tidak semua masalah dapat dijadikan penelitian. **Masalah yang bersifat etis atau filosofis** umumnya tidak dapat diteliti secara langsung karena tidak memiliki jawaban yang bersifat benar atau salah secara empiris. Contohnya adalah isu mengenai perpanjangan hidup dengan intervensi medis tertentu atau pertimbangan kualitas hidup pasien. Penelitian hanya dapat menggali persepsi atau sikap individu terhadap isu tersebut, tetapi tidak dapat memberikan jawaban final. Meskipun demikian, kajian terhadap isu-isu tersebut tetap penting untuk memperkaya pemahaman dan pengembangan ilmu.

Karakteristik lain dari pernyataan masalah adalah **tingkat signifikansinya**. Masalah yang dipilih harus memiliki potensi untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu keperawatan, baik dalam aspek praktik, pendidikan, maupun penelitian. Oleh karena itu, pemilihan masalah perlu mempertimbangkan nilai ilmiah dan relevansinya. Selain itu, aspek kelayakan penelitian (feasibility) juga perlu diperhatikan.

Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan meliputi:

a. Ketersediaan subjek penelitian
b. Keterbatasan waktu dan biaya
c. Kompetensi atau keahlian peneliti
d. Dukungan dan kerja sama dari pihak terkait
e. Ketersediaan sumber daya
f. Pertimbangan etika

2. **Penelitian Kuantitatif (Format PICOT)**

   Digunakan untuk menguji efektivitas intervensi atau mencari hubungan antar variabel.

   a. **Contoh Judul:** "Pengaruh Terapi Musik Klasik terhadap Tingkat Nyeri Pasien Pasca-Operasi Fraktur."
   b. **Rumusan PICOT:** Apakah pada pasien pasca-operasi fraktur (P), pemberian terapi musik klasik (I) dibandingkan dengan perawatan standar saja (C) efektif dalam menurunkan skala nyeri (O) selama 24 jam pertama pasca-bedah (T)?

3. **Penelitian Kualitatif (Format SPIDER)**

   Digunakan untuk menggali makna, persepsi, atau pengalaman hidup.

   a. **Contoh Judul:** "Pengalaman Psikologis Perawat IGD dalam Menghadapi Kematian Pasien Akibat Kecelakaan Massal."
   b. **Rumusan SPIDER:** Bagaimana pengalaman psikologis (PI) perawat IGD (S) dalam menghadapi kematian pasien akibat kecelakaan massal (E) yang digali melalui studi fenomenologi (D) dalam konteks keperawatan gawat darurat (R)?

E. Merumuskan Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus sejalan dengan rumusan masalah dan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur (Luan et al., 2024). Pernyataan tujuan merupakan pernyataan utama yang menjelaskan alasan mengapa suatu masalah diteliti. Pernyataan ini menggambarkan arah, maksud, serta hasil yang diharapkan dari penelitian, sekaligus memperjelas jenis pengetahuan yang ingin diperoleh (Fein, 2017).

Dalam artikel ilmiah, pernyataan tujuan umumnya disusun secara objektif dan mencerminkan jenis desain penelitian yang akan digunakan. Posisi pernyataan tujuan dapat bervariasi, misalnya:

1. Berada di akhir paragraf tinjauan literatur, atau
2. Disajikan dalam paragraf khusus dengan subjudul “Tujuan Penelitian”.

Pernyataan tujuan yang baik mampu memberikan gambaran awal mengenai pendekatan penelitian yang akan dilakukan.

1. **Tujuan Umum:** Mengetahui pengaruh intervensi X terhadap variabel Y.
2. **Tujuan Khusus:**
   a. Mengidentifikasi karakteristik responden (umur, jenis kelamin).
   b. Mengukur tingkat nyeri sebelum intervensi.
   c. Mengukur tingkat nyeri sesudah intervensi.
   d. Menganalisis perbedaan tingkat nyeri sebelum dan sesudah intervensi.

Berikut beberapa bentuk lain pernyataan tujuan penelitian:

1. Eksploratif (mengeksplorasi efek/intervensi)

   Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh intervensi kesehatan komprehensif terhadap status kesehatan secara menyeluruh, kesehatan fisik, serta efikasi diri dalam perilaku promosi kesehatan pada remaja perempuan di sekolah menengah.

2. Deskriptif-korelasi (menggambarkan hubungan)

   Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kualitas hidup terkait kesehatan (health-related quality of life/HRQoL) dengan indeks massa tubuh (body mass index/BMI), dengan mengendalikan faktor penyakit kronis terkait obesitas.

3. Analitik-prediktif (memahami dan memprediksi)

   Penelitian ini bertujuan untuk:

   a. Mengidentifikasi beban pengasuh, status kesehatan, dan kemampuan belajar pada pengasuh lansia;
   b. Menganalisis hubungan antar variabel tersebut; serta
   c. Menentukan faktor-faktor yang memengaruhi beban pengasuh.

Untuk memudahkan pemahaman mahasiswa, dibuatkan tabel identifikasi masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian kuantitatif dan kualitatif sesuai area keperawatan

Tabel 2.1: Identifikasi masalah dan menentukan tujuan penelitian kuantitatif (PICOT)

No	Area Keperawatan	Fenomena/Masalah Klinis	Rumusan Masalah	Tujuan Penelitian
1	**Kep. Dasar**	Tingginya kejadian flebitis pada pemasangan infus.	Apakah penggunaan transparan dressing **(I)** dibandingkan dengan kasa steril **(C)** efektif menurunkan angka kejadian flebitis **(O)** pada pasien dewasa **(P)** selama 72 jam pemasangan **(T)**?	Menganalisis perbedaan efektivitas *transparan dressing* dan kasa terhadap kejadian flebitis pada pasien dewasa.

2	**Manajemen**	Rendahnya kepatuhan perawat dalam operan pasien (*handover*).	Apakah penerapan modul *SBAR-Handover* berbasis digital **(I)** dibandingkan metode lisan standar **(C)** meningkatkan akurasi informasi medis **(O)** pada perawat pelaksana **(P)** dalam waktu 1 bulan evaluasi **(T)**?	Mengidentifikasi pengaruh penerapan *SBAR-Digital* terhadap peningkatan akurasi informasi saat operan shift.
3	**KMB**	Kekakuan sendi pada pasien paska stroke.	Apakah latihan *Range of Motion* (ROM) silindris **(I)** lebih efektif dibandingkan ROM pasif standar **(C)** terhadap peningkatan kekuatan otot tangan **(O)** pada pasien stroke non-hemoragik **(P)** setelah 2 minggu intervensi **(T)**?	Membuktikan pengaruh latihan ROM silindris terhadap peningkatan kekuatan otot tangan pada pasien stroke non-hemoragik.
4	**Maternitas**	Ketidaklancaran produksi ASI pada ibu post-partum.	Apakah kombinasi pijat oksitosin dan teknik marmet **(I)** dibandingkan pijat oksitosin saja **(C)** mempercepat onset pengeluaran ASI **(O)** pada ibu nifas primipara **(P)**	Menilai efektivitas kombinasi pijat oksitosin dan teknik marmet terhadap percepatan onset pengeluaran ASI.

			dalam 3 hari pertama **(T)**?	
5	**Anak**	Obesitas pada anak usia sekolah karena kurang aktivitas.	Apakah program *Exergame* (permainan digital aktif) **(I)** dibandingkan edukasi gizi konvensional **(C)** efektif menurunkan indeks massa tubuh (IMT) **(O)** pada anak usia 6-12 tahun **(P)** selama 3 bulan program **(T)**?	Menganalisis pengaruh intervensi *Exergame* terhadap penurunan Indeks Massa Tubuh (IMT) pada anak usia sekolah.
6	**Gawat Darurat**	Ketidakefektifan resusitasi jantung paru (RJP).	Apakah penggunaan alat *feedback* kompresi otomatis **(I)** dibandingkan kompresi manual tanpa alat **(C)** meningkatkan kualitas kedalaman kompresi dada **(O)** pada pasien henti jantung di IGD **(P)** selama siklus resusitasi **(T)**?	Membandingkan kualitas kedalaman kompresi dada antara penggunaan alat *feedback* otomatis dan teknik manual.
7	**Kritis**	Risiko *Ventilator-Associated Pneumonia* (VAP).	Apakah oral hygiene menggunakan *Chlorhexidine 0,2%* **(I)** dibandingkan air matang **(C)**	Menganalisis pengaruh pemberian *oral hygiene Chlorhexidine 0,2%* terhadap penurunan

			menurunkan insiden VAP **(O)** pada pasien dengan ventilator mekanik **(P)** selama perawatan di ICU **(T)**?	angka kejadian VAP.
8	**Jiwa**	Halusinasi pendengaran yang menetap pada pasien.	Apakah pemberian terapi menghardik dikombinasikan dengan terapi musik **(I)** dibandingkan terapi menghardik saja **(C)** efektif menurunkan frekuensi halusinasi **(O)** pada pasien skizofrenia **(P)** setelah 6 sesi pertemuan **(T)**?	Menguji efektivitas kombinasi terapi menghardik dan terapi musik terhadap penurunan frekuensi halusinasi pendengaran.
9	**Gerontik**	Risiko jatuh akibat penurunan keseimbangan pada lansia.	Apakah latihan *Otago Exercise* **(I)** dibandingkan senam lansia biasa **(C)** lebih efektif meningkatkan keseimbangan dinamis **(O)** pada lansia risiko jatuh **(P)** selama 8 minggu latihan **(T)**?	Mengetahui pengaruh latihan *Otago Exercise* terhadap peningkatan keseimbangan dinamis pada lansia risiko jatuh
10	**Keluarga**	Ketidakmampuan keluarga merawat anggota dengan Hipertensi.	Apakah pendampingan keluarga melalui *Home-care*	Menganalisis dampak pendampingan *Home-care*

			berbasis aplikasi **(I)** dibandingkan kunjungan puskesmas biasa **(C)** meningkatkan kemandirian keluarga dalam mengontrol tekanan darah **(O)** anggota keluarga yang sakit **(P)** selama 1 bulan **(T)**?	berbasis aplikasi terhadap tingkat kemandirian keluarga merawat hipertensi.
11	**Komunitas**	Rendahnya cakupan imunisasi dasar lengkap di desa X.	Apakah kampanye imunisasi melalui *Peer-Education* (kader sebaya) **(I)** dibandingkan penyuluhan oleh tenaga kesehatan **(C)** meningkatkan motivasi ibu membawa balita ke posyandu **(O)** selama periode intervensi 3 bulan **(T)**?	Menilai perbedaan efektivitas *Peer-Education* dan penyuluhan konvensional terhadap motivasi ibu dalam imunisasi balita.

Tabel 2.2. Identifikasi Masalah dan menentukan tujuan penelitian Kualitatif (SPIDER)

No	Area Keperawatan	Fenomena/Masalah Klinis	Rumusan Masalah	Tujuan penelitian
1	**Kep. Dasar**	Pengalaman nyeri spritual pasien terminal.	Bagaimana makna kedamaian spiritual **(PI)** pada pasien kanker stadium akhir **(S)** yang digali melalui studi fenomenologi **(D)**	Mengeksplorasi secara mendalam makna kedamaian spiritual pada pasien kanker stadium akhir.

			untuk memahami kualitas hidup mereka **(E)** (R: Kualitatif)?	
2	**Manajemen**	Fenomena *Burnout* pada perawat baru.	Bagaimana persepsi beban kerja dan stres kerja **(PI)** perawat lulusan baru (*new grad*) **(S)** dalam studi deskriptif kualitatif **(D)** untuk mengeksplorasi strategi koping mereka **(E)** (R: Kualitatif)?	Mendeskripsikan persepsi beban kerja dan strategi koping perawat lulusan baru yang mengalami *burnout*.
3	**KMB**	Stigma pasien dengan luka kronis (mis. Kusta/DM).	Bagaimana pengalaman hidup dan hambatan sosial **(PI)** pasien dengan luka diabetes kronis **(S)** dalam studi kasus kualitatif **(D)** untuk mengungkap persepsi diri mereka **(E)** (R: Kualitatif)?	Memahami pengalaman hidup dan dampak psikososial akibat stigma pada pasien dengan luka diabetes kronis.
4	**Maternitas**	Trauma persalinan pada korban kekerasan.	Bagaimana pengalaman emosional selama proses persalinan **(PI)** pada ibu dengan riwayat kekerasan seksual **(S)** melalui pendekatan fenomenologi **(D)**	Menggali pengalaman emosional dan kebutuhan dukungan selama persalinan pada ibu dengan

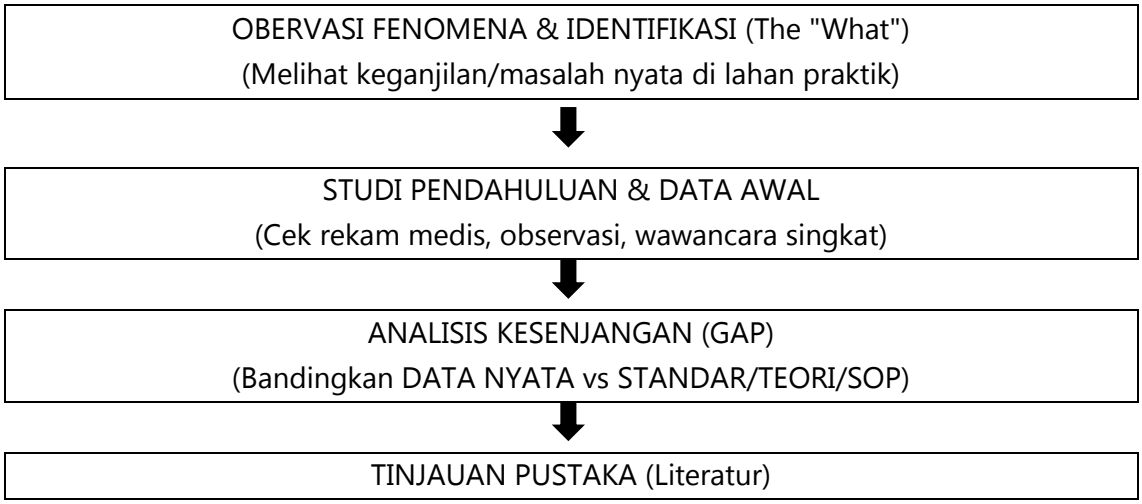
			untuk mengevaluasi kebutuhan dukungan emosional **(E)** (R: Kualitatif)?	riwayat trauma kekerasan.
5	**Anak**	Persepsi orang tua terhadap anak berkebutuhan khusus.	Bagaimana tantangan psikologis dan penerimaan diri **(PI)** orang tua yang memiliki anak dengan autisme **(S)** melalui studi naratif **(D)** untuk mengeksplorasi proses resiliensi keluarga **(E)** (R: Kualitatif)?	Mengeksplorasi proses resiliensi dan adaptasi psikologis orang tua dalam merawat anak dengan autisme.
6	**Gawat Darurat**	Dilema etik perawat saat kondisi *Triage* massal.	Bagaimana proses pengambilan keputusan etik **(PI)** perawat IGD saat menghadapi bencana massal **(S)** dalam studi fenomenologi interpretatif **(D)** untuk memahami konflik batin perawat **(E)** (R: Kualitatif)?	Mengidentifikasi tantangan dan proses pengambilan keputusan etik perawat IGD dalam situasi *triage* massal
7	**Kritis**	Pengalaman keluarga mendampingi pasien koma.	Bagaimana perasaan dan harapan keluarga **(PI)** yang mendampingi anggota keluarga di ruang ICU dalam kondisi	Menjelaskan gambaran perasaan, harapan, dan kebutuhan dukungan keluarga yang mendampingi

			kritis **(S)** melalui studi kualitatif deskriptif **(D)** untuk mengeksplorasi dukungan sosial yang dibutuhkan **(E)** (R: Kualitatif)?	pasien kritis di ICU.
8	**Jiwa**	Stigma masyarakat terhadap mantan pasien RSJ.	Bagaimana pengalaman diskriminasi dan proses reintegrasi **(PI)** mantan pasien gangguan jiwa **(S)** di lingkungan tempat tinggal melalui studi *grounded theory* **(D)** untuk memahami hambatan pemulihan **(E)** (R: Kualitatif)?	Mengembangkan pemahaman tentang proses reintegrasi sosial dan hambatan diskriminasi pada mantan pasien gangguan jiwa.
9	**Gerontik**	Kesepian pada lansia yang ditinggal pasangan.	Bagaimana makna kehilangan dan strategi menghadapi kesepian **(PI)** pada lansia duda/janda **(S)** melalui studi fenomenologi **(D)** untuk mengeksplorasi dukungan psikososial **(E)** (R: Kualitatif)?	Mengungkap makna kehilangan dan cara lansia mengatasi kesepian setelah ditinggal pasangan hidup.
10	**Keluarga**	Dinamika keluarga merawat ODHA (Orang dengan HIV).	Bagaimana persepsi dan dukungan	Mengeksplorasi dinamika dukungan dan

			anggota keluarga **(PI)** dalam merawat anggota keluarga dengan HIV/AIDS **(S)** melalui studi fenomenologi **(D)** untuk mengungkap beban perawatan keluarga **(E)** (R: Kualitatif)?	beban psikososial keluarga dalam merawat anggota keluarga dengan HIV/AIDS.
11	**Komunitas**	Kepercayaan budaya terhadap praktik pengobatan tradisional.	Bagaimana pandangan budaya dan alasan pemilihan pengobatan alternatif **(PI)** pada masyarakat pedalaman **(S)** melalui pendekatan etnografi **(D)** untuk memahami perilaku pencarian kesehatan **(E)** (R: Kualitatif)?	Menganalisis perspektif budaya dan alasan masyarakat pedalaman dalam memilih praktik pengobatan tradisional

Diagram Alir Langkah Sistematis Perumusan Masalah dan Tujuan Penelitian

Konsep perumusan masalah dan tujuan penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:





Gambar 2.1: Diagram Alir Langkah Sistematis Perumusan Masalah dan Tujuan Penelitian

Penjelasan Tahapan Diagram Alir:

1. **Observasi & Identifikasi Fenomena (The "What")**
   a. Peneliti mengamati kejadian di lahan praktik.
   b. *Contoh:* Perawat mengamati banyak pasien lansia di bangsal KMB mengalami konstipasi selama perawatan.
2. **Studi Pendahuluan & Pengumpulan Data Awal**
   a. Melakukan cek rekam medis atau wawancara singkat untuk memastikan fenomena tersebut nyata (bukan sekadar perasaan).
   b. *Hasil:* Ditemukan data bahwa 60% lansia tidak BAB lebih dari 3 hari.
3. **Analisis Kesenjangan (*Gap Analysis*)**
   a. Membandingkan kenyataan dengan standar (SOP/Teori).
   b. *Kesenjangan:* Standarnya pasien harus BAB lancar, kenyataannya terjadi konstipasi masif.
4. **Tinjauan Pustaka (*Literature Review*)**
   a. Mencari penyebab atau solusi yang sudah ada di jurnal 5 tahun terakhir.
   b. *Temuan:* Masase abdomen atau pemberian air putih hangat sering disarankan, namun belum optimal dilakukan di ruangan tersebut.
5. **Perumusan Masalah (Latar Belakang)**
   a. Menyusun narasi yang kuat mengapa masalah ini "layak" dan "mendesak" untuk diteliti.

6. **Penyusunan Pertanyaan Penelitian (PICOT/SPIDER)**
   a. Mengubah masalah menjadi pertanyaan terstruktur.
   b. *Pertanyaan:* Apakah pemberian masase abdomen efektif menurunkan derajat konstipasi pada lansia?
7. **Penetapan Tujuan Penelitian (SMART)**
   a. Menetapkan hasil akhir yang ingin dicapai.
   b. *Tujuan:* Membuktikan pengaruh masase abdomen terhadap pola eliminasi alvi pada lansia.

F. Matriks Kriteria Kelayakan Masalah (FINER)

Setelah diagram alir dilewati, peneliti harus menguji masalah tersebut dengan kriteria **FINER** (Gray & Grove, 2021) untuk memastikan riset dapat diselesaikan:

a. **F (*Feasible*):** Tersediakah subjeknya? Cukupkah waktunya? Adakah biayanya?
b. **I (*Interesting*):** Apakah masalah ini menarik bagi peneliti dan bermanfaat bagi profesi?
c. **N (*Novel*):** Apakah ini memberikan temuan baru atau sekadar mengulang yang sudah ada tanpa modifikasi?
d. **E (*Ethical*):** Apakah intervensi ini aman bagi pasien dan sudah mendapat persetujuan komite etik?
e. **R (*Relevant*):** Apakah hasilnya nanti akan berkontribusi pada kemajuan asuhan keperawatan?

G. Rangkuman Materi

Menemukan masalah penelitian adalah langkah awal yang menentukan kualitas riset keperawatan. Masalah muncul dari adanya kesenjangan (*gap*) antara standar praktik (SOP/Teori) dengan kenyataan di lapangan. Peneliti harus mampu mengidentifikasi masalah di berbagai area (KMB, Maternitas, Anak, dsb) melalui observasi klinis dan studi literatur 5 tahun terakhir. Setelah masalah diidentifikasi dan diuji kelayakannya dengan kriteria FINER, masalah tersebut dirumuskan ke dalam pertanyaan terstruktur menggunakan format PICOT untuk kuantitatif atau SPIDER untuk kualitatif. Langkah terakhir adalah menetapkan tujuan penelitian yang SMART agar arah riset jelas, terukur, dan dapat dicapai.

H. Soal Latihan & Kasus (CBL)

Soal Kuantitatif (5 Soal)

1. Seorang perawat di ruang bedah mengamati tingginya angka infeksi area operasi. Perawat ingin membandingkan efektivitas penggunaan *povidone-*

iodine 10% dengan *chlorhexidine* 2% dalam perawatan luka. Manakah komponen "C" dalam format PICOT pada kasus tersebut?

A. Pasien paska operasi bedah
B. *Povidone-iodine* 10%
C. *Chlorhexidine* 2%
D. Penurunan angka infeksi
E. Waktu perawatan luka

Jawaban: C

2. **(C3)** Perawat puskesmas menemukan cakupan imunisasi dasar lengkap hanya 60% dari target 90%. Perawat merumuskan tujuan: "Mengetahui pengaruh edukasi melalui WhatsApp Group terhadap kepatuhan ibu dalam imunisasi." Apa kriteria "M" (Measurable) yang paling tepat untuk tujuan tersebut?
   A. Ibu merasa senang dengan edukasi
   B. Peningkatan jumlah kunjungan imunisasi yang tercatat di KMS
   C. Edukasi diberikan setiap hari Senin
   D. Ibu memahami pentingnya imunisasi
   E. Penggunaan aplikasi WhatsApp yang mudah

   Jawaban: B
3. Di ruang ICU, ditemukan data bahwa 5 dari 10 pasien yang terpasang ventilator mengalami VAP. Perawat menelaah jurnal dan menemukan teknik *subglottic suctioning* sebagai solusi potensial. Manakah rumusan pertanyaan PICOT yang paling tepat?
   A. Apakah teknik *subglottic suctioning* dapat mencegah VAP di ruang ICU?
   B. Bagaimana pengaruh *suctioning* terhadap kenyamanan pasien kritis?
   C. Apakah pemberian *subglottic suctioning* (I) dibanding *suction* konvensional (C) menurunkan kejadian VAP (O) pada pasien ventilator (P)?
   D. Mengapa pasien ventilator berisiko mengalami pneumonia di ICU?
   E. Kapan waktu terbaik melakukan *suction* pada pasien VAP?

   Jawaban: C
4. Seorang peneliti ingin menguji pengaruh aromaterapi lemon terhadap mual muntah pada ibu hamil. Peneliti menetapkan kriteria inklusi: "Ibu hamil trimester I". Namun, peneliti ragu apakah ibu hamil dengan gastritis harus diikutkan. Berdasarkan prinsip pemilihan masalah, tindakan peneliti yang paling tepat adalah...
   A. Tetap memasukkan ibu dengan gastritis agar sampel banyak
   B. Mengeksklusi ibu dengan gastritis karena akan menjadi variabel pengganggu (*confounding*)
   C. Mengubah judul penelitian menjadi pengaruh gastritis pada ibu hamil

D. Menghapus kriteria inklusi trimester I
E. Menunda penelitian hingga pasien gastritis sembuh

Jawaban: B

5. Anda diminta menyusun rancangan riset manajemen keperawatan untuk mengatasi rendahnya kepuasan pasien terhadap komunikasi perawat. Susunlah urutan langkah identifikasi masalah yang paling sistematis...
   A. Studi literatur -> Identifikasi fenomena -> Pertanyaan penelitian -> Data awal
   B. Identifikasi fenomena -> Data awal -> Analisis gap -> Tinjauan pustaka -> Pertanyaan penelitian
   C. Pertanyaan penelitian -> Analisis gap -> Data awal -> Observasi
   D. Tinjauan pustaka -> Penentuan tujuan -> Identifikasi fenomena -> Masalah
   E. Data awal -> Analisis gap -> Pertanyaan penelitian -> Tinjauan pustaka

   Jawaban: B

Soal Kualitatif (5 Soal)

6. Perawat jiwa ingin mengeksplorasi perasaan keluarga yang memiliki anggota keluarga dengan gangguan jiwa berat di komunitas. Perawat menggunakan format SPIDER. Manakah yang merupakan komponen "PI" (*Phenomenon of Interest*)?
   A. Keluarga pasien gangguan jiwa
   B. Studi fenomenologi
   C. Perasaan dan pengalaman batin keluarga
   D. Wawancara mendalam
   E. Wilayah komunitas puskesmas

   Jawaban: C

7. Seorang perawat melakukan penelitian kualitatif dengan judul "Persepsi Pasien Kanker Stadium Terminal terhadap Makna Hidup". Manakah tujuan penelitian yang paling sesuai?
   A. Mengukur tingkat depresi pasien kanker stadium terminal
   B. Menganalisis hubungan stadium kanker dengan keinginan hidup
   C. Mengeksplorasi pandangan dan makna hidup menurut pasien kanker stadium terminal
   D. Membandingkan terapi paliatif dengan terapi konvensional
   E. Menurunkan gejala nyeri pada pasien kanker

   Jawaban: C

8. Perawat IGD sering mengalami stres saat menangani pasien kecelakaan massal. Peneliti ingin mengetahui bagaimana "strategi koping" mereka. Mengapa format SPIDER lebih tepat digunakan dibanding PICOT untuk kasus ini?
   A. Karena melibatkan jumlah sampel yang sangat besar
   B. Karena bertujuan menggali makna subjektif dan pengalaman, bukan menguji intervensi
   C. Karena peneliti ingin membandingkan dua jenis obat stres d. Karena data yang dihasilkan berupa angka statistik
   D. Karena waktu penelitian dilakukan secara longitudinal

   Jawaban: B
9. Dalam studi kualitatif tentang "Resiliensi Perawat di Daerah Terpencil", peneliti menemukan bahwa beberapa informan tidak jujur karena takut kepada atasan. Peneliti harus memutuskan cara memperbaiki masalah ini dalam rumusan prosedur. Tindakan paling tepat adalah...
   A. Mengganti pertanyaan penelitian menjadi kuantitatif
   B. Menjamin kerahasiaan (*anonymity*) dan membina hubungan saling percaya (*trust*) sebelum wawancara
   C. Menghentikan penelitian karena data tidak valid
   D. Memaksa perawat untuk jujur demi ilmu pengetahuan
   E. Melaporkan perawat tersebut ke atasan

   Jawaban: B
10. Rancanglah sebuah judul penelitian kualitatif yang paling tepat untuk area keperawatan gerontik di masa transisi dari panti ke lingkungan rumah...
   A. Pengaruh dukungan keluarga terhadap kemandirian lansia (Kuantitatif)
   B. Hubungan jenis kelamin dengan tingkat kesepian lansia (Kuantitatif)
   C. Studi fenomenologi: Pengalaman transisi dan adaptasi psikososial lansia paska perawatan di panti wreda
   D. Perbedaan skor MMSE lansia di panti dan di rumah (Kuantitatif)
   E. Efektivitas senam otak terhadap fungsi kognitif lansia (Kuantitatif)

   Jawaban: C

Soal Esai Kualitatif: Perawat komunitas menemukan fenomena banyak warga di Desa X yang lebih memilih berobat ke dukun daripada ke Puskesmas saat menderita penyakit kronis.

1. Susunlah pertanyaan penelitian menggunakan format SPIDER!
2. Mengapa masalah ini lebih cocok diteliti dengan metode kualitatif?

Jawaban Esai Kualitatif:

1. **SPIDER:** Bagaimana persepsi dan alasan pemilihan pengobatan tradisional (PI) pada warga Desa X (S) yang digali melalui studi etnografi (D) untuk memahami perilaku pencarian kesehatan (E) dalam perspektif kualitatif (R)?
2. **Alasan:** Masalah ini lebih cocok kualitatif karena peneliti ingin menggali alasan mendalam, sistem kepercayaan, nilai budaya, dan pengalaman subjektif masyarakat yang tidak bisa diukur hanya dengan angka atau kuesioner kaku.

I. Daftar Pustaka

Fein, J. A. (2017). *Reading Understanding and apllying Nursing Reasearch Fifth Edition*. Philadelphia : F. A. Davis Company.

Gray, J. R., & Grove, S. K. (2021). *The practice of nursing research: Appraisal, synthesis,* and *generation of evidence* (9th ed.). Elsevier.

Holloway, I., & Galvin, K. (2021). *Qualitative research in nursing and healthcare*. John Wiley & Sons.

Jones, A., & Brown, L. (2024). Identifying clinical gaps in critical care: A systematic review. *Journal of Clinical Nursing*, 33(2), 145-158.

Luan, M., et al. (2024). The impact of SMART goal setting on nursing students' research *productivity*. *Nurse Education Today*, 132, 106-115.

Nieswiadomy, R. M., & Bailey, C. (2018). *NURSING Foundations of Nursing Research*. United States of America: Pearson Education, Inc.

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2022). *Essentials of nursing research: Appraising evidence for nursing practice* (10th ed.). Lippincott Williams & Wilkins.

Smith, J., et al. (2023). Framing research questions in evidence-based practice: A guide for clinical nurses. *International Journal of Nursing Studies*, 140, 104-112.

White, S., et al. (2021). PICOT, SPIDER, and SPICE: A comparison of search frameworks for nursing questions. *Evidence-Based Nursing*, 24(3), 75-81.

BAB 3

TELAAH PUSTAKA DAN MANAJEMEN REFERENSI

Tabel CPL

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menguasai konsep riset keperawatan dan Evidence-Based Nursing (EBN), termasuk etika, integritas ilmiah, dan hirarki bukti sebagai landasan praktik.	CPMK-1; CPMK-7
CPL-2	Mampu mengidentifikasi masalah keperawatan/praktik, merumuskan pertanyaan penelitian/EBN, serta menetapkan tujuan yang terukur.	CPMK-2; CPMK-3
CPL-3	Mampu merancang metode penelitian (kuantitatif/kualitatif) termasuk desain, populasi–sampel, sampling, instrumen, dan prosedur pengumpulan/manajemen data secara sistematis.	CPMK-4; CPMK-5
CPL-4	Mampu melakukan analisis data dasar (kuantitatif/kualitatif) dan menyajikan temuan secara ilmiah, jelas, dan dapat ditindaklanjuti.	CPMK-6; CPMK-7
CPL-5	Mampu melakukan critical appraisal bukti dan merancang penerapan EBN di praktik dengan indikator evaluasi yang terukur dan kolaboratif.	CPMK-7; CPMK-1
CPL-6	Mampu menyusun proposal/skripsi/manuskrip ilmiah, mengelola referensi, dan menyampaikan hasil secara profesional untuk perbaikan mutu layanan.	CPMK-3; CPMK-7

Tabel CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan konsep dasar riset keperawatan dan EBN, termasuk etika–integritas ilmiah, keselamatan partisipan, dan prinsip penggunaan bukti.
CPMK-2	Merumuskan masalah, tujuan, dan pertanyaan penelitian/EBN yang fokus, terukur, dan feasible sesuai konteks keperawatan.
CPMK-3	Melakukan telaah pustaka sistematis sederhana, mengelola referensi, serta menyusun kerangka teori/konsep dan hipotesis/rumusan konseptual yang logis.
CPMK-4	Menentukan desain penelitian kuantitatif/kualitatif yang sesuai, termasuk populasi–sampel, teknik sampling, dan kontrol kualitas metodologis.
CPMK-5	Menyusun instrumen dan rencana pengukuran, prosedur pengumpulan data, serta manajemen data (keamanan, kerahasiaan, kualitas) yang dapat diaudit.
CPMK-6	Melakukan analisis data kuantitatif dasar dan analisis data kualitatif, serta menyajikan temuan dalam format ilmiah yang jelas.
CPMK-7	Melakukan critical appraisal dan menetapkan tingkat bukti, merancang implementasi EBN di praktik, serta menyusun proposal/skripsi/manuskrip sesuai kaidah ilmiah.

Tabel Pemetaan Bab–Sub-CPMK–CPMK

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 1. Konsep Dasar Riset Keperawatan dan Evidence-Based Nursing (EBN)	1.1 Menjelaskan langkah inti riset dan siklus EBN (ask–acquire–appraise–apply–assess) sebagai alur kerja berbasis bukti.	1.2 Mengidentifikasi prinsip etika, integritas ilmiah, dan perlindungan partisipan pada penelitian keperawatan.	CPMK-1	CPMK-7; CPMK-2
Bab 2. Menemukan Masalah dan Merumuskan	2.1 Mengidentifikasi gap praktik/masalah prioritas dan menyusun	2.2 Merumuskan pertanyaan penelitian/EBN (mis.	CPMK-2	CPMK-1; CPMK-3

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Pertanyaan Penelitian	latar belakang berbasis data awal.	PICOT/SPIDER) dan tujuan yang terukur.		
Bab 3. Telaah Pustaka dan Manajemen Referensi	3.1 Menyusun strategi pencarian literatur (kata kunci, operator boolean, kriteria inklusi–eksklusi) yang dapat direplikasi.	3.2 Mengelola sitasi dan menyusun sintesis literatur ringkas (matriks temuan) secara konsisten.	CPMK-3	CPMK-2; CPMK-7
Bab 4. Kerangka Teori, Kerangka Konsep, dan Hipotesis	4.1 Menyusun kerangka teori/konsep dan definisi operasional konsep/variabel sesuai literatur.	4.2 Merumuskan hipotesis/rumusan konseptual dan arah hubungan antar-variabel/konsep secara logis.	CPMK-3	CPMK-4; CPMK-2
Bab 5. Desain Penelitian Kuantitatif	5.1 Membedakan desain kuantitatif utama dan memilih desain sesuai tujuan/pertanyaan.	5.2 Menetapkan variabel, outcome, dan strategi minimisasi bias sesuai desain yang dipilih.	CPMK-4	CPMK-5; CPMK-6
Bab 6. Desain Penelitian Kualitatif	6.1 Membedakan desain kualitatif utama dan memilih pendekatan sesuai tujuan eksplorasi pengalaman/konteks.	6.2 Menetapkan strategi kualitas kualitatif (kredibilitas, dependabilitas) melalui rencana prosedur dan dokumentasi jejak audit.	CPMK-4	CPMK-5; CPMK-6
Bab 7. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling	7.1 Menetapkan populasi sasaran, kriteria inklusi–eksklusi, dan kebutuhan ukuran sampel secara rasional.	7.2 Memilih teknik sampling (probability/non-probability) dan justifikasi kesesuaian dengan desain.	CPMK-4	CPMK-5; CPMK-2
Bab 8. Instrumen	8.1 Memilih/menyusun instrumen sesuai	8.2 Menyusun rencana uji validitas–reliabilitas	CPMK-5	CPMK-4; CPMK-6

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Penelitian dan Pengukuran	konstruk dan skala ukur untuk menghasilkan data yang valid.	(atau trustworthiness untuk instrumen kualitatif) termasuk uji coba/pilot.		
Bab 9. Prosedur Pengumpulan Data dan Manajemen Data	9.1 Menyusun SOP pengumpulan data (alur, peran, kontrol kualitas) termasuk persetujuan partisipan.	9.2 Menetapkan manajemen data (coding, cleaning, penyimpanan aman, kerahasiaan) yang dapat diaudit.	CPMK-5	CPMK-1; CPMK-7
Bab 10. Analisis Data Kuantitatif Dasar	10.1 Memilih teknik analisis deskriptif dan uji dasar sesuai jenis data dan tujuan analisis.	10.2 Menginterpretasi output analisis dan melaporkan hasil secara ringkas (parameter kunci dan makna klinis).	CPMK-6	CPMK-4; CPMK-7
Bab 11. Analisis Data Kualitatif dan Penyajian Temuan	11.1 Melakukan coding dan membangun kategori/tema berdasarkan data kualitatif secara sistematis.	11.2 Menyajikan temuan (narasi, tabel/diagram) dengan keterlacakan data dan koherensi interpretasi.	CPMK-6	CPMK-3; CPMK-7
Bab 12. Critical Appraisal dan Hirarki Bukti	12.1 Melakukan critical appraisal menggunakan checklist yang relevan untuk menilai risiko bias dan kualitas studi.	12.2 Menetapkan tingkat bukti dan kekuatan rekomendasi untuk keputusan praktik/penelitian lanjutan.	CPMK-7	CPMK-1; CPMK-3
Bab 13. Implementasi Evidence-Based Nursing di Praktik	13.1 Menyusun sintesis bukti untuk menjawab pertanyaan praktik dan merumuskan rekomendasi berbasis bukti.	13.2 Merancang rencana implementasi EBN (stakeholder, indikator proses–hasil, audit–umpan balik) yang terukur.	CPMK-7	CPMK-6; CPMK-2

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 14. Penyusunan Proposal, Skripsi, dan Publikasi Ilmiah	14.1 Menyusun dokumen proposal/skripsi dengan konsistensi metodologis (latar–metode–rencana analisis–etik).	14.2 Menyusun manuskrip/presentasi ilmiah dengan sitasi benar, struktur IMRAD, dan kepatuhan etika publikasi.	CPMK-7	CPMK-3; CPMK-6

Tabel Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-1	Ujian tulis (CBT/essay terstruktur)	Persentase jawaban benar konsep inti EBN/etika dan ketepatan identifikasi isu etik pada skenario.	10	Nilai ujian; lembar jawaban
CPMK-2	Tugas perumusan masalah & pertanyaan (template PICOT/SPIDER)	Ketepatan struktur pertanyaan (komponen lengkap) dan keterukuran tujuan/outcome (skor rubrik).	10	Dokumen pertanyaan & tujuan
CPMK-3	Tugas telaah pustaka ringkas + matriks literatur	Reproducibility strategi pencarian (kriteria jelas) dan kualitas sintesis/kerangka konsep (skor rubrik).	15	Matriks literatur; kerangka konsep
CPMK-4	Ujian/penugasan rancangan metode (protocol brief)	Kesesuaian desain dengan pertanyaan dan ketepatan rencana	15	Protocol brief metode

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
		sampling/ukuran sampel (skor rubrik).		
CPMK-5	Penugasan instrumen + SOP pengumpulan/manajemen data	Kesesuaian instrumen–skala ukur dan kelengkapan SOP/manajemen data (checklist/rubrik).	15	Draft instrumen; SOP; data dictionary
CPMK-6	Praktikum analisis data (dataset/skenario) + laporan singkat	Akurasi pemilihan analisis dan interpretasi output serta kualitas penyajian temuan (skor rubrik).	15	File/hasil analisis; laporan ringkas
CPMK-7	Proyek mini EBN + critical appraisal + draft proposal/manuskrip	Ketepatan appraisal (risiko bias/tingkat bukti) dan keterukuran rencana implementasi/struktur dokumen ilmiah (skor rubrik).	20	Form appraisal; rencana implementasi; proposal/manuskrip

Tabel Rubrik CPMK (skala 1–4)

Rubrik CPMK-1

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Ketepatan konsep inti riset/EBN (% benar)	<60% benar; miskonsepsi dominan	60–74% benar; miskonsepsi masih ada	75–89% benar; kesalahan minor	≥90% benar; konsisten
1.2 Ketepatan identifikasi	Banyak isu kunci terlewat/keliru	Isu inti teridentifikasi; alasan lemah	Isu inti tepat;	Isu lengkap; alasan kuat,

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
isu etik pada skenario			alasan logis	mempertimbangkan risiko–mitigasi

Rubrik CPMK-2

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Kualitas struktur pertanyaan (kelengkapan komponen)	Komponen tidak lengkap; fokus tidak jelas	Komponen cukup; fokus masih melebar	Komponen lengkap; fokus jelas	Komponen sangat lengkap; sangat fokus dan operasional
2.2 Keterukuran tujuan/outcome & kelayakan (feasibility)	Tidak terukur; tidak feasible	Sebagian terukur; feasibility belum jelas	Terukur; feasibility logis	Sangat terukur; feasibility kuat dengan batasan jelas

Rubrik CPMK-3

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Reproducibility strategi pencarian & seleksi literatur	Tidak sistematis; tidak dapat diulang	Cukup sistematis; detail kurang	Sistematis; detail memadai untuk diulang	Sangat sistematis; transparan (query, kriteria, alur seleksi)
3.2 Kualitas sintesis & kerangka konsep/hipotesis	Sintesis lemah; kerangka tidak logis	Sintesis ada; kerangka kurang kuat	Sintesis baik; kerangka logis berbasis literatur	Sintesis sangat kuat; kerangka koheren dan menunjukkan gap jelas

Rubrik CPMK-4

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Kesesuaian desain dengan pertanyaan & kontrol bias	Desain tidak sesuai; bias tidak dipertimbangkan	Desain cukup sesuai; kontrol bias terbatas	Desain sesuai; kontrol bias jelas	Desain sangat sesuai; kontrol bias komprehensif dan realistis
4.2 Ketepatan rencana sampling (kriteria, ukuran, teknik)	Tidak jelas/keliru; tidak dapat dilaksanakan	Cukup jelas; masih ada kekurangan bermakna	Jelas; dapat dilaksanakan; justifikasi memadai	Sangat jelas; justifikasi kuat; mempertimbangkan keterbatasan dan mitigasi

Rubrik CPMK-5

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Kesesuaian instrumen & skala ukur terhadap konstruk	Tidak sesuai; indikator tidak jelas	Cukup sesuai; definisi operasional kurang	Sesuai; definisi operasional jelas	Sangat sesuai; indikator sangat tepat dan konsisten
5.2 Kelengkapan SOP pengumpulan & manajemen data	SOP tidak lengkap; risiko kualitas/kerahasiaan tinggi	SOP cukup; kontrol kualitas/keamanan belum konsisten	SOP lengkap; kontrol kualitas dan keamanan jelas	SOP sangat lengkap; audit trail kuat (coding, cleaning, storage, akses)

Rubrik CPMK-6

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Akurasi pemilihan analisis & interpretasi output kuantitatif	Salah memilih analisis; interpretasi keliru	Analisis cukup tepat; interpretasi terbatas	Analisis tepat; interpretasi jelas	Analisis sangat tepat; interpretasi kuat dan bermakna klinis
6.2 Kualitas analisis kualitatif/penyajian temuan	Coding tidak sistematis; temuan tidak terlacak	Coding cukup; tema kurang koheren	Coding sistematis; tema koheren; penyajian jelas	Sangat sistematis; tema kuat; penyajian transparan dan meyakinkan

Rubrik CPMK-7

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Ketepatan critical appraisal & penetapan tingkat bukti	Penilaian bias keliru; tingkat bukti tidak tepat	Penilaian cukup; masih ada kekeliruan bermakna	Penilaian tepat; tingkat bukti sesuai	Penilaian sangat tepat; justifikasi kuat dan konsisten
7.2 Keterukuran rencana implementasi/struktur dokumen ilmiah	Rencana/dokumen tidak sistematis; indikator tidak terukur	Cukup sistematis; indikator sebagian terukur	Sistematis; indikator proses–hasil terukur	Sangat sistematis; indikator komprehensif (baseline–target–cara ukur) dan rencana audit jelas

Pendahuluan

Perkembangan ilmu keperawatan yang semakin berbasis bukti menuntut mahasiswa dan praktisi untuk memiliki kemampuan literasi ilmiah yang kuat. Dalam konteks *Evidence-Based Nursing (EBN)*, pengambilan keputusan klinis tidak lagi semata-mata didasarkan pada pengalaman, tetapi pada sintesis bukti ilmiah terbaik, keahlian klinis, serta nilai dan preferensi pasien. Oleh karena itu, kemampuan melakukan manajemen referensi dan sitasi ilmiah menjadi kompetensi esensial dalam riset keperawatan maupun praktik profesional.

Manajemen referensi bukan sekadar kegiatan teknis menyusun daftar pustaka, melainkan proses sistematis dalam mengidentifikasi, mengorganisasi, menyimpan, dan menggunakan sumber ilmiah secara akurat dan etis. Mahasiswa dan peneliti keperawatan dituntut tidak hanya mampu mencari literatur melalui basis data ilmiah, tetapi juga mengelola referensi tersebut secara efisien, melakukan sitasi sesuai standar internasional, serta memastikan tidak terjadi pelanggaran integritas akademik.

Dalam penulisan karya ilmiah di bidang kesehatan, gaya sitasi yang banyak digunakan adalah standar yang dikembangkan oleh American Psychological Association melalui *APA Style* edisi terbaru. Penguasaan gaya sitasi ini penting untuk menjaga konsistensi, kredibilitas, dan profesionalisme dalam publikasi ilmiah.

Bab ini membahas secara komprehensif tentang pentingnya manajemen referensi dalam riset keperawatan, penggunaan gaya sitasi APA edisi terbaru, teknik sitasi dalam teks dan penyusunan daftar pustaka, pemanfaatan perangkat lunak manajemen referensi, teknik impor file RIS dan BibTeX, strategi pencegahan plagiarisme, serta integrasi referensi dengan Microsoft Word. Dengan memahami materi dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu menghasilkan karya ilmiah yang sistematis, akurat, dan berintegritas tinggi sesuai standar akademik nasional maupun internasional.

Uraian Materi

Manajemen referensi merupakan proses sistematis dalam mengidentifikasi, mengumpulkan, menyimpan, mengorganisasi, dan menggunakan sumber-sumber ilmiah dalam penulisan karya akademik. Dalam konteks riset keperawatan, manajemen referensi memiliki peran yang sangat penting karena menjadi dasar dalam membangun argumen ilmiah, mendukung temuan penelitian, serta memastikan bahwa praktik keperawatan yang dilakukan berbasis bukti (*evidence-based*).

Menurut (Polit & Beck, 2021), riset keperawatan bertujuan untuk menghasilkan bukti ilmiah yang dapat digunakan dalam meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan. Oleh karena itu, penggunaan referensi yang valid, relevan, dan mutakhir menjadi keharusan dalam setiap tahap penelitian, mulai dari penyusunan latar belakang hingga pembahasan hasil penelitian.

Manajemen referensi yang baik memungkinkan peneliti untuk:

1. Menelusuri literatur secara sistematis
2. Menghindari duplikasi sumber
3. Menyusun kerangka teori yang kuat
4. Mendukung proses *critical appraisal*
5. Mempermudah penyusunan laporan ilmiah

Dalam praktik *Evidence-Based Nursing (EBN)*, manajemen referensi juga menjadi bagian penting dalam tahap *acquire* dan *appraise*, di mana perawat harus mampu mengakses dan mengevaluasi literatur ilmiah secara efektif (Melnyk & Fineout-Overholt, 2019)

A. Peran Manajemen Referensi Dalam Evidence-Based Nursing (Ebn)

EBN merupakan pendekatan yang mengintegrasikan bukti ilmiah terbaik, keahlian klinis, dan nilai pasien dalam pengambilan keputusan keperawatan. Proses EBN umumnya mengikuti langkah 5A, yaitu: *Ask, Acquire, Appraise, Apply,* dan *Assess*.

Pada tahap *acquire*, perawat dituntut untuk mencari literatur ilmiah yang relevan dari berbagai sumber seperti jurnal internasional, database kesehatan, dan panduan klinis. Tanpa kemampuan manajemen referensi yang baik, proses ini akan menjadi tidak efisien dan berpotensi menghasilkan bukti yang tidak akurat.

Selanjutnya, pada tahap *appraise*, referensi yang telah dikumpulkan perlu dianalisis kualitasnya melalui proses *critical appraisal*. Hal ini membutuhkan

pengelolaan referensi yang sistematis agar peneliti dapat membandingkan dan mensintesis berbagai hasil penelitian.

(Melnyk & Fineout-Overholt, 2019) menekankan bahwa keberhasilan implementasi EBN sangat dipengaruhi oleh kemampuan tenaga kesehatan dalam mengakses dan mengelola bukti ilmiah. Dengan demikian, manajemen referensi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga merupakan bagian dari kompetensi profesional perawat.

B. Jenis dan Sumber Referensi Ilmiah

Dalam riset keperawatan, kualitas suatu karya ilmiah sangat ditentukan oleh ketepatan dan kredibilitas sumber referensi yang digunakan. Oleh karena itu, peneliti perlu memahami klasifikasi sumber referensi ilmiah agar dapat memilih literatur yang sesuai dengan tujuan penelitian dan tingkat evidensi yang dibutuhkan dalam *Evidence-Based Nursing (EBN)*.

Secara umum, referensi ilmiah dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis utama, yaitu sumber primer, sekunder, dan tersier.

1. Sumber Primer

Sumber primer merupakan sumber informasi yang berasal langsung dari penelitian asli yang dilakukan oleh peneliti. Contoh sumber primer yang paling umum adalah artikel jurnal penelitian, laporan penelitian, disertasi, dan tesis. Sumber ini menyajikan data empiris, metodologi penelitian, serta hasil dan pembahasan secara langsung tanpa melalui interpretasi pihak lain.

Dalam konteks keperawatan berbasis bukti, sumber primer memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi karena memungkinkan peneliti untuk menilai secara langsung validitas, reliabilitas, serta kualitas metodologi penelitian yang digunakan. Oleh karena itu, sumber primer sangat penting dalam tahap *critical appraisal* untuk menentukan kekuatan bukti yang akan digunakan dalam praktik klinis (Polit & Beck, 2021).

2. Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan hasil analisis, sintesis, atau interpretasi dari berbagai sumber primer. Contoh sumber sekunder meliputi *systematic review*, *meta-analysis*, dan *literature review*. Sumber ini sangat penting dalam EBN karena memberikan ringkasan bukti terbaik yang telah melalui proses evaluasi kritis.

Systematic review menggabungkan hasil beberapa penelitian dengan metode yang sistematis dan transparan, sedangkan *meta-analysis* melakukan analisis statistik terhadap data gabungan dari berbagai studi untuk memperoleh kesimpulan yang lebih kuat. Dengan demikian, sumber sekunder

sering dianggap sebagai tingkat evidensi yang lebih tinggi dibandingkan sumber primer karena telah melalui proses sintesis ilmiah (Melnyk & Fineout-Overholt, 2019).

3. Sumber Tersier

Sumber tersier merupakan sumber yang menyajikan ringkasan atau kompilasi dari informasi yang berasal dari sumber primer dan sekunder. Contohnya meliputi buku teks, ensiklopedia, panduan klinis, serta pedoman praktik keperawatan.

Sumber tersier biasanya digunakan untuk memperoleh pemahaman dasar mengenai suatu konsep atau teori. Dalam pendidikan keperawatan, buku teks dan panduan klinis sering menjadi referensi awal sebelum mahasiswa melakukan penelusuran literatur yang lebih mendalam. Meskipun demikian, dalam penelitian ilmiah, penggunaan sumber tersier sebaiknya dilengkapi dengan sumber primer dan sekunder agar kualitas evidensi tetap terjaga (Association, 2020).

C. Database Literatur Ilmiah

Selain memahami jenis referensi ilmiah, peneliti keperawatan juga perlu memiliki keterampilan dalam menelusuri sumber literatur melalui database ilmiah yang kredibel. Database literatur ilmiah merupakan platform digital yang menyediakan akses terhadap berbagai publikasi ilmiah, seperti artikel jurnal, buku, laporan penelitian, dan prosiding. Penggunaan database yang tepat sangat penting dalam mendukung proses *Evidence-Based Nursing (EBN)*, terutama pada tahap pencarian dan pengumpulan bukti (*acquire*).

Pemanfaatan database ilmiah memungkinkan peneliti untuk memperoleh sumber informasi yang valid, mutakhir, dan relevan dengan topik penelitian. Selain itu, database yang terkurasi dengan baik juga membantu dalam meningkatkan kualitas literatur yang digunakan sehingga hasil penelitian menjadi lebih dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Melnyk & Fineout-Overholt, 2019)

Beberapa database literatur ilmiah yang umum digunakan dalam riset keperawatan antara lain sebagai berikut:

1. Google Scholar

Google Scholar merupakan mesin pencari akademik yang menyediakan akses luas terhadap berbagai sumber ilmiah, seperti artikel jurnal, tesis, disertasi, buku, dan prosiding konferensi. Platform ini sangat populer di kalangan mahasiswa karena mudah digunakan dan dapat diakses secara gratis.

Google Scholar sering digunakan sebagai langkah awal dalam penelusuran literatur karena memiliki cakupan yang luas dan mampu mengindeks berbagai jenis publikasi dari berbagai disiplin ilmu. Namun demikian, peneliti tetap perlu melakukan seleksi kritis terhadap sumber yang ditemukan karena tidak semua artikel yang tersedia memiliki kualitas ilmiah yang sama.

2. PubMed

PubMed merupakan database yang dikelola oleh National Library of Medicine (NLM) Amerika Serikat dan berfokus pada bidang kesehatan dan biomedis. Database ini menyediakan akses ke jutaan artikel ilmiah yang berasal dari jurnal-jurnal bereputasi internasional.

PubMed menjadi salah satu sumber utama dalam penelitian keperawatan berbasis bukti karena menyediakan artikel dengan tingkat evidensi yang tinggi, termasuk *randomized controlled trials*, *systematic reviews*, dan *clinical guidelines*. Selain itu, PubMed juga dilengkapi dengan fitur pencarian lanjutan yang memungkinkan peneliti menyaring artikel berdasarkan jenis studi, tahun publikasi, dan kata kunci tertentu.

3. ScienceDirect

ScienceDirect merupakan platform yang dikembangkan oleh penerbit Elsevier dan menyediakan akses ke jurnal serta buku ilmiah berkualitas tinggi, khususnya di bidang kesehatan, kedokteran, dan ilmu terapan.

Keunggulan utama ScienceDirect adalah ketersediaan artikel *full-text* yang lengkap serta kualitas publikasi yang telah melalui proses *peer-review*. Database ini sangat bermanfaat bagi peneliti yang membutuhkan literatur mendalam untuk mendukung analisis dan pembahasan dalam penelitian keperawatan.

4. Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Directory of Open Access Journals (DOAJ) merupakan database yang menyediakan akses ke jurnal ilmiah *open access* yang dapat diunduh secara gratis. DOAJ menghimpun jurnal-jurnal yang telah melalui proses seleksi kualitas sehingga tetap dapat dipercaya meskipun tersedia secara bebas.

Keberadaan DOAJ sangat membantu mahasiswa dan peneliti, terutama yang memiliki keterbatasan akses terhadap jurnal berbayar. Dengan memanfaatkan database ini, peneliti tetap dapat memperoleh literatur ilmiah yang berkualitas tanpa hambatan biaya.

D. Pentingnya Pemanfaatan Database Ilmiah Yang Tepat

Pemilihan database literatur ilmiah yang tepat merupakan langkah krusial dalam proses penelitian keperawatan. Database yang digunakan akan sangat menentukan kualitas, kedalaman, dan relevansi sumber informasi yang diperoleh. Dalam konteks *Evidence-Based Nursing (EBN)*, penggunaan sumber yang kredibel menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan klinis yang aman, efektif, dan berbasis bukti.

Database ilmiah yang terpercaya umumnya telah melalui proses kurasi dan seleksi yang ketat, sehingga hanya memuat publikasi yang memenuhi standar akademik tertentu. Dengan memanfaatkan database yang tepat, peneliti dapat memperoleh sumber literatur yang:

1. **Valid dan terpercaya**, karena berasal dari jurnal yang telah melalui proses *peer-review*
2. **Relevan dengan topik penelitian**, sehingga mendukung fokus dan tujuan penelitian
3. **Mutakhir (***up-to-date***)**, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan terbaru
4. **Memiliki tingkat evidensi yang tinggi**, seperti *randomized controlled trials*, *systematic review*, dan *clinical guidelines*

Sebaliknya, penggunaan sumber yang tidak terverifikasi—seperti artikel tanpa proses penelaahan sejawat (*non-peer-reviewed*) atau sumber dari platform yang tidak kredibel—dapat menurunkan kualitas penelitian. Hal ini berpotensi menyebabkan kesalahan dalam interpretasi data, bias dalam penarikan kesimpulan, serta menurunkan validitas hasil penelitian secara keseluruhan.

(Melnyk & Fineout-Overholt, 2019) menegaskan bahwa kualitas bukti ilmiah yang digunakan dalam praktik keperawatan sangat bergantung pada kemampuan tenaga kesehatan dalam mengakses dan memilih sumber literatur yang tepat. Oleh karena itu, pemilihan database tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga merupakan bagian dari kompetensi profesional dalam praktik berbasis bukti.

Dengan demikian, kemampuan dalam memilih jenis referensi serta menelusuri database ilmiah secara efektif merupakan keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh mahasiswa dan peneliti keperawatan. Keterampilan ini tidak hanya mendukung penyusunan karya ilmiah yang berkualitas, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan mutu pelayanan keperawatan melalui penerapan praktik berbasis bukti.

E. Teknik Sitasi Dalam Penulisan Ilmiah

Sitasi merupakan cara untuk memberikan pengakuan terhadap sumber asli yang digunakan dalam karya ilmiah. Dalam penulisan ilmiah keperawatan, sitasi tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penghargaan terhadap karya orang lain, tetapi juga sebagai indikator kredibilitas dan keabsahan informasi yang digunakan. Penggunaan teknik sitasi yang benar sangat penting untuk menghindari plagiarisme serta menjaga integritas akademik.

Jenis Sitasi

Secara umum, terdapat dua jenis sitasi yang digunakan dalam penulisan ilmiah, yaitu:

1. **Sitasi langsung (kutipan langsung)**
   Sitasi langsung dilakukan dengan mengutip kalimat atau pernyataan dari sumber asli secara persis. Kutipan langsung biasanya digunakan jika pernyataan tersebut memiliki makna yang sangat spesifik atau tidak dapat diubah.
2. **Sitasi tidak langsung (parafrase)**
   Sitasi tidak langsung dilakukan dengan menyampaikan kembali ide atau informasi dari sumber menggunakan bahasa sendiri tanpa mengubah makna aslinya.

Dalam praktik penulisan ilmiah, parafrase lebih dianjurkan karena menunjukkan pemahaman penulis terhadap materi yang dikutip serta menghindari ketergantungan pada kutipan langsung (Wallwork, 2016)

Kesalahan Umum dalam Sitasi

Beberapa kesalahan yang sering terjadi dalam penulisan sitasi antara lain:

1. Tidak mencantumkan sumber referensi
2. Format sitasi yang tidak konsisten
3. Sumber yang disitasi dalam teks tidak dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Penggunaan *et al.* yang tidak tepat

Kesalahan-kesalahan tersebut dapat menurunkan kualitas karya ilmiah dan berpotensi dianggap sebagai pelanggaran akademik.

F. Software Manajemen Referensi

Perkembangan teknologi telah menghadirkan berbagai perangkat lunak yang membantu peneliti dalam mengelola referensi secara lebih efisien dan sistematis. Penggunaan software ini sangat direkomendasikan dalam penulisan ilmiah karena dapat mengurangi kesalahan sitasi serta mempercepat proses penyusunan daftar pustaka.

1. Mendeley

Mendeley merupakan salah satu software manajemen referensi yang paling banyak digunakan oleh mahasiswa dan peneliti. Software ini bersifat gratis dan memiliki berbagai fitur yang mendukung penulisan ilmiah, seperti:

a. Penyimpanan dan pengelolaan artikel
b. Anotasi file PDF
c. Integrasi dengan Microsoft Word
d. Pembuatan sitasi otomatis

2. Zotero

Zotero adalah software manajemen referensi berbasis open-source yang memiliki keunggulan dalam pengambilan referensi secara langsung dari browser. Dengan menggunakan *browser connector*, pengguna dapat menyimpan artikel hanya dengan satu klik.

3. EndNote

EndNote merupakan software manajemen referensi yang banyak digunakan oleh peneliti tingkat lanjut. Software ini memiliki fitur yang lebih kompleks dan mendukung pengelolaan referensi dalam jumlah besar, namun bersifat berbayar dan biasanya tersedia melalui lisensi institusi.

Penggunaan software manajemen referensi terbukti dapat meningkatkan efisiensi penulisan ilmiah serta mengurangi kesalahan dalam sitasi (Singh, 2021)

G. Format File Referensi: Ris dan Bibtex

Dalam pertukaran data referensi, digunakan format standar seperti RIS dan BibTeX yang memungkinkan interoperabilitas antar berbagai software manajemen referensi.

1. RIS (Research Information System)

Format ini banyak digunakan pada database seperti PubMed, Scopus, dan Google Scholar. File RIS memungkinkan pengguna untuk mengimpor metadata referensi secara otomatis ke dalam software seperti Mendeley atau Zotero.

2. BibTeX

Format ini umumnya digunakan dalam sistem LaTeX dan banyak digunakan dalam penulisan ilmiah di bidang teknik dan sains.

Penggunaan format ini membantu peneliti dalam menghemat waktu serta meminimalkan kesalahan input data referensi.

H. Plagiarisme dan Integritas Akademik

Plagiarisme merupakan tindakan menggunakan karya, ide, atau gagasan orang lain tanpa memberikan pengakuan yang semestinya. Dalam dunia akademik, plagiarisme merupakan pelanggaran serius yang dapat berdampak pada reputasi, kredibilitas, bahkan karier profesional seseorang.

Jenis plagiarisme meliputi:

1. **Plagiarisme langsung** → menyalin tanpa perubahan
2. **Plagiarisme mosaik** → menggabungkan berbagai sumber tanpa sitasi jelas
3. **Self-plagiarism** → menggunakan kembali karya sendiri tanpa atribusi

(Bretag, 2016) menekankan bahwa pendidikan mengenai integritas akademik sangat penting untuk mencegah praktik plagiarisme sejak dini.

1. **Upaya Pencegahan Plagiarisme**
2. Menggunakan sitasi yang benar
3. Melakukan parafrase dengan baik
4. Menggunakan software deteksi plagiarisme seperti Turnitin
5. Mengelola referensi secara sistematis

I. Integrasi Referensi Dengan Microsoft Word

Integrasi ini sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi penulisan ilmiah, terutama dalam penyusunan skripsi, tesis, disertasi, dan artikel jurnal.

Salah satu keunggulan utama penggunaan software manajemen referensi dalam penulisan ilmiah adalah kemampuannya untuk terintegrasi secara langsung dengan Microsoft Word. Integrasi ini memungkinkan penulis untuk mengelola sitasi dan daftar pustaka secara otomatis, sehingga meningkatkan efisiensi, akurasi, dan konsistensi dalam penulisan karya ilmiah.

Dalam konteks riset keperawatan dan *Evidence-Based Nursing (EBN)*, penggunaan teknologi ini sangat membantu mahasiswa dan peneliti dalam menyusun dokumen ilmiah yang sesuai dengan standar akademik internasional. Dengan memanfaatkan fitur integrasi ini, proses penulisan yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat diotomatisasi secara sistematis.

1. Fungsi Utama Integrasi Referensi

Integrasi antara software manajemen referensi (seperti Mendeley, Zotero, atau EndNote) dengan Microsoft Word memungkinkan penulis untuk:

a. Menyisipkan sitasi secara otomatis ke dalam teks

Penulis dapat menambahkan referensi langsung pada bagian tertentu dalam dokumen tanpa perlu mengetik manual. Sistem akan secara otomatis menyesuaikan format sitasi sesuai gaya yang dipilih.

b. Mengubah gaya sitasi dengan satu klik

Gaya sitasi seperti APA, Vancouver, Harvard, dan lainnya dapat diubah secara instan tanpa perlu mengedit satu per satu. Hal ini sangat membantu ketika penulis harus menyesuaikan format dengan ketentuan jurnal atau institusi.

c. Membuat daftar pustaka secara otomatis

Semua referensi yang telah disitasi dalam teks akan secara otomatis dikompilasi menjadi daftar pustaka yang tersusun rapi sesuai aturan gaya sitasi yang digunakan.

2. Cara Integrasi dengan Microsoft Word (Langkah Praktis)

Berikut langkah umum integrasi menggunakan software manajemen referensi:

a. *Instal Plugin Word*

1) Mendeley: gunakan **Mendeley Cite**
2) Zotero: install **Zotero Word Plugin**
3) EndNote: plugin biasanya otomatis terpasang

Buka Microsoft Word

Setelah plugin terpasang, akan muncul menu tambahan seperti:

1) *References* → Mendeley Cite / Zotero / EndNote

b. **Menyisipkan Sitasi**

1) Klik **Insert Citation**
2) Pilih referensi dari library
3) Sitasi otomatis muncul dalam teks

c. **Membuat Daftar Pustaka**

1) Klik **Insert Bibliography**
2) Daftar pustaka akan muncul otomatis

d. **Mengubah Style Sitasi**

1) Pilih style (misalnya APA 7th Edition)
2) Sistem akan menyesuaikan seluruh sitasi dan daftar pustaka

3. Keunggulan Integrasi Referensi

Penggunaan integrasi referensi dengan Microsoft Word memberikan berbagai keuntungan, antara lain:

a. **Efisiensi waktu** dalam penulisan
b. **Mengurangi kesalahan format sitasi**

c. **Konsistensi dalam daftar pustaka**
d. **Memudahkan revisi dan editing**
e. **Mendukung penulisan ilmiah berskala besar** (skripsi, tesis, disertasi, artikel jurnal)

Menurut (Singh, 2021), penggunaan software manajemen referensi secara signifikan meningkatkan efisiensi penulisan ilmiah dan mengurangi kesalahan sitasi.

J. Strategi Pencarian Literatur

Strategi pencarian literatur merupakan langkah awal yang sangat penting dalam proses telaah pustaka. Pencarian yang sistematis, terstruktur, dan dapat direplikasi akan menghasilkan sumber literatur yang relevan, berkualitas, serta mendukung validitas penelitian. Dalam konteks *Evidence-Based Nursing (EBN)*, strategi pencarian literatur menjadi bagian dari tahap *acquire*, yaitu proses memperoleh bukti ilmiah terbaik untuk menjawab pertanyaan klinis atau penelitian (Melnyk & Fineout-Overholt, 2019)

Strategi pencarian literatur tidak dilakukan secara acak, melainkan melalui tahapan yang jelas, meliputi penentuan kata kunci, penggunaan operator Boolean, penyusunan framework pencarian, penetapan kriteria seleksi, serta dokumentasi proses pencarian.

1. Penentuan Kata Kunci (Keywords)

Langkah awal dalam pencarian literatur adalah menentukan kata kunci (*keywords*) yang sesuai dengan topik penelitian. Kata kunci merupakan istilah utama yang mewakili konsep atau variabel dalam penelitian. Pemilihan kata kunci yang tepat akan sangat memengaruhi hasil pencarian literatur.

Kata kunci biasanya diambil dari:

a. Variabel penelitian
b. Masalah penelitian
c. Komponen pertanyaan penelitian

Sebagai contoh, pada topik penelitian mengenai stunting, kata kunci yang dapat digunakan antara lain:

a. *Stunting*
b. *Child nutrition*
c. *Family participation*
d. *Nursing intervention*

Untuk meningkatkan sensitivitas pencarian, peneliti dianjurkan menggunakan sinonim atau istilah terkait. Misalnya, istilah *stunting* dapat

dikombinasikan dengan *growth faltering* atau *chronic malnutrition*. Penggunaan sinonim ini bertujuan untuk memperluas cakupan hasil pencarian sehingga tidak ada literatur penting yang terlewat (Polit & Beck, 2021)

2. Penggunaan Operator Boolean

Operator Boolean digunakan untuk mengombinasikan kata kunci dalam proses pencarian literatur agar hasil yang diperoleh lebih spesifik dan terarah. Terdapat tiga operator utama yang digunakan, yaitu AND, OR, dan NOT.

a. AND digunakan untuk mempersempit pencarian dengan menggabungkan dua atau lebih kata kunci.
   Contoh:
   stunting AND family support
   Hasil pencarian hanya akan menampilkan artikel yang memuat kedua istilah tersebut.
b. OR digunakan untuk memperluas pencarian dengan memasukkan sinonim atau istilah yang memiliki makna serupa.
   Contoh: *stunting OR growth faltering*
   Hasil pencarian akan mencakup artikel yang memuat salah satu atau kedua istilah tersebut.
c. NOT digunakan untuk mengecualikan istilah tertentu yang tidak relevan.
   Contoh:
   stunting NOT obesity

Penggunaan operator Boolean secara tepat akan meningkatkan efisiensi pencarian dan membantu peneliti mendapatkan literatur yang relevan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

3. Framework Pencarian (PICO/PICOT)

Framework PICO (Population, Intervention, Comparison, Outcome) merupakan alat yang digunakan untuk menyusun pertanyaan penelitian secara sistematis dan terstruktur. Framework ini sangat membantu dalam menentukan fokus pencarian literatur, terutama dalam penelitian berbasis intervensi.

Komponen PICO meliputi:

P (Population): kelompok atau populasi yang diteliti

I (Intervention): intervensi yang diberikan

C (Comparison): pembanding (jika ada)

O (Outcome): hasil yang diharapkan

Contoh penerapan: Pada balita (P), apakah edukasi keluarga (I) dibandingkan tanpa edukasi (C) dapat meningkatkan status gizi (O)? Dalam pengembangan lebih lanjut, PICO dapat diperluas menjadi PICOT dengan tambahan: T (Time): periode waktu pengamatan

Penggunaan framework ini membantu peneliti dalam menyusun strategi pencarian yang lebih fokus dan sistematis.

4. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Setelah mendapatkan hasil pencarian literatur, langkah selanjutnya adalah melakukan seleksi artikel menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria ini bertujuan untuk menyaring literatur agar hanya artikel yang relevan dan berkualitas yang digunakan dalam penelitian.

Kriteria inklusi merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh artikel, misalnya:

a. Artikel dipublikasikan dalam 5–10 tahun terakhir
b. Tersedia dalam bentuk *full-text*
c. Menggunakan bahasa Inggris atau Indonesia
d. Relevan dengan topik penelitian

Kriteria eksklusi merupakan kondisi yang menyebabkan artikel tidak digunakan, misalnya:

a. Artikel duplikat
b. Tidak sesuai dengan topik penelitian
c. Bukan merupakan penelitian ilmiah (misalnya opini atau editorial)

Penetapan kriteria ini penting untuk menjaga konsistensi dan transparansi dalam proses seleksi literatur, serta memastikan bahwa proses pencarian dapat direplikasi oleh peneliti lain.

5. Dokumentasi Proses Pencarian

Tahap akhir dalam strategi pencarian literatur adalah dokumentasi seluruh proses yang telah dilakukan. Dokumentasi ini merupakan bagian penting dalam penelitian ilmiah karena berkaitan dengan transparansi dan reprodusibilitas.

Hal-hal yang perlu didokumentasikan meliputi:

Database yang digunakan (misalnya PubMed, Google Scholar)

a. Kata kunci dan kombinasi pencarian
b. Jumlah artikel yang ditemukan
c. Tahapan seleksi artikel (screening)
d. Jumlah artikel yang digunakan dalam analisis

Dokumentasi yang baik memungkinkan peneliti lain untuk mengulangi proses pencarian dengan metode yang sama dan memperoleh hasil yang serupa. Selain itu, dokumentasi ini juga menjadi dasar dalam penyusunan diagram alur seleksi literatur, seperti diagram PRISMA yang sering digunakan dalam *systematic review*.

K. Manajemen Referensi dan Sintesis Literatur

Manajemen referensi dan sintesis literatur merupakan tahapan lanjutan setelah proses pencarian literatur. Pada tahap ini, peneliti tidak hanya mengumpulkan artikel, tetapi juga mengorganisasi, menganalisis, dan mengintegrasikan berbagai hasil penelitian menjadi suatu pemahaman yang komprehensif. Dalam konteks riset keperawatan dan *Evidence-Based Nursing (EBN)*, kemampuan ini sangat penting untuk menghasilkan kesimpulan yang berbasis bukti serta mendukung pengambilan keputusan klinis yang tepat (Polit & Beck, 2021)

1. Pengelolaan Referensi

Pengelolaan referensi adalah proses mengorganisasi sumber literatur secara sistematis agar mudah diakses dan digunakan dalam penulisan ilmiah. Pengelolaan yang baik akan meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan sitasi, serta membantu menjaga konsistensi dalam penulisan daftar pustaka.

Beberapa langkah dalam pengelolaan referensi meliputi:

a. **Menggunakan software manajemen referensi,** seperti Mendeley atau Zotero, untuk menyimpan dan mengelola artikel secara digital
b. **Mengelompokkan artikel berdasarkan tema atau variabel penelitian**, misalnya intervensi, faktor risiko, atau outcome
c. **Menyimpan metadata artikel**, seperti nama penulis, tahun, judul, jurnal, dan DOI, sehingga memudahkan proses sitasi

Dengan pengelolaan referensi yang baik, peneliti dapat dengan mudah menemukan kembali artikel yang dibutuhkan serta menyusun karya ilmiah secara lebih sistematis dan efisien (Wallwork, 2016)

2. Sintesis Literatur

Sintesis literatur merupakan proses mengintegrasikan hasil dari berbagai penelitian untuk menghasilkan kesimpulan yang terstruktur dan bermakna. Sintesis tidak hanya berupa rangkuman isi artikel, tetapi melibatkan analisis kritis terhadap berbagai temuan penelitian.

Dalam sintesis literatur, peneliti diharapkan mampu:

a. **Membandingkan hasil antar penelitian**, baik yang memiliki kesamaan maupun perbedaan
b. **Mengidentifikasi pola atau tren temuan**, misalnya efektivitas suatu intervensi
c. **Menemukan kesenjangan penelitian (***research gap***)**, yaitu area yang belum banyak diteliti atau masih memiliki hasil yang inkonsisten

Sintesis yang baik akan menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap suatu topik serta menjadi dasar dalam penyusunan kerangka konsep dan hipotesis penelitian. (Melnyk & Fineout-Overholt, 2019) menekankan bahwa sintesis literatur merupakan langkah penting dalam praktik berbasis bukti karena membantu dalam menentukan intervensi yang paling efektif.

3. Matriks Literatur (Matriks Temuan)

Matriks literatur merupakan alat bantu yang digunakan untuk merangkum dan mengorganisasi hasil penelitian secara sistematis dalam bentuk tabel. Matriks ini memudahkan peneliti dalam membandingkan berbagai artikel secara cepat dan terstruktur.

Contoh format matriks literatur:

Penulis	Tahun	Tujuan	Metode	Sampel	Hasil
A	2022	Edukasi stunting	RCT	100 ibu	Meningkatkan pengetahuan

Dalam praktiknya, matriks literatur dapat dikembangkan dengan menambahkan kolom lain seperti variabel, instrumen, atau temuan utama.

Penggunaan matriks literatur memiliki beberapa manfaat, antara lain:

a. **Mempermudah analisis literatur secara cepat**
b. **Mendukung penyusunan pembahasan yang sistematis**
c. **Membantu dalam mengidentifikasi kesenjangan penelitian**
d. **Menjadi dasar dalam penyusunan kerangka konsep**

Dengan demikian, matriks literatur tidak hanya berfungsi sebagai alat ringkasan, tetapi juga sebagai instrumen analisis yang membantu peneliti dalam menyusun sintesis literatur yang kuat dan berbasis bukti.

L. Aktivitas 1 — Knows How (Mini Case)

Kasus:

Seorang mahasiswa keperawatan sedang menyusun proposal penelitian tentang pencegahan stunting. Mahasiswa tersebut mengambil beberapa paragraf dari artikel jurnal tanpa mencantumkan sumber dan hanya menuliskan daftar pustaka di akhir tanpa sitasi dalam teks.

Pertanyaan Diskusi:

1. Identifikasi kesalahan yang dilakukan mahasiswa tersebut.
2. Apakah tindakan tersebut termasuk plagiarisme? Jelaskan.
3. Bagaimana cara memperbaiki penulisan tersebut?
4. Software apa yang dapat membantu menghindari kesalahan tersebut?

M. Aktivitas 2 — Shows How (Praktikum)

Simulasi: Penggunaan Mendeley

Mahasiswa diminta untuk:

1. Mengunduh 3 artikel jurnal dari Google Scholar
2. Mengimpor file RIS ke Mendeley/Zotero
3. Menyusun sitasi dalam Microsoft Word
4. Membuat daftar pustaka otomatis dengan APA Style

N. Latihan

1. Buat 3 contoh sitasi:
   a. Buku
   b. Artikel jurnal
   c. Website WHO
2. Identifikasi kesalahan sitasi pada contoh yang diberikan dosen
3. Praktik:
   a. Import 5 artikel ke Mendeley
   b. Generate daftar pustaka

O. Rangkuman Materi

Manajemen referensi merupakan bagian penting dalam penulisan ilmiah keperawatan. Penggunaan gaya sitasi yang tepat, seperti APA Style, membantu menjaga konsistensi dan kredibilitas karya ilmiah. Software manajemen referensi mempermudah pengelolaan literatur dan mengurangi risiko kesalahan sitasi.

Selain itu, pemahaman tentang plagiarisme sangat penting untuk menjaga integritas akademik.

P. Daftar Pustaka

Association, A. P. (2020). *Publication manual of the American Psychological Association (7th ed.)*.

Bretag, T. (2016). *Handbook of academic integrity*. Springer.

Melnyk, B. M., & Fineout-Overholt, E. (2019). *Evidence-based practice in nursing & healthcare*. Wolters Kluwer.

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2021). *Nursing research: Generating and assessing evidence for nursing practice*. Wolters Kluwer.

Singh, J. (2021). Reference management software in academic writing: A review. *Journal of Academic Writing*, *11*(2), 45–55.

Wallwork, A. (2016). *English for writing research papers*. Springer.

Q. Glosarium

APA: American Psychological Association

EBN: Evidence-Based Nursing

RIS: Format file referensi

BibTeX: Format referensi berbasis LaTeX

Plagiarisme: Penggunaan karya tanpa sumber

DOI: Identitas digital artikel

BAB 4

KERANGKA TEORI, KERANGKA KONSEP, DAN HIPOTESIS

Tabel CPL

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-2	Mampu mengidentifikasi masalah keperawatan/praktik, merumuskan pertanyaan penelitian/EBN, serta menetapkan tujuan yang terukur.	CPMK-2; CPMK-3
CPL-3	Mampu merancang metode penelitian (kuantitatif/kualitatif) termasuk desain, populasi–sampel, sampling, instrumen, dan prosedur pengumpulan/manajemen data secara sistematis.	CPMK-4; CPMK-5

Tabel CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-4	Menentukan desain penelitian kuantitatif/kualitatif yang sesuai, termasuk populasi–sampel, teknik sampling, dan kontrol kualitas metodologis.
CPMK-5	Menyusun instrumen dan rencana pengukuran, prosedur pengumpulan data, serta manajemen data (keamanan, kerahasiaan, kualitas) yang dapat diaudit.
CPMK-6	Melakukan analisis data kuantitatif dasar dan analisis data kualitatif, serta menyajikan temuan dalam format ilmiah yang jelas.
CPMK-7	Melakukan critical appraisal dan menetapkan tingkat bukti, merancang implementasi EBN di praktik, serta menyusun proposal/skripsi/manuskrip sesuai kaidah ilmiah.

Tabel Pemetaan Bab–Sub-CPMK–CPMK

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 4. Kerangka Teori, Kerangka Konsep, dan Hipotesis	4.1 Menyusun kerangka teori/konsep dan definisi operasional konsep/variabel sesuai literatur.	4.2 Merumuskan hipotesis/rumusan konseptual dan arah hubungan antar-variabel/konsep secara logis.	CPMK-3	CPMK-4; CPMK-2

Tabel Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-1	Ujian tulis (CBT/essay terstruktur)	Persentase jawaban benar konsep inti EBN/etika dan ketepatan identifikasi isu etik pada skenario.	10	Nilai ujian; lembar jawaban
CPMK-2	Tugas perumusan masalah & pertanyaan (template PICOT/SPIDER)	Ketepatan struktur pertanyaan (komponen lengkap) dan keterukuran tujuan/outcome (skor rubrik).	10	Dokumen pertanyaan & tujuan
CPMK-3	Tugas telaah pustaka ringkas + matriks literatur	Reproducibility strategi pencarian (kriteria jelas) dan kualitas sintesis/kerangka konsep (skor rubrik).	15	Matriks literatur; kerangka konsep
CPMK-4	Ujian/penugasan rancangan metode (protocol brief)	Kesesuaian desain dengan pertanyaan dan ketepatan rencana	15	Protocol brief metode

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
		sampling/ukuran sampel (skor rubrik).		
CPMK-5	Penugasan instrumen + SOP pengumpulan/manajemen data	Kesesuaian instrumen–skala ukur dan kelengkapan SOP/manajemen data (checklist/rubrik).	15	Draft instrumen; SOP; data dictionary
CPMK-6	Praktikum analisis data (dataset/skenario) + laporan singkat	Akurasi pemilihan analisis dan interpretasi output serta kualitas penyajian temuan (skor rubrik).	15	File/hasil analisis; laporan ringkas
CPMK-7	Proyek mini EBN + critical appraisal + draft proposal/manuskrip	Ketepatan appraisal (risiko bias/tingkat bukti) dan keterukuran rencana implementasi/struktur dokumen ilmiah (skor rubrik).	20	Form appraisal; rencana implementasi; proposal/manuskrip

Rubrik CPMK-2

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Kualitas struktur pertanyaan (kelengkapan komponen)	Komponen tidak lengkap; fokus tidak jelas	Komponen cukup; fokus masih melebar	Komponen lengkap; fokus jelas	Komponen sangat lengkap; sangat fokus dan operasional
2.2 Keterukuran tujuan/outcome & kelayakan (feasibility)	Tidak terukur; tidak feasible	Sebagian terukur; feasibility belum jelas	Terukur; feasibility logis	Sangat terukur; feasibility kuat dengan batasan jelas

Rubrik CPMK-3

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Reproducibility strategi pencarian & seleksi literatur	Tidak sistematis; tidak dapat diulang	Cukup sistematis; detail kurang	Sistematis; detail memadai untuk diulang	Sangat sistematis; transparan (query, kriteria, alur seleksi)
3.2 Kualitas sintesis & kerangka konsep/hipotesis	Sintesis lemah; kerangka tidak logis	Sintesis ada; kerangka kurang kuat	Sintesis baik; kerangka logis berbasis literatur	Sintesis sangat kuat; kerangka koheren dan menunjukkan gap jelas

Rubrik CPMK-4

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Kesesuaian desain dengan pertanyaan & kontrol bias	Desain tidak sesuai; bias tidak dipertimbangkan	Desain cukup sesuai; kontrol bias terbatas	Desain sesuai; kontrol bias jelas	Desain sangat sesuai; kontrol bias komprehensif dan realistis
4.2 Ketepatan rencana sampling (kriteria, ukuran, teknik)	Tidak jelas/keliru; tidak dapat dilaksanakan	Cukup jelas; masih ada kekurangan bermakna	Jelas; dapat dilaksanakan; justifikasi memadai	Sangat jelas; justifikasi kuat; mempertimbangkan keterbatasan dan mitigasi

Uraian Materi

Pada bagian ini, penulis hanya ingin berfokus pada penjelasan terkait Kerangka Teori, Kerangka Konsep dan Hipotesis Penelitian. Penyusunan kerangka konsep yang baik akan membantu peneliti dalam mengembangkan an pola piker ilmiah berdasarkan pengetahuan pada kerangka teori untuk menyelesaikan permasalahan penelitian. Kerangka konsep dapat menjelaskan hubungan atau kaitan antara konsep satu dengan yang lain dari masalah penelitian yang ingin diteliti sehingga dapat menghasilkan kesimpulan penelitian yang dapat digunakan untuk rekomendasi penelitian.

Penjabaran lingkup Kerangka Teori, Kerangka Konsep dan Hipotesisi penelitian meliputi:

1. Menjelaskan tentang Kerangka Teori penelitian,
2. Menjelaskan tentang Kerangka konsep penelitian,
3. Menjelaskan tentang variabel penelitan skala pengukuran data
4. Menjelaskan tentang hipotesis penelitian
5. Menyajikan Kerangka Teori, Kerangka Konsep, Variabel penelitian, skala pengukuran data dan hipotesis penelitian
6. Menyusun Kerangka Teori, Kerangka Konsep, Variabel dan hipotesis penelitian

A. Pengertian Kerangka Teori Penelitian

Kerangka teori penelitian adalah kumpulan konsep, teori, dan hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai landasan ilmiah dalam menjelaskan fenomena penelitian serta hubungan antarvariabel yang diteliti. Kerangka teori membantu peneliti memahami masalah penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kerangka konsep dan hipotesis penelitian.

Menurut teori metodologi penelitian, kerangka teori merupakan bagian penting dalam penelitian karena berfungsi menjelaskan mengapa suatu variabel dapat memengaruhi variabel lainnya (Notoatmodjo, 2018).

Kerangka teori membantu peneliti untuk:

1. memahami masalah penelitian secara ilmiah,
2. menjelaskan hubungan antarvariabel,
3. menyusun kerangka konseptual,
4. dan merumuskan hipotesis penelitian.

Dengan kata lain, kerangka teori menjadi dasar berpikir dalam penelitian.

Ciri-Ciri Kerangka Teori

1. Berasal dari teori atau hasil penelitian terdahulu.
2. Memuat konsep-konsep yang relevan dengan penelitian.
3. Menjelaskan hubungan antarvariabel.
4. Disusun secara sistematis dan logis.
5. Menjadi dasar penyusunan hipotesis.

Fungsi Kerangka Teori

1. Sebagai Landasan Penelitian: Menjadi dasar ilmiah dalam menjelaskan fenomena yang diteliti.
2. Membantu Menentukan Variabel: Menjelaskan variabel independen, dependen, mediator, atau moderator.
3. Menjelaskan Hubungan Antarvariabel: Menggambarkan mengapa suatu variabel dapat memengaruhi variabel lain.
4. Menjadi Dasar Hipotesis: Hipotesis disusun berdasarkan teori yang digunakan.
5. Membantu Analisis Data: Hasil penelitian nantinya dibandingkan dengan teori yang digunakan.

Contoh Sederhana

Judul Penelitian

"Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Anemia pada Remaja Puteri"

Kerangka Teori

Peneliti menggunakan:

1. teori status gizi,
2. teori perilaku kesehatan,
3. teori sosial ekonomi kesehatan.

Teori tersebut menjelaskan bahwa:

1. sosial ekonomi memengaruhi kualitas makanan,
2. pola asuh memengaruhi kebiasaan makan,
3. status gizi (berat badan dan tinggi badan) berkaitan dengan kecukupan zat besi,
4. sehingga dapat memengaruhi kejadian anemia.

Perbedaan Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

Kerangka Teori	Kerangka Konseptual
Berisi teori dan pendapat ahli	Berisi hubungan variabel penelitian
Bersifat luas dan teoritis	Bersifat spesifik sesuai penelitian
Menjadi dasar penelitian	Menjadi model/alur penelitian
Diambil dari literatur	Disusun peneliti berdasarkan teori

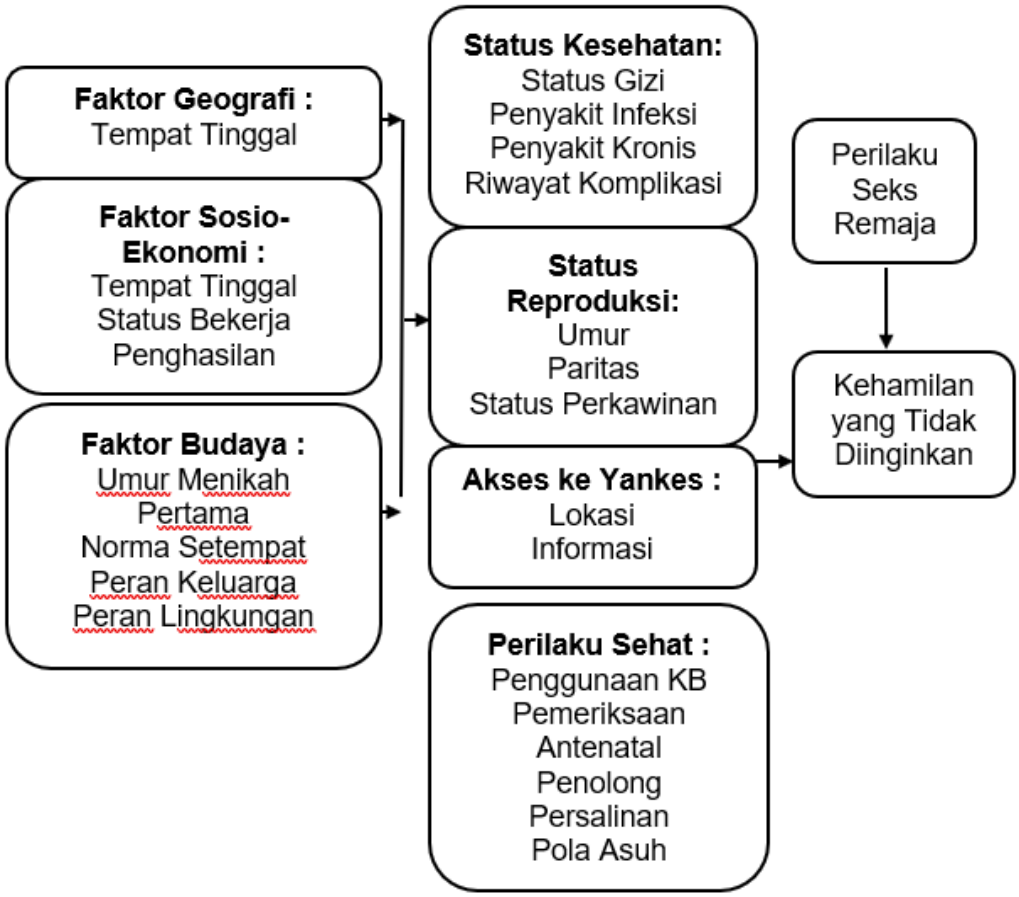
Ilustrasi Hubungan
Teori/konsep para ahli
↓
Kerangka Teori
↓
Kerangka Konseptual
↓
Hipotesis Penelitian
↓
Pengumpulan & Analisis Data

Kesimpulan

Kerangka teori adalah dasar ilmiah yang menjelaskan konsep dan hubungan antarvariabel dalam penelitian berdasarkan teori atau hasil penelitian sebelumnya. Kerangka teori menjadi fondasi utama dalam menyusun kerangka konseptual dan hipotesis penelitian.

1. **Kerangka Teori** Modifikasi Kerangka Mc Carthy dan Maine (Mc Carthy and Maine (1992)

Distans Determinants Intermediet Determinants Outcomes Determinants

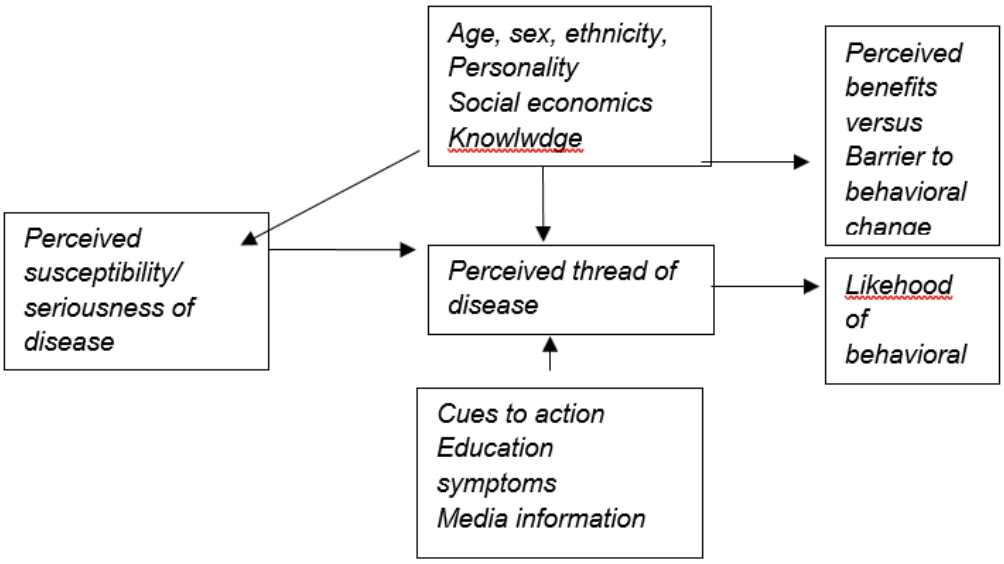


Gambar 4.1: Modifikasi Kerangka Mc Carthy dan Maine
(Mc Carthy and Maine (1992) dalam Depkes (2007

B. Teori Health Belief Model (HBM)

Teori *Health Belief Model* (HBM) menjadi acuan untuk menjelaskan faktor intra personal atau individu meliputi umur, gender, pendidikan, pekerjaan, etnis, kepribadian, sosial ekonomi, pengetahuan, sikap dan nilai. Teori ini yang mendukung untuk faktor intra personal. *The Health Belief Model* (Model keyakinan yang berkaitan dengan kesehatan) merupakan model psikologis yang berupaya utuk menjelaskan dan meprediksi perilaku kesehatan. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan sikap dan keyakinan individu. HBM dikembangkan pertama kali pada tahun 1950 oleh para pakar psikologi sosial Hochbaum, Rosenstock dan Kegels yang bekerja untuk *Public Health Service AS*. Model ini dikembangkan dalam rangka merespon kegagalan dalam program skrining kesehatan sukarela untuk TBC. Sejak saat itu HBM terus diadaptasi dan digali untuk mengeksplorasi perilaku sehat jangka pendek maupun menengah, termasuk perilaku sexual dan penyebaran HIV/AIDS.

HBM didasari oleh pemahaman bahwa seseorang akan melakukan tindakan jika dia: (1) Merasakan bahwa suatu kondisi kesehatan negatif dapat dihindari, (2) Punya harapan positif bahwa dengan tindakan yang dia ambil, dia akan terhindar dari kondisi kesehatan yang negatif (misalnya menggunakan kondom cara terbaik/efektif untuk mencegah HIV), dan (3) percaya bahwa dia bisa berhasil dengan tindakan sehat yang direkomendasikan (ia menggunakan kondom dengan nyaman dan yakin). HBM perlu dijelaskan dalam pemahaman empat konstruksi yang menggambarkan ancaman yang bakal dirasakan/ diperkirakan dan manfaat pokok: Kerentanan dibayangkan *(perceived susceptibility);* Seburuk apa yang dia bayangkan *(perceived severity);* manfaat yang dia bayangkan *(perceived be (perceived benefit);* dan rintangan/halangan yang dibayangkan *(perceived barriers).* Konsep ini diusulkan sebagai langkah kesiapan untuk bertindak. Konsep tambahan terakhir bagi HBM adalah konsep *Self Efficacy* atau keyakinan seseorang akan kemampuannya untuk melakukan suatu tindakan dengan berhasil. Konsep ini ditambah oleh Rosenstock *et al.,* pada tahun 1988 untuk membantu HBM mampu menantang kebiasaan yang tidak sehat, misalnya kebiasaan tidak bergerak banyak *(sedentary),* merokok atau makan berlebihan. Lihat Gambar 2.2 dan Tabel 2.1

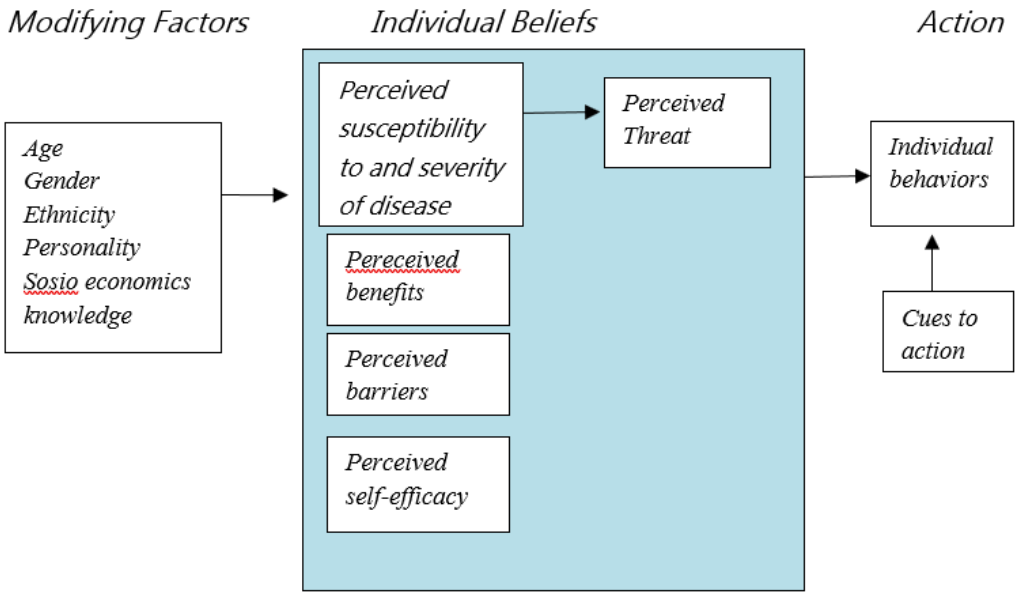


Gambar 4.2: Komponen Health Belief Model (HBM).
Sumber: Glanz *et al.*, 2002 dalam Ratu Ludji., ID,2023

Tabel 4.1: Perkembangan Konsep dan Definisi HBM

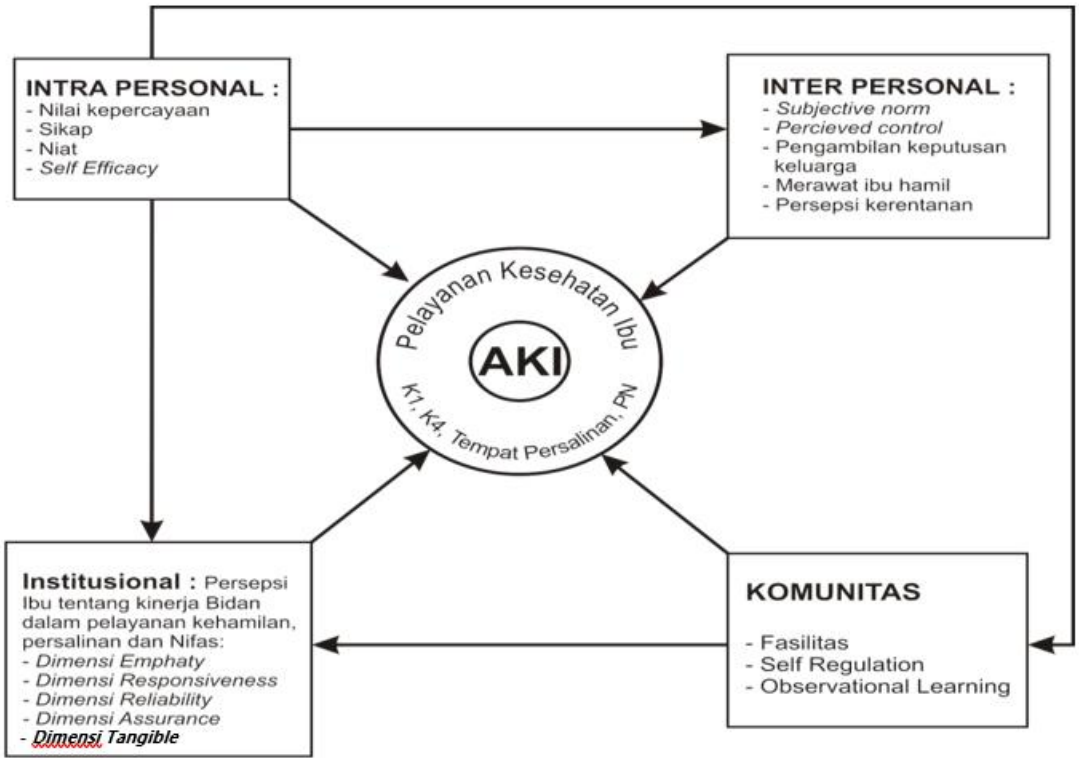
Konsep	Definisi	Aplikasi
Perceived Susceptibility/ Kerentanan yang dibayang	Kepercayaan tentang kemungkinan mengalami risiko atau mendapatkan suatu kondisi atau penyakit	Mendefinisikan populasi berisiko, level risiko; risiko yang bakal menimpa seseorang dengan melihat ciri atau perilaku, membuat persepsi kerentanan lebih konsisten dengan risiko individu sebenarnya.
Perceived Severity/ Beratnya apa yang dibayangkan	Kepercayaan tentang bagaimana seriusnya suatu kondisi dan konsekuensinya	Beri perincian konskuensi dari risiko dan kondisi
*Perceived Benefits/*Bayangan Manfaat didapat	Keyakinan seseorang akan kemujarapan tindakan yg disarankan untuk mengurangi risiko atau keseriusan dampaknya.	Definisikan tindakan akan diambil, kapan, dimana, jelaskan efek-efek positif yang bakal didapat.
Perceived Barriers/ Bayangan kesulitan/Hambatan	keyakinan seseorang akan biaya psikologis dan biaya riil dari tindakan yang disarankan	Mengidentifikasi dan mengurangi hambatan dengan memberikan insentif atau meyakinkan kembali
Cues to Action/Pengingat untuk melakukan tindakan	Strategi untuk mengaktifkan "kesigapan"	Berikan informasi, bagaimana meningkatkan kesadaran, dan berikan pengingat tertentu.
Self-Efficacy/ Efikasi Diri	Keyakinan akan kemampuan seseorang untuk melakukan tindakan.	• Memberikan pelatihan, bimbingan dalam melakukan tindakan yang dianjurkan • Gunakan penetapan tujuan progresif • Berikan *reinforcement* verbal • Menunjukkan perilaku yang diinginkan • Mengurangi kecemasan

Sumber: Glanz *et al.,* 2008, dalam Ratu Ludji., ID,2023



Gambar 4.3 Komponen *Health Belief Model (HBM).*
Sumber: Glanz *et al.,* 2008. Dalam Ratu Ludji., ID, 2023

1. Kerangka Teori: TEORI *Social Ecological Model of Health Behavior* : *Ina Djayaku Abadi* untuk Penurunan Angka Kematian Ibu



Gambar 4.4: Teori "*Social Ecological Model of Health Behavior Ina Djayaku Abadi*" Untuk Penurunan AKI di Kabupaten Kupang, NTT. Ratu Ludji., ID, 2023.

2. *M*odel baru pengembangan pendekatan *Social Ecological Model of Health Behavior Ina Djayaku Abadi* untuk penurunan AKI di Kabupaten Kupang, NTT dikembangkan sendiri oleh peneliti berdasarkan variabel yang ada pada *Social Ecological Model of Health Behavior* : intra personal, interpersonal, institusional dan komunitas dengan indikator untuk mengukurnya menggunakan beberapa teori : Faktor intrapersonal dikembangkan dari *Health Belief model* serta konsep kesehatan ibu dan anak meliputi obstetrik ginekologi, program KIA, indikator pelayanan kesehatan ibu pendidikan kesehatan melalui Kelas prenatal care and family*, Screening* faktor risiko dengan Kartu Skor Poedji Rochjati (KSPR); Faktor Interpersonal dari *Theory of Reasoned Action, Theory of Planned Behaviour,* serta konsep perawatan keluarga dan komunitas ; Faktor institusional dari persepsi ibu tentang kinerja bidan dimensi *realibility, assurance, tangible, emphaty* dan *responsivness dan Social Cognitif Theory.*
3. Faktor terbesar yang mempengaruhi pelayanan kesehatan ibu untuk penurunan AKI adalah mengikuti beberapa jalur yaitu:

   Jalur I: Pengaruh langsung variabel intrapersonal, interpersonal, institusional dan komunitas terhadap pelayanan kesehatan.

   Jalur II: Pengaruh tidak langsung variabel intrapersonal melalui interpersonal, institusional dan komunitas terhadap pelayanan kesehatan ibu.

   Jalur III: Pengaruh tidak langsung variabel intrapersonal ke variabel komunitas, kemudian ke institusional terhadap pelayanan kesehatan ibu.

   Model Jalur I, II, dan III cocok diterapkan diseluruh Indonesia maupun dunia dengan faktor sosial budaya yang sama yaitu budaya Patriaki. Model jalur I dan II untuk masyarakat rural di daerah pedesaan. Sedangkan Model jalur III cocok diterapkan untuk masyarakat urban atau perkotaan.

   Semakin tinggi faktor intrapersonal dan interpersonal maka akan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan ibu. Faktor institusional dan komunitas juga mempunyai pengaruh terhadap penurunan AKI. Pengaruh yang ada bersifat terbalik dikarenakan pada faktor institusional kinerja bidan cukup dan kurang, bidan kurang *emphaty* terhadap kebutuhan ibu karena mengerjakan tugas tambahan bidan sebagai adminstrasi, tidak *reliable* atau handal dalam memberikan pelayanan kesehatan, tidak menepati janji, tidak tepat waktu serta tidak berada di tempat saat dibutuhkan. Bidan juga kurang *responsive* terhadap kebutuhan pelayanan kesehatan pada ibu. Belum dapat memberikan jaminan keamanan dan *privacy* bagi ibu saat IMD.

Dengan demikian ibu tetap memilih tidak melakukan K1 murni, tidak K4 serta tidak mendapatkan pelayanan kesehatan lainnya, ibu memilih melahirkan di rumah dan ditolong oleh keluarga/dukun. Demikian halnya juga faktor komunitas berpengaruh terbalik terhadap penurunan AKI dikarenakan pada komunitas kehamilan, melahirkan dan masa nifas adalah sesuatu yang bernilai sehingga oleh masyarakat perlu mendapat perhatian khusus, dengan melakukan perawatan khusus selama awal kehamilan tidak ke Puskesmas sampai merasa pasti kehamilannya sudah kuat, sesudah melahirkan mendapat perawatan mandi air panas "tatobi" selama 7 hari dan "panggang api". sehingga ibu merasa nyaman dan tidak memanfaatkan pelayanan kesehatan untuk ibu. Di masyarakat juga sudah tersedia wadah untuk pelayanan kesehatan ibu seperti posyandu namun dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan harapan ibu karena kurangnya kreatifitas dalam mengelola posyandu menjadi tempat yang menarik untuk dikunjungi oleh ibu hamil dan nifas. Posyandu dilakukan pada jam kerja, yang mana pada saat itu ibu harus menyelesaikan pekerjaan rumah tangga atau ibu masih di kebun. Waktu posyandu mengikuti waktu kerja bidan atau petugas kesehatan. Disamping itu masih kuatnya pengaruh intrapersonal berkaitan dengan nilai kepercayaan, sikap, niat dan *Self Efficacy.* Serta interpersonal *Subjective norm.* Di masyarakat perawatan kehamilan, persalinan dan masa nifas biasanya menjadi perhatian keluarga besar sehingga keluarga memberikan dukungan penuh untuk perawatan ibu selama hamil, melahirkan dan nifas sehingga ibu merasa nyaman di rumah dan tidak memeriksakan kehamilannya, memilih melahirkan di rumah. Ini perlu menjadi perhatian dalam rencana intervensi selanjutnya.

Variabel *observed* yang membentuk variabel laten endogen/dependen pelayanan kesehatan ibu untuk penurunan AKI adalah K1 murni, K4, tempat persalinan dan penolong persalinan. Sedangkan variabel *observed* Kf dan KB tidak dimasukkan untuk variabel laten endogen/dependen penurunan AKI.

Variabel laten eksogen/independen intrapersonal dibentuk oleh variabel *observed*: Nilai kepercayaan, sikap, niat, dan *Self Efficacy*. Variabel laten eksogen/ independen Interpersonal dibentuk oleh variabel *observed*: *Subjective norm*, *Perceived control,* pengambilan keputusan keluarga, merawat ibu hamil dan persepsi kerentanan, Variabel laten eksogen/independen institusional dibentuk oleh variabel *observed*: kinerja bidan dimensi *emphaty, responsivness, reliability* dan *assurance.* Namun dimensi *tangible* tetap dianggap penting untuk meningkatkan pelayanan

kesehatan ibu yang prima, sehingga peneliti tetap memasukkannya dalam model. Variabel laten eksogen/independen komunitas dibentuk oleh variabel *observed*: fasilitasi, *self regulation* dan *observasional*

C. Kerangka Konsep Penelitian

1. Kerangka konseptual atau *conceptual framework* adalah suatu kegiatan menvisualisasi konsep (variabel) dan keterkaitan antar konsep agar dapat dilakukan penelitian. Secara filsafat ilmu, kegiatan ini merupakan kegiatan ontologi dan epistemologi (ingat kembali modul Bab 1). Kerangka konseptual perlu dibuat sesederhana mungkin tetapi tidak kehilangan makna saat orang lain mempelajari penelitian yang akan Anda lakukan.
2. Merupakan pola pikir yang dikembangkan berdasarkan pengetahuan pada kerangka teori untuk menyelesaikan permasalahan penelitian.
3. Kerangka konsep menjelaskan hubungan atau kaitan antara konsep satu dengan yang lain dari masalah penelitian yang ingin diteliti
4. Merupakan alur pikir ilmiah yang dikembangkan peneliti untuk menyelesaikan masalah berdasarkan konsep epidemiologis "agent-host-environment" dalam hubungannya dengan "exposure" atau pemajaan dan "outcome" atau masalah kesehatan/penyakit. Anak panah antar variable belum menggambarkan hubungan statistik tetapi hubungan konsepsional
5. Merupakan pengembangan satu model penyelesaian masalah atau kerangka konsep yang terdiri dari variable-variabel yang akan diukur. Jenis variable ada dua yaitu vaiabel "outcome" atau "dependent" atau variable tergantung dan variable-variabel "independent" atau variable bebas yang terdiri dari faktor-faktor sosiodemografi dan faktor-faktor risiko outcome lainnya. Adakalanya dikenal variable "intermediate" antara variable dependent dan variable independent.
    a. Kerangka Teori Dari Studi Kepustakaan
    b. Memudahkan Pemahaman Hipotesis

Penyusunan kerangka konseptual sebagai visualisasi harus dapat menggambarkan kedudukan variabel penelitian sebagai variabel masukan, proses, keluaran, dan dampak. Kerangka konseptual yang disusun harus memenuhi kaidah umum dalam kegiatan penelitian dengan simbol atau gambar tertentu. Simbol yang dimaksud adalah:

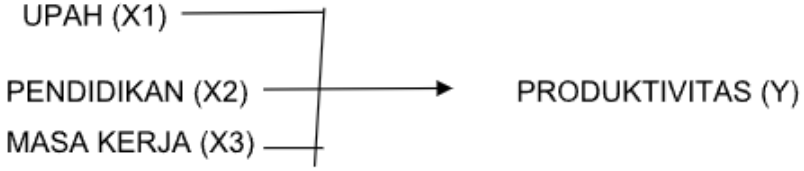
= Gambar variabel yang diteliti

= Gambar variabel yang tidak diteliti

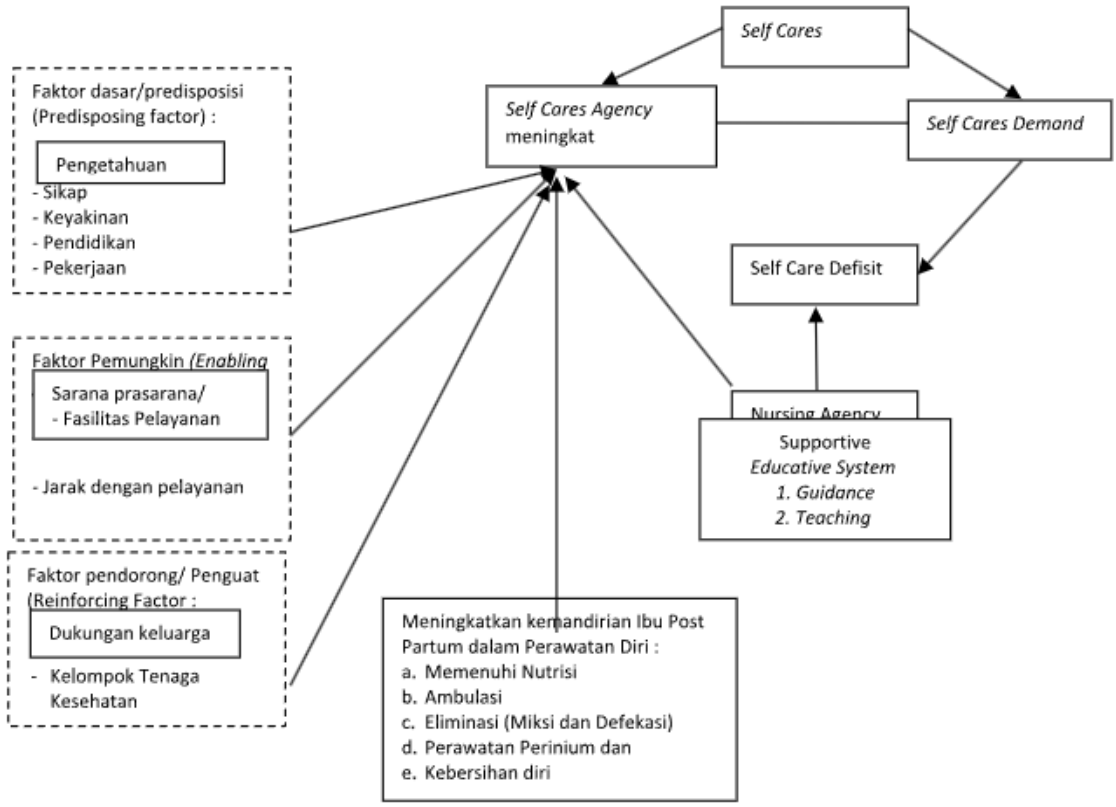
= Arah garis pengaruh

= Arah garis hubungan

Kerangka konseptual harus sinkron dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah disusun dengan penguatan tinjauan pustaka dan diberi judul gambar, seperti contoh 4.1; 4.2dan 4.3 di bawah ini .



1. Contoh Kerangka Konsep Berbasis Self Care (Orem) *Self care Agency* (Kemandirian Orem). Penerapan pada Ibu Nifas dengan Menggunakan Pendekatan *Teori Self Care Model.*

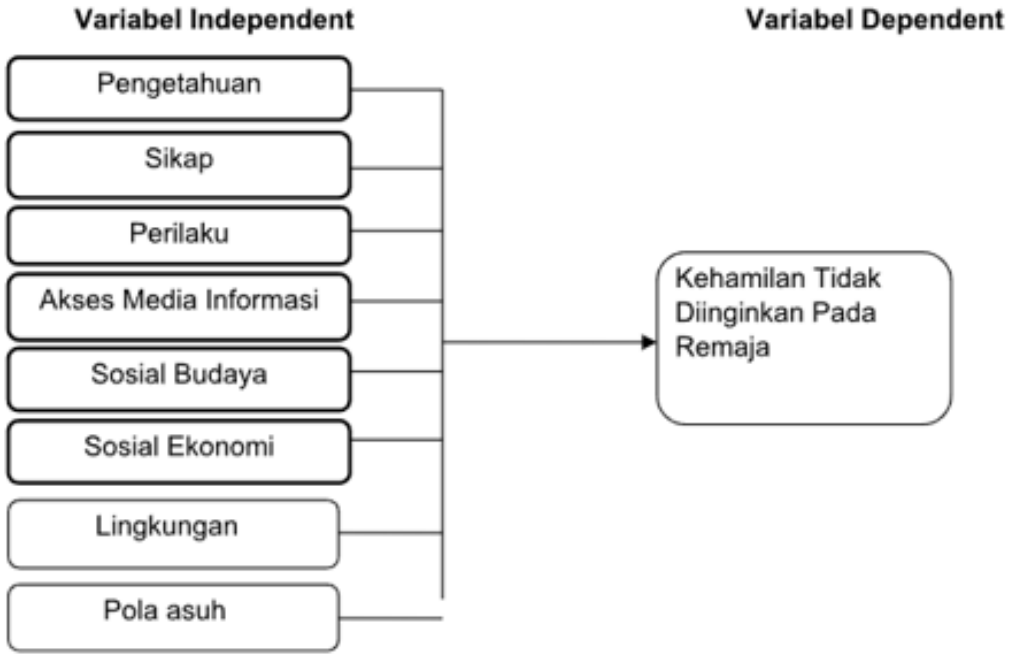


Gambar 4.5: Kerangka Konsep Penelitian meningkatkan Kemandirian Ibu Nifas dengan menggunakan pendekatan teori *Self Care Model Orem* (Mardiatun, 2012 dalam Nursalam, 2013).

Keterangan: Variabel yang diteliti: Variabel yang tidak diteliti

Gambar 4.3 menunjukkan teori keperawatan Self Care yang dikemukakan oleh Dorothea Orem, manusia pada dasarnya mempunyai kemampuan dalammerawat dirinya sendiri yang disebut Self Care Agency. Self Care Agency dapat berubah setiap waktu yang dipengaruhi oleh faktor predisposisi *(predisposing factor)* pengetahuan, sikap keyakinan pendidikan dan pekerjaan. yang kedua yaitu faktor pemungkin (*enabling factor)* yang terdiri atas sarana prasarana dan jarak dengan pelayanan kesehatan. Yang ketiga yaitu faktor pendorong *(Reinforcing factor)* yang berupa peran dukungan keluarga dan adanya aturan-aturan. Ketika terjadi deficit perawatan diri, peran perawat sebagai *Nursing Agency* membantu untuk memaksimalkan kemampuan pelaksanaan perawatan diri ibu post partum melalui tindkan asuhan keperawatan mandiri perawat berupa bantuan supportif- educative system dengan memberikan Guidance (*Booklet and Teaching* untuk meningkatkan kemampuan atau kemandirian pelaksanaan perawatan diri ibu *(Self care Agency)* terhadap kebuthan perawatan diri ibu *(Self Care Demand)* seperti kemampuan memenuhi nutrisi dan cairan, ambulasi, kebersihan diri, perawatan perineum, perawatan payudara, miksi dan defekasi

2. Contoh Kerangka Konsep Faktor yang Berhubungan dengan Kehamilan Tidak Diinginkan Pada Remaja di Wilayah Kerja Puskesmas Bakunase Tahun 2017 (Moniz V, 2018)



Sumber : Moniz V, 2018

Ket :

: Variabel Independent yang diteliti

: Variabel Dependent yang diteliti

Gambar 4.6: Faktor yang Berhubungan dengan Kehamilan Tidak Diinginkan Pada Remaja di Wilayah Kerja Puskesmas Bakunase Tahun 2017

D. Hipotesis Penelitian

1. Hipotesis adalah pernyataan sebagai jawaban sementara atas pertanyaan penelitian, yang harus diuji validitasnya secara empiris. Atau
2. Hipotesis merupakan jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya.
3. Tidak semua penelitian memerlukan hipotesis, penelitian yang bersifat eksploratif dan deskriptif tidak memerlukan hipotesis
4. Dasar Merumuskan Hipotesis adalah: Berdasarkan pada teori, Berdasarkan penelitian terdahulu, Berdasarkan penelitian pendahuluan, Berdasarkan akal sehat peneliti
   a. Kata Hipo: - Lemah
   b. Tesis: - Pernyataan
   c. Penelitian Kualitatif tidak perlu Hipotesis

Manfaat Hipotesis adalah:

1. Menjelaskan masalah penelitian
2. Menjelaskan variabel-variabel yang akan diuji
3. Pedoman untuk memilih metode analisis data
4. Dasar untuk membuat kesimpulan penelitian.

Pembagian Hipotesis:

1. HIPOTESIS DESKRIPTIF
   a. Pelayanan Rumah sakit Budi Asih tidak Memuaskan
   b. Kinerja Keuangan Bank CBA Baik
   c. Semangat Kerja Karyawan RS Kartika Tinggi
2. HIPOTESIS KOMPARATIF
   a. Rumah sakit Sumber Waras lebih memuaskan dibandingkan pelayanan rumah sakit Alam Indah
   b. Kinerja keuangan bank CBA lebih baik dibandingkan dengan kinerja bank Polli
   c. Semangat kerja karyawan RS Kartika lebih tinggi dibandingkan dengan semangat kerja RS Kartono
3. HIPOTESIS ASOSIATIF

a. Kepuasan pasien berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pasien
b. Jumlah nasabah berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank CBA
c. Semangat kerja karyawan berpengaruh positif terhadap produktifitas karyawan

Dalam Penelitian Hipotesis dapat dinyatakan dalam bentuk hipotesis Nol atau Hipotesis alternatif.

4. Hipotesis Nol

   Merupakan hipotesis yang menyatakan hubungan atau pengaruh antar variabel sama dengan nol. Atau dengan kata lain tidak terdapat perbedaan, hubungan atau pengaruh antar variabel.

5. Hipotesis Alternatif

   Merupakan hipotesis yang menyatakan adanya perbedaan, hubungan atau pengaruh antar variabel tidak sama dengan nol. Atau dengan kata lain terdapat perbedaan, hubungan atau pengaruh antar variabel (merupakan kebalikan dari hipotesis alternatif)

Syarat Hipotesis:

1. Dinyatakan dalam kalimat deklaratif yang jelas dan sederhana, tidak bermakna ganda.
2. Mempunyai landasan teori yang kuat..
3. Menyatakan hubungan antara satu variable tergantung dengan satu atau lebih variable bebas

Hipotesis Yang Baik:

1. Pernyataan tanpa diawali kata diduga
2. Informatif
3. Dapat diuji
4. Sinkron dengan rumusan masalah
5. Penulisan tidak boleh bentuk H0 dan H1

I s i :

1. Pengaruh
2. Hubungan
3. Perbedaan

Macam Hipotesis:

1. Hipotesis kerja

   Adalah suatu rumusan hipotesis dengan tujuan untuk membuat ramalan tentang peristiwa yang terjadi apabila suatu gejala muncul. Biasanya menggunakan rumusan pernyataan: Jika…., maka…… Artinya jika suatu faktor

atau variabel terdapat atau terjadi pada suatu situasi, maka ada akibat tertentu yang dapat ditimbulkannya.

Contoh sederhana:

a. Jika sanitasi lingkungan suatu daerah buruk, maka penyakit menular di daerah tersebut tinggi
b. Jika persalinan dilakukan oleh dukun yang belum terlatih, maka angka kematian bayi di daerah tersebut tinggi.
c. Rumusan hipotesis harus dapat memberi penjelasan tentang kedudukan masalah yang diteliti, sebagai bentuk kesimpulan yang akan diuji.

2. Hipotesis Nol atau Hipotesis Statistik

Hipotesis ini biasanya dibuat untuk menyatakan sesuatu kesamaan atau tidak adanya suatu perbedaan yang bermakna antara kedua kelompok atau lebih mengenai suatu hal yang dipermasalahkan. Bila dinyatakan adanya perbedaan antar adua variable, disebut hipotesis alternatif.

Contoh sederhana:

a. Tidak ada perbedaan tentang angka kematian akibat penyakit jantung antara penduduk perkotaan dengan penduduk pedesaan.
b. Tidak ada perbedaan angka penderita sakit diare antara kelompok penduduk yang menggunakan air minum dari PAM dengan kelompok penduduk yang menggunakan air minum dari sumur.

3. Hipotesis Hubungan dan Hipotesis Perbedaan
   a. Hipotesis hubungan berisi tentang dugaan adanya hubungan antara dua variable. Misalnya ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan praktek pemeriksaan hamil. Hipotesis ini dapat diperjelas lagi menjadi: makin tinggi tingkat pendidikan ibu, semakin sering (teratur) memeriksakan kehamilannya.
   b. Hipotesis perbedaan menyatakan adanya ketidaksamaan atau perbedaan diantara dua variabel, misalnya Praktek pemberian ASI ibu-ibu di kelurahan X berbeda dengan praktek pemberian ASI ibu-ibu di kelurahan Y. Hipotesis ini lebih dielaborasi menjadi: Praktek pemberian ASI ibu-ibu di kelurahan X lebih tinggi dibandingkan dengan praktek pemberian ASI ibu-ibu di kelurahan Y.
   c. Ada pengaruh positif yang signifikan pemberian insentif, lingkungan kerja, dan kepemimpinan terhadap semangat kerja karyawan RSUD Prof W.Z. Johannes Kupang

Hipotesis dapat Menunjukkan: Masalah penelitian, Variabel penelitian, Metode Analisis data dan Kesimpulan.

Tidak semua penelitian membutuhkan hipotesis penelitian, hanya penelitian yang mempelajari hubungan, perbedaan, atau pengaruh bukan penelitian deskriptif. Ciri penelitian deskriptif yaitu tujuan penelitiannya untuk menggambarkan pada variabel tertentu dan tidak terdapat keterkaitan antar variabel.

Tahap lanjut setelah menyusun kerangka konseptual adalah merumuskan hipotesis. Hipotesis terdiri dari dua kata yaitu *hypo* artinya lemah dan *thesis* artinya pernyataan, sehingga dapat diartikan pernyataan yang lemah. Dalam filsafat ilmu (modul 1) hipotesis adalah suatu pembuatan kesimpulan berdasarkan teori yang ada, karena merupakan pernyataan atau kesimpulan yang lemah perlu dilakukan pembuktian (verifikasi). Ingat kalimat *LOGICO – HYPOTHESIS– VERIFICATIVE*. Sehingga secara lengkap hipotesis adalah suatu pernyataan yang lemah dan perlu dibuktikan secara fakta.

Penyusunan hipotesis harus padat makna dan sesuai dengan rumusan masalah penelitian yang telah ditetapkan di awal. Pada tahap ini, penyusunan hipotesis dilakukan penelitian dengan tujuan untuk mempelajari perbedaan atau hubungan atau pengaruh, sedangkan penelitian deskriptif tidak perlu hipotesis. Menggunakanrumusan masalah 1 dan 2 dapat ditulis hipotesis penelitian sebagai berikut:

Berdasarkan Rumusan Masalah Penelitian 1:

Adakah pengaruh pembelajaran praktik terhadap kompetensi mahasiswa?

Hipotesis penelitian 1 ini adalah:

Ada pengaruh pembelajaran praktik terhadap kompetensi mahasiswa.

Berdasarkan Rumusan Masalah Penelitian 2:

Adakah hubungan antara pengetahuan dan sikap dengan ketrampilan mahasiswa?

Hipotesis penelitian 2 ini adalah:

ada hubungan antara pengetahuan dan sikap dengan ketrampilan mahasiswa.

Fungsi hipotesis penelitian untuk menggambarkan bahwa hasil pengumpulan data nanti perlu dilakukan uji statistik dengan statistika. Cara menulis hipotesis penelitian seperti di Tabel 4.1

Tabel 4.2: Cara Penulisan Hipotesis Penelitian

No	Penelitian	Cara Menulis
1	Hubungan	**a. Ada hubungan antara** variabel A **dengan** variabel F. **b.** Variabel A **berhubungan dengan** variabel F.

2	Pengaruh	• **Ada pengaruh** variabel A **terhadap** variabel F. • Variabel A **berpengaruh terhadap** variabel F.
3	Perbedaan	**1) Ada perbedaan antara** variabel A1 **dan** A2. **2)** Antara variabel A1 dan A2 **ada perbedaan**.

Sumber : Suprajitno, 2013

Keterangan: Perhatikan kata yang dicetak tebal

Hipotesis dibedakan menjadi dua yaitu hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Penulisan hipotesis penelitian hanya menggunakan kalimat sedangkan penulisan hipotesis statistik menggunakan simbol H_0 dan H_1 atau H_a. Hipotesis penelitian dan statititistik memiliki perbedaan seperti dalam Tabel 4.2 di bawah ini.

Tabel 4.3: Perbedaan hipotesis penelitian dan hipotesis statistik

No.	Karakteristik	Hipotesis penelitian	Hipotesis statistik
1	Syarat penulisan	Diperlukan Berpikir	logika
2	Waktu penulisan	Setelah menyusun kerangka konseptual	Setelah melakukan pengumpulan data
3	Cara penulisan	Hipotesis penelitian ini adalah	H_0: ..... H_1: ..... atau H_a: .....
4	Pengujian	Tidak perlu, karena berasal dari teori	Perlu, karena diperoleh dari sampel sehingga harus dikembalikan ke populasi

Contoh Hipotesis Penelitian (Moniz, V 2018)

1. Ada hubungan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas dengan kejadian kehamilan tidak diinginkan pada remaja di wilayah kerja Puskesmas Bakunase Kota Kupang
2. Ada hubungan sikap terhadap seks pranikah dengan kejadian kehamilan tidak diinginkan pada remaja di wilayah kerja Puskesmas Bakunase Kota Kupang
3. Ada hubungan perilaku seksual dengan kejadian kehamilan tidak diinginkan pada remaja di wilayah kerja Puskesmas Bakunase Kota Kupang.
4. Ada hubungan akses media informasi tentang pornografi dengan kejadian kehamilan tidak diinginkan pada remaja di wilayah kerja Puskesmas Bakunase Kota Kupang.
5. Ada hubungan sosial budaya dengan kejadian kehamilan tidak diinginkan pada remaja di wilayah kerja Puskesmas Bakunase Kota Kupang.
6. Ada hubungan pola asuh orang tua dengan kejadian kehamilan tidak diinginkan pada remaja di wilayah kerja Puskesmas Bakunase Kota Kupang.
7. Ada hubungan sosial ekonomi dengan kejadian kehamilan tidak diinginkan pada remaja di wilayah kerja Puskesmas Bakunase Kota Kupang.
8. Ada hubungan lingkungan tempat tinggal dengan kejadian kehamilan tidak diinginkan pada remaja di wilayah kerja Puskesmas Bakunase Kota Kupang.
9. Ada hubungan pola asuh orang tua dengan kejadian kehamilan tidak diinginkan pada remaja di wilayah kerja Puskesmas Bakunase Kota Kupang.

Contoh Hipotesis Penelitiian (Tasa, Y., 2015)

1. Ada pengaruh umur terhadap pemanfaatan VCT oleh ibu rumah tangga t erinfeksi HIV/AIDS di Kabupaten Belu.
2. Ada pengaruh tingkat pendidikan terhadap pemanfaatan VCT oleh ibu ru mah tangga terinfeksi HIV/AIDS di Kabupaten Belu.
3. Ada pengaruh persepsi tentang penyakit terhadap pemanfaatan VCT oleh ibu rumah tangga terinfeksi HIV/AIDS di Kabupaten Belu.
4. Ada pengaruh persepsi tentang pelayanan kesehatan terhadap pemanfaa tan VCT oleh ibu rumah tangga terinfeksi HIV/AIDS di Kabupaten Belu.
5. Ada pengaruh pekerjaan suami terhadap pemanfaatan VCT oleh ibu ruma h tangga terinfeksi HIV/AIDS di Kabupaten Belu.
6. Ada pengaruh pendapatan keluarga terhadap pemanfaatan VCT oleh ibu rumah tangga terinfeksi HIV/AIDS di Kabupaten Belu.
7. Ada pengaruh keterjangkauan terhadap pemanfaatan VCT oleh ibu rumah

tangga terinfeksi HIV/AIDS di Kabupaten Belu.

8. Ada pengaruh persepsi keparahan penyakit terhadap pemanfaatan VCT o leh ibu rumah tangga terinfeksi HIV/AIDS di Kabupaten Belu.
9. Ada pengaruh persepsi stigma diri sendiri terhadap pemanfaatan VCT ole h ibu rumah tangga terinfeksi HIV/AIDS diKabupaten Belu.
10. Ada pengaruh faktor umur, tingkat pendidikan, persepsi tentang penyakit , persepsi tentang pelayanan kesehatan, pekerjaan suami, pendapatan kel uarga, keterjangkauan, persepsi keparahan penyakit dan persepsi stigma diri sendiri terhadap pemanfaatan VCT oleh ibu rumah tangga terinfeksi H IV/AIDS di Kabupaten Belu.

Contoh Hipotesis Penelitiian (Bilaut, I 2017)

1. Ada pengaruhi *Individual Belief* (kerentanan, keseriusan, manfaat dan hambatan, dan ancaman yang dirasakan) terhadap kepatuhan perawat dalam pelaksanaan *hand hygiene five moment* di IRNA I RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes kupang.
2. Ada pengaruh faktor motivasi (imbalan dan hukuman) terhadap kepatuhan perawat dalam pelaksanaan *hand hygiene five moment* di IRNA I RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes kupang.
3. Ada pengaruh supervisi (kepala ruangan dan IPCLN) terhadap kepatuhan perawat dalam pelaksanaan *hand hygiene five moment* di IRNA I RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes kupang.
4. Ada pengaruh ketersediaan fasilitas *hand hygiene* terhadap kepatuhan perawat dalam pelaksanaan *hand hygiene five moment* di IRNA I RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes kupang.

E. Aktivitas 1 — Knows How Mini-Case Tertulis

Diskusi Kelompok: Perumusan Kerangka Konseptual Penelitian

Mata Kuliah

Metodologi Penelitian

Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti aktivitas ini, mahasiswa mampu:

1. Mengidentifikasi variabel penelitian berdasarkan kasus yang diberikan.
2. Menentukan hubungan antarvariabel secara logis dan ilmiah.
3. Menyusun kerangka konseptual penelitian sederhana.
4. Menjelaskan dasar teoritis hubungan antarvariabel.

Petunjuk Aktivitas

1. Mahasiswa dibagi dalam kelompok beranggotakan 4–5 orang.

2. Bacalah mini-case berikut dengan cermat.
3. Diskusikan variabel yang terlibat dalam kasus.
4. Susun kerangka konseptual penelitian berdasarkan hasil diskusi kelompok.
5. Presentasikan hasil diskusi dalam bentuk bagan dan uraian singkat.

Mini-Case

Sebuah sekolah menengah mengalami penurunan motivasi belajar siswa selama pembelajaran daring. Berdasarkan hasil observasi awal, beberapa faktor yang diduga memengaruhi motivasi belajar antara lain:

1. kualitas interaksi guru dengan siswa,
2. ketersediaan fasilitas belajar di rumah,
3. tingkat stres akademik siswa.

Pihak sekolah ingin mengetahui faktor mana yang paling berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa agar dapat menentukan strategi peningkatan kualitas pembelajaran.

Sebagai tim peneliti, kelompok Anda diminta untuk menyusun kerangka konseptual penelitian yang tepat berdasarkan kasus tersebut.

Tugas Diskusi Kelompok

A. Identifikasi Variabel

Tentukan:

1. Variabel independen (bebas)
2. Variabel dependen (terikat)
3. Variabel yang mungkin menjadi mediator atau moderator (jika ada)

B. Rumusan Hubungan Antarvariabel

Jelaskan dugaan hubungan:

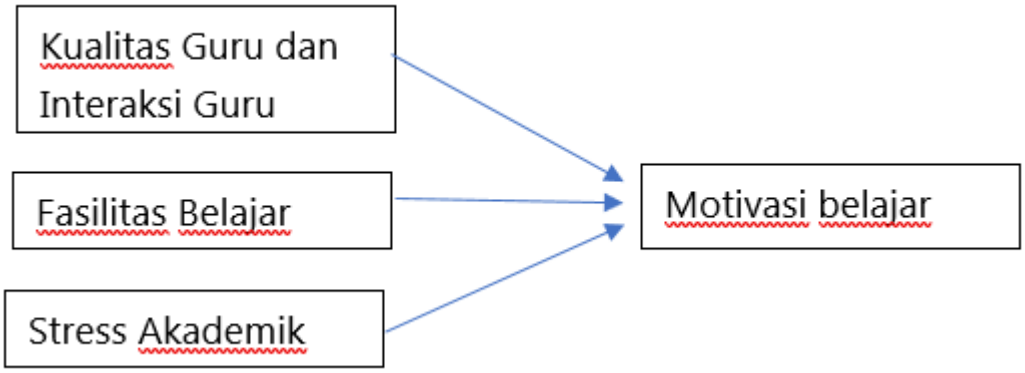
1. kualitas interaksi guru → motivasi belajar,
2. fasilitas belajar → motivasi belajar,
3. stres akademik → motivasi belajar.

Berikan alasan teoritis secara singkat.

C. Penyusunan Kerangka Konseptual

Buat bagan kerangka konseptual penelitian.

Contoh sederhana:



D. Pengembangan Hipotesis

Susun minimal 3 hipotesis penelitian berdasarkan kerangka konseptual yang telah dibuat.

Contoh:

1. H1: Kualitas interaksi guru berpengaruh positif terhadap motivasi belajar siswa.
2. H2: Fasilitas belajar berpengaruh positif terhadap motivasi belajar siswa.
3. H3: Stres akademik berpengaruh negatif terhadap motivasi belajar siswa.

Output yang Dikumpulkan

Setiap kelompok menyerahkan:

1. Hasil identifikasi variabel
2. Diagram kerangka konseptual
3. Penjelasan hubungan antarvariabel
4. Rumusan hipotesis penelitian

Kriteria Penilaian

Aspek Penilaian	Bobot
Ketepatan identifikasi variabel	25%
Logika hubungan antarvariabel	30%
Kejelasan kerangka konseptual	25%
Kualitas argumentasi dan presentasi	20%

Catatan Dosen

Aktivitas ini dirancang untuk melatih kemampuan *knows how* mahasiswa dalam menerapkan konsep metodologi penelitian pada situasi nyata melalui analisis kasus dan diskusi kolaboratif.

Aktivitas 2 — *Knows How* Mini-Case Tertulis

Diskusi Kelompok: Perumusan Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian

Mata Kuliah

Metodologi Penelitian Kesehatan

Topik

Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Anemia pada Remaja Puteri

Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti aktivitas ini, mahasiswa mampu:

1. Mengidentifikasi variabel penelitian berdasarkan kasus kesehatan masyarakat.
2. Menentukan hubungan antarvariabel dalam penelitian kuantitatif.
3. Menyusun kerangka konseptual penelitian.
4. Merumuskan hipotesis penelitian berdasarkan teori dan kasus.
5. Menjelaskan alasan ilmiah hubungan antarvariabel.

Petunjuk Aktivitas

1. Mahasiswa dibagi dalam kelompok beranggotakan 4–5 orang.
2. Bacalah mini-case berikut dengan cermat.
3. Diskusikan faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian anemia pada remaja puteri.
4. Susun kerangka konseptual penelitian dalam bentuk bagan.
5. Rumuskan hipotesis penelitian berdasarkan hasil diskusi kelompok.
6. Presentasikan hasil diskusi di depan kelas.

Mini-Case

Hasil pemeriksaan kesehatan di beberapa sekolah menunjukkan masih tingginya angka anemia pada remaja puteri. Kondisi ini dapat memengaruhi konsentrasi belajar, pertumbuhan, serta kesehatan reproduksi remaja di masa mendatang.

Berdasarkan studi pendahuluan, terdapat beberapa faktor yang diduga berhubungan dengan kejadian anemia pada remaja puteri, antara lain:

1. usia,
2. status sosial ekonomi keluarga,
3. suku,
4. pola asuh orang tua,
5. berat badan,
6. tinggi badan.

Tim peneliti ingin mengetahui hubungan faktor-faktor tersebut dengan kejadian anemia pada remaja puteri sebagai dasar penyusunan program pencegahan anemia di sekolah.

Sebagai kelompok peneliti, Anda diminta menyusun kerangka konseptual dan hipotesis penelitian yang sesuai dengan kasus tersebut.

Tugas Diskusi Kelompok

A. Identifikasi Variabel Penelitian

Tentukan:

1. Variabel dependen (terikat)
2. Variabel independen (bebas)
3. Variabel yang mungkin menjadi faktor perancu (confounding)

B. Analisis Hubungan Antarvariabel

Diskusikan kemungkinan hubungan:

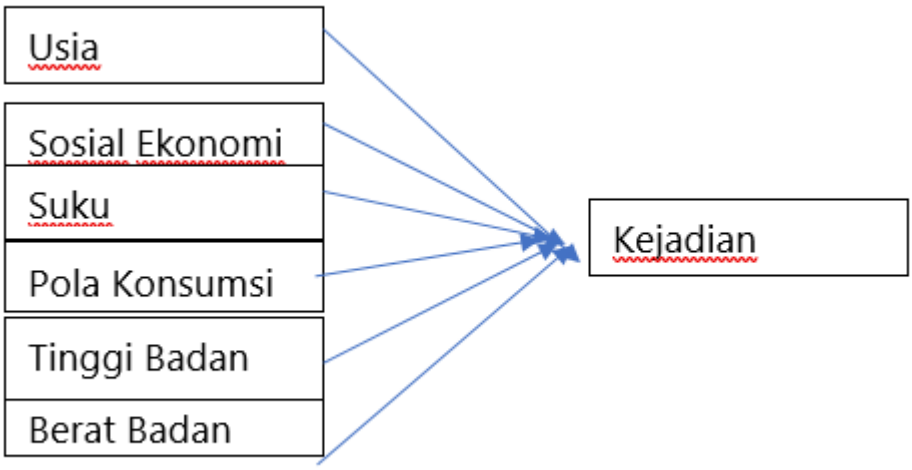
1. usia → kejadian anemia,
2. sosial ekonomi → kejadian anemia,
3. suku → kejadian anemia,
4. pola asuh → kejadian anemia,
5. berat badan → kejadian anemia,
6. tinggi badan → kejadian anemia.

Berikan alasan teoritis atau logis dari masing-masing hubungan tersebut.

C. Penyusunan Kerangka Konseptual

Buat bagan kerangka konseptual penelitian berdasarkan hasil diskusi kelompok.

Contoh sederhana:



Pengembangan Hipotesis Penelitian

Susun hipotesis penelitian berdasarkan kerangka konseptual yang telah dibuat.

Contoh:

1. H1: Terdapat hubungan antara usia dengan kejadian anemia pada remaja puteri.
2. H2: Terdapat hubungan antara status sosial ekonomi dengan kejadian anemia pada remaja puteri.
3. H3: Terdapat hubungan antara suku dengan kejadian anemia pada remaja puteri.
4. H4: Terdapat hubungan antara pola Konsumsi dengan kejadian anemia pada remaja puteri.
5. H5: Terdapat hubungan antara berat badan dengan kejadian anemia pada remaja puteri.
6. H6: Terdapat hubungan antara tinggi badan dengan kejadian anemia pada remaja puteri.

Pertanyaan Diskusi Tambahan

1. Faktor manakah yang menurut kelompok paling dominan memengaruhi anemia?
2. Bagaimana hubungan status gizi dengan kejadian anemia?
3. Apakah faktor budaya atau kebiasaan makan berdasarkan suku dapat memengaruhi anemia?
4. Upaya pencegahan apa yang dapat dilakukan sekolah dan keluarga?

Output yang Dikumpulkan

Setiap kelompok menyerahkan:

1. Identifikasi variabel penelitian
2. Diagram kerangka konseptual
3. Penjelasan hubungan antarvariabel
4. Rumusan hipotesis penelitian
5. Kesimpulan hasil diskusi kelompok

Kriteria Penilaian

Aspek Penilaian	Bobot
Ketepatan identifikasi variabel	20%
Logika hubungan antarvariabel	30%
Kejelasan kerangka konseptual	20%
Ketepatan hipotesis penelitian	20%
Kemampuan presentasi dan diskusi	10%

Catatan Dosen

Aktivitas ini dirancang untuk melatih kemampuan mahasiswa dalam menerapkan konsep metodologi penelitian kesehatan melalui analisis kasus nyata, penyusunan kerangka konseptual, serta pengembangan hipotesis penelitian secara sistematis dan ilmiah.

Soal:

1. Seorang Perawat Perempuan memvisualisasi variabel penelitian dan menggambarkan keterkaitan antar variabel.
   Apakah kegiatan yang dilakukan perawat?
   A. Melakukan ontology
   B. Menyusun epistemologi.
   C. Menyederhanakan konsep.
   D. Menyusun kerangka konseptual.

2. Manakah yang digunakan perawat sebagai acuan menyusun kerangka konseptual penelitian?
   A. Hipotesis penelitian.
   B. Masalah penelitian.
   C. Variabel penelitian.
   D. Keterkaitan variabel penelitian.

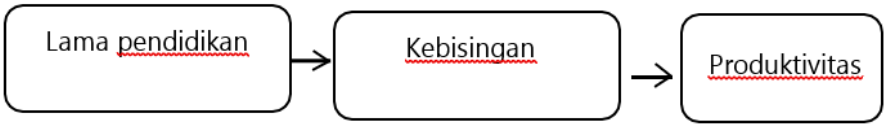
3. Perawat merumuskan masalah penelitian: adakah hubungan antara minum obat malaria dengan kesembuhan Malaria selama hamil?

Manakah yang disebut variabel akibat?

A. Usia kehamilan.
B. Minum obat Malaria.
C. Kesembuhan Malaria.
D. Hubungan minum obat malaria.

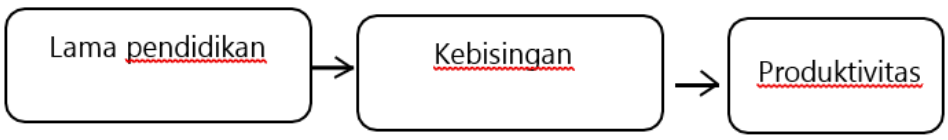
4. Perawat merumuskan masalah penelitian: adakah hubungan antara minum obat malaria dengan kesembuhan Malaria selama hamil?
   Manakah yang disebut variabel penyebab?
   A. Usia kehamilan.
   B. Minum obat Malaria.
   C. Kesembuhan Malaria.
   D. Hubungan minum obat malaria.

5. Perhatikan gambar di bawah ini.
   Perhatikan gambar 1 di bawah ini.



   Berdasarkan gambar 1, manakah yang disebut variabel independen?
   A. Produktivitas.
   B. Ketrampilan.
   C. Lama pendidikan.
   D. Kebisingan

6. Perhatikan gambar 2 di bawah ini.
   Gambar 2 Perhatikan gambar di bawah ini.
   Berdasarkan gambar 2, manakah yang disebut variabel intervening?



   A. Kompetensi.
   B. Ketrampilan.
   C. Lama pendidikan.
   D. Kebisingan

7. Dalam jurnal penelitian disebutkan terdapat variabel independen.
   Apakah yang dimaksud dalam jurnal?
   A. Variabel bebas
   B. Variabel antara.
   C. Variabel intervening.
   D. Variabel tergantung.

8. Perawat merumuskan masalah penelitian: adakah pengaruh latihan kaki terhadap gula darah pasien DM?
   Apakah hipotesis penelitiannya?
   A. Ada perbedaan antara latihan kaki dan gula darah.
   B. Latihan kaki berpengaruh terhadap gula darah.
   C. Ada hubungan latihan kaki dengan gula darah
   D. Ada hubungan latihan kaki terhadap nadi.

9. Saat ini peneliti telah selesai melakukan pengumpulan data sesuai dengan variabel penelitian.
   Apakah yang harus dilakukan peneliti?
   A. Merumuskan tujuan penelitian.
   B. Merumuskan hipotesis statistik.
   C. Merumuskan hipotesis penelitian.
   D. Merumuskan masalah penelitian.
10. Manakah cara penulisan hipotesis statistik?
   A. Menggunakan kalimat.
   B. Menggunakan dua kata.
   C. Menggunakan simbol H0.
   D. Menggunakan hasil pengujian.

Kunci Jawaban

1. D
2. B
3. C
4. B
5. C
6. D
7. A
8. B
9. B
10. C

F. Rangkuman Materi

1. Kerangka konseptual atau *conceptual framework* adalah suatu kegiatan menvisualisasi konsep (variabel) dan keterkaitan antar konsep dan merupakan kegiatan ontologi dan epistemologi yang perlu dibuat sesederhana mungkin tetapi tidak kehilangan makna.
2. Kerangka konseptual sebagai visualisasi harus dapat menggambarkan kedudukan variabel penelitian sebagai variabel masukan, proses, keluaran, dan dampak yang harus memenuhi kaidah umum dengan simbol atau gambar tertentu.
3. Kerangka konseptual harus sinkron dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian dan diberi judul gambar.
4. Variabel masukan disebut variabel bebas atau penyebab atau independen, variabel proses disebut sebagai variabel antara atau intervening dan variabel keluaran dan dampak disebut sebagai variabel tergantung atau akibat atau dependen.
5. Yang perlu disusun kerangka konseptual penelitian yang mempelajari hubungan, perbedaan, atau pengaruh bukan penelitian deskriptif
6. Hipotesis terdiri dari dua kata yaitu hypo artinya lemah dan thesis artinya pernyataan, yang lemah perlu dilakukan pembuktian (verifikasi).
7. Penyusunan hipotesis harus padat makna dan sesuai dengan rumusan masalah penelitian.
8. Penulisan hipotesis penelitian harus menggunakan kata penghubung antar variabel yang logik.
9. Hipotesis dibedakan menjadi dua yaitu hipotesis penelitian dan hipotesis statistik, di mana keduanya memiliki perbedaan.

G. Daftar Pustaka

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50*(2), 179–211.

Glanz, K., Rimer, B. K., & Viswanath, K. (2008). *Health behavior and health education: Theory, research, and practice* (4th ed.). Jossey-Bass.

Mardiatun. (2012). *Pendekatan teori self care model pada ibu nifas*. Jakarta: EGC.

McCarthy, J., & Maine, D. (1992). A framework for analyzing the determinants of maternal mortality. *Studies in Family Planning, 23*(1), 23–33.

Moniz, V. (2018). *Faktor yang berhubungan dengan kehamilan tidak diinginkan pada remaja di wilayah kerja Puskesmas Bakunase Kota Kupang* [Skripsi tidak dipublikasikan]. Poltekkes Kemenkes Kupang.

Notoatmodjo, S. (2018). *Metodologi penelitian kesehatan* (Rev. ed.). Rineka Cipta.

Nursalam. (2013). *Metodologi penelitian ilmu keperawatan: Pendekatan praktis* (3rd ed.). Salemba Medika.

Ratu Ludji, I. D. (2023). *Social ecological model of health behavior Ina Djayaku Abadi untuk penurunan angka kematian ibu di Kabupaten Kupang, NTT* [Monograf]. Poltekkes Kemenkes Kupang.

Rosenstock, I. M., Strecher, V. J., & Becker, M. H. (1988). Social learning theory and the Health Belief Model. *Health Education Quarterly, 15*(2), 175–183.

Suprajitno. (2013). *Metodologi penelitian kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika.

Tasa, Y. (2015). *Faktor yang memengaruhi pemanfaatan VCT oleh ibu rumah tangga terinfeksi HIV/AIDS di Kabupaten Belu* [Tesis tidak dipublikasikan]. Universitas Nusa Cendana.

World Health Organization. (2021). *Anaemia in women and children*. World Health Organization.

BAB 5

DESAIN PENELITIAN KUANTITATIF

Tabel CPL

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-3	Mampu merancang metode penelitian (kuantitatif/kualitatif) termasuk desain, populasi–sampel, sampling, instrumen, dan prosedur pengumpulan/manajemen data secara sistematis.	CPMK-4; CPMK-5
CPL-4	Mampu melakukan analisis data dasar (kuantitatif/kualitatif) dan menyajikan temuan secara ilmiah, jelas, dan dapat ditindaklanjuti.	CPMK-6; CPMK-7

Tabel CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-4	Menentukan desain penelitian kuantitatif/kualitatif yang sesuai, termasuk populasi–sampel, teknik sampling, dan kontrol kualitas metodologis.
CPMK-5	Menyusun instrumen dan rencana pengukuran, prosedur pengumpulan data, serta manajemen data (keamanan, kerahasiaan, kualitas) yang dapat diaudit.
CPMK-6	Melakukan analisis data kuantitatif dasar dan analisis data kualitatif, serta menyajikan temuan dalam format ilmiah yang jelas.

Pendahuluan

Perkembangan ilmu keperawatan tidak dapat dilepaskan dari kemampuan profesi ini untuk menghasilkan dan memanfaatkan bukti ilmiah secara berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, penelitian kuantitatif menjadi salah satu pilar utama karena memberikan dasar empiris yang terukur untuk menilai efektivitas intervensi, menggambarkan fenomena keperawatan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan masalah kesehatan tertentu. Melalui data numerik yang dianalisis secara sistematis, perawat memperoleh landasan yang lebih kuat dalam merumuskan keputusan klinik, menyusun standar prosedur operasional, dan mengembangkan program pelayanan maupun pendidikan kesehatan.

Di tatanan praktik keperawatan, berbagai permasalahan yang muncul dalam pemberian asuhan sehari-hari pada hakikatnya dapat dirumuskan sebagai topik penelitian kuantitatif, misalnya untuk menilai efektivitas edukasi dengan media audiovisual dibandingkan media cetak dalam meningkatkan pengetahuan keluarga, mengkaji hubungan beban kerja dengan tingkat kelelahan perawat, atau mengevaluasi pengaruh program pencegahan jatuh terhadap angka kejadian jatuh pada pasien lansia. Permasalahan-permasalahan tersebut memerlukan rancangan penelitian yang tepat, sehingga data yang dikumpulkan dapat dianalisis secara akurat dan menghasilkan temuan yang bermakna bagi peningkatan mutu pelayanan keperawatan.

Meskipun demikian, tidak sedikit mahasiswa dan perawat yang memandang kajian mengenai desain penelitian sebagai bagian yang cukup kompleks dalam metodologi penelitian. Berbagai istilah, seperti desain deskriptif, korelasional, eksperimen, quasi eksperimen, populasi, sampel, variabel independen dan dependen, serta konsep validitas dan reliabilitas, kerap terasa abstrak apabila tidak dikaitkan secara langsung dengan konteks praktik keperawatan. Padahal, secara hakiki desain penelitian merupakan kerangka berpikir yang memfasilitasi perawat dalam merumuskan dan menjawab masalah klinik secara sistematis, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Bab ini disusun untuk memberikan pemahaman yang lebih terstruktur dan kontekstual mengenai desain penelitian kuantitatif dalam keperawatan. Pembahasan disajikan dalam bentuk sajian umum yang komunikatif, dengan tetap menjaga ketepatan istilah ilmiah dan alur berpikir yang runtut. Contoh-contoh yang digunakan diambil dari berbagai situasi keperawatan di rumah sakit, puskesmas, komunitas, dan pendidikan keperawatan, sehingga pembaca dapat melihat relevansi langsung antara konsep desain penelitian dengan peran profesional yang dijalankan.

Sejalan dengan pendekatan ***Outcome Based Education***, Bab 5 tidak hanya bertujuan menambah wawasan teoretis, tetapi juga mengarahkan pembaca untuk

mencapai kemampuan yang terukur. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa keperawatan mampu memilih dan menjelaskan jenis desain penelitian kuantitatif yang sesuai dengan rumusan masalah, menyusun komponen utama rancangan penelitian (populasi, sampel, variabel, dan instrumen), serta memahami garis besar prosedur pengumpulan dan analisis data. Dengan demikian, penelitian kuantitatif tidak hanya dipandang sebagai persyaratan akademik, tetapi sebagai bagian integral dari praktik keperawatan profesional yang berbasis bukti.

Tujuan Instruksional Umum

Mahasiswa memahami dan mampu menerapkan konsep desain penelitian kuantitatif dalam keperawatan untuk menyusun rancangan penelitian yang logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Tujuan Instruksional Khusus

1. Mahasiswa menjelaskan pengertian dan karakteristik penelitian kuantitatif dalam keperawatan.
2. Mahasiswa mengklasifikasikan jenis desain kuantitatif (deskriptif, korelasional, eksperimen, quasi eksperimen) dari contoh kasus keperawatan.
3. Mahasiswa mengidentifikasi variabel penelitian dan mengelompokkan menjadi variabel independen, dependen, dan kontrol.
4. Mahasiswa menyusun tabel operasionalisasi variabel untuk satu contoh masalah keperawatan.
5. Mahasiswa menjelaskan secara lisan maupun tertulis prinsip dasar pemilihan instrumen, validitas, dan reliabilitas.
6. Mahasiswa menguraikan secara garis besar langkah analisis deskriptif dan uji beda sederhana yang sesuai dengan desain penelitian yang dipilih.

Capaian Pembelajaran

1. Menjelaskan konsep dasar dan karakteristik desain penelitian kuantitatif dalam keperawatan secara sistematis.
2. Menguraikan jenis-jenis desain penelitian kuantitatif yang lazim digunakan dalam penelitian keperawatan beserta kelebihan dan keterbatasannya.
3. Mengidentifikasi variabel independen, dependen, dan kontrol dalam rancangan penelitian keperawatan.
4. Menyusun definisi operasional dan indikator pengukuran variabel dalam konteks penelitian keperawatan.
5. Menjelaskan prinsip dasar pemilihan instrumen, validitas, dan reliabilitas dalam penelitian kuantitatif keperawatan.
6. Menguraikan langkah-langkah prosedur pengumpulan dan analisis data dasar (deskriptif dan inferensial sederhana) dalam penelitian kuantitatif keperawatan.

A. Konsep Dasar Desain Penelitian Kuantitatif

Desain penelitian kuantitatif merupakan kerangka kerja yang mengatur proses perencanaan, pelaksanaan, dan analisis penelitian dengan menggunakan data numerik untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis. Dalam keperawatan, desain penelitian yang tepat membantu perawat mengevaluasi intervensi, menggambarkan fenomena klinik, dan menilai hubungan antara berbagai faktor risiko dengan luaran kesehatan.

Peneliti keperawatan menyusun desain dengan mempertimbangkan beberapa komponen utama, yaitu tujuan penelitian, jenis pertanyaan penelitian, karakteristik populasi, ketersediaan sumber daya, serta etika penelitian. Kombinasi komponen ini akan menentukan apakah penelitian lebih sesuai menggunakan desain deskriptif, korelasional, eksperimen, atau quasi eksperimen. Desain yang disusun secara cermat memungkinkan peneliti mengurangi bias, meningkatkan validitas hasil, dan memudahkan interpretasi temuan.

B. Jenis-Jenis Desain Penelitian Kuantitatif

1. Desain Deskriptif

Desain deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik suatu fenomena keperawatan secara sistematis tanpa memberikan perlakuan atau intervensi tertentu. Peneliti mengumpulkan data pada satu titik waktu atau dalam periode tertentu untuk memperoleh gambaran mengenai variabel yang diteliti, seperti tingkat pengetahuan, sikap, perilaku, atau kondisi klinik. Contoh penerapan di keperawatan:

a. Menggambarkan tingkat pengetahuan keluarga tentang perawatan pasien stroke di rumah.
b. Menggambarkan tingkat kepatuhan pasien diabetes terhadap regimen diet di poliklinik penyakit dalam.

Desain deskriptif penting sebagai langkah awal untuk memahami suatu masalah keperawatan dan sering menjadi dasar bagi penelitian analitik atau intervensi pada tahap berikutnya.

2. Desain Korelasional

Desain korelasional digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur derajat hubungan antara dua atau lebih variabel tanpa manipulasi dari peneliti. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk membuktikan hubungan

sebab-akibat, tetapi untuk mengetahui apakah variabel-variabel tersebut bergerak searah, berlawanan arah, atau tidak berhubungan.

Contoh penerapan:

a. Menilai hubungan antara beban kerja dan tingkat kelelahan (burnout) perawat di unit perawatan intensif.
b. Mengkaji hubungan dukungan keluarga dengan kualitas hidup pasien gagal ginjal yang menjalani hemodialisis.

Hasil penelitian korelasional dapat digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berpotensi berkontribusi terhadap masalah keperawatan dan menjadi dasar penyusunan intervensi yang lebih terarah.

3. Desain Eksperimental

Desain eksperimental digunakan ketika peneliti ingin menguji secara ketat pengaruh suatu intervensi terhadap luaran tertentu dengan cara membandingkan kelompok intervensi dan kelompok kontrol yang ditetapkan secara acak. Ciri utama desain ini adalah adanya randomisasi, kelompok kontrol, dan intervensi yang distandarkan.

Contoh penerapan:

1. Menguji pengaruh terapi relaksasi napas dalam terhadap intensitas nyeri pascaoperasi pada pasien bedah.
2. Menilai efektivitas program edukasi keperawatan berbasis simulasi dibandingkan ceramah dalam meningkatkan keterampilan klinik mahasiswa.

Desain eksperimental berada pada tingkat tinggi dalam hierarki bukti karena kemampuannya mengurangi bias dan memberikan dukungan yang lebih kuat terhadap hubungan sebab-akibat.

4. Desain Quasi Eksperimental

Desain quasi eksperimental memiliki tujuan yang serupa dengan desain eksperimental, yaitu menilai pengaruh intervensi, tetapi tidak menggunakan randomisasi penuh karena keterbatasan konteks penelitian. Peneliti bekerja dengan kelompok yang sudah ada, misalnya dua ruang rawat berbeda atau dua kelas mahasiswa.

Contoh penerapan:

a. Mengkaji pengaruh program pencegahan jatuh yang baru diterapkan di satu ruang rawat dan membandingkannya dengan ruang lain yang belum menerapkan program tersebut.

b. Menilai pengaruh pendidikan kesehatan tentang manajemen nyeri terhadap kecemasan pasien sebelum tindakan invasif di dua poliklinik berbeda.

Desain quasi eksperimental banyak digunakan dalam penelitian keperawatan karena lebih realistis diterapkan di lahan praktik, meskipun peneliti perlu lebih cermat dalam mengendalikan faktor perancu.

C. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling

1. Populasi Penelitian

Populasi penelitian adalah seluruh subjek yang memiliki karakteristik tertentu dan menjadi sasaran generalisasi hasil penelitian. Dalam keperawatan, populasi dapat berupa pasien, keluarga, perawat, mahasiswa, atau kelompok masyarakat di wilayah tertentu.

Contoh:

a. Seluruh pasien gagal jantung yang dirawat di ruang rawat inap rumah sakit tipe B selama satu tahun.
b. Seluruh perawat pelaksana yang bekerja di unit rawat intensif di tiga rumah sakit rujukan.

Definisi populasi yang jelas membantu peneliti menentukan kriteria inklusi dan eksklusi secara spesifik, sehingga proses pengambilan sampel menjadi terarah.

2. Sampel dan Ukuran Sampel

Sampel adalah sebagian anggota populasi yang dipilih untuk diteliti dan diharapkan mewakili karakteristik populasi. Penentuan ukuran sampel dipengaruhi oleh besarnya populasi, tujuan penelitian, desain penelitian, variabilitas data, serta pertimbangan praktis seperti waktu dan sumber daya.

Untuk penelitian dengan populasi yang diketahui, salah satu pendekatan yang sering digunakan di tingkat dasar adalah rumus Slovin untuk memperkirakan jumlah sampel yang diperlukan. Pada penelitian dengan desain yang lebih kompleks, peneliti dianjurkan merujuk pada pedoman perhitungan sampel yang lebih rinci atau menggunakan perangkat lunak statistik khusus.

3. Teknik Sampling

Teknik sampling dalam penelitian keperawatan secara garis besar dibagi menjadi dua kelompok.

a. Probability sampling

Setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Teknik ini lebih disukai untuk meningkatkan representativitas, tetapi tidak selalu mudah diterapkan di lahan praktik. Contoh:

a. Simple random sampling: pemilihan sampel secara acak dari daftar populasi.
b. Stratified random sampling: pemilihan sampel dengan membagi populasi ke dalam strata tertentu, seperti jenis kelamin atau unit kerja.

b. Non-probability sampling

Pemilihan sampel dilakukan berdasarkan pertimbangan peneliti atau kemudahan akses. Teknik ini banyak digunakan dalam penelitian keperawatan karena lebih praktis, tetapi memiliki keterbatasan dalam generalisasi hasil. Contoh:

a. Purposive sampling: pemilihan responden yang dianggap memenuhi kriteria tertentu secara khusus.
b. Consecutive sampling: pengambilan semua subjek yang memenuhi kriteria dalam jangka waktu tertentu.

D. Variabel Penelitian dan Operasionalisasi dalam Keperawatan

Variabel penelitian merupakan konsep atau karakteristik yang nilainya dapat berubah dan dapat diukur. Dalam keperawatan, variabel dapat berupa kondisi klinik, faktor perilaku, faktor lingkungan, maupun luaran asuhan keperawatan.

Beberapa jenis variabel yang umum digunakan:

1. Variabel independen (bebas): variabel yang diduga memengaruhi variabel lain, misalnya jenis intervensi edukasi atau program pencegahan.
2. Variabel dependen (terikat): variabel yang dipengaruhi, misalnya tingkat pengetahuan, tingkat kecemasan, intensitas nyeri, atau kejadian jatuh.
3. Variabel kontrol: variabel lain yang dijaga tetap atau dikendalikan agar tidak mengganggu hubungan antara variabel independen dan dependen, misalnya usia, jenis kelamin, atau diagnosis utama.

Operasionalisasi variabel dilakukan dengan menjabarkan variabel abstrak menjadi indikator yang dapat diobservasi dan diukur. Misalnya, variabel "kecemasan" dapat dioperasionalkan melalui skor kuesioner standar, sedangkan "kejadian jatuh" diukur berdasarkan jumlah insiden jatuh yang tercatat selama periode tertentu.

E. Instrumen Penelitian Kuantitatif dalam Keperawatan

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data secara sistematis dan konsisten. Dalam keperawatan, instrumen yang sering digunakan antara lain kuesioner, skala penilaian, lembar observasi, formulir audit dokumentasi, dan alat ukur fisiologis.

Penyusunan instrumen perlu memperhatikan beberapa hal:

1. Kesesuaian dengan tujuan penelitian dan variabel yang diukur.
2. Kejelasan bahasa dan petunjuk pengisian agar mudah dipahami responden.
3. Relevansi butir pertanyaan dengan konteks budaya dan klinik tempat penelitian dilakukan.

Peneliti dianjurkan menggunakan instrumen yang sudah terstandar dan memiliki bukti validitas serta reliabilitas, atau melakukan adaptasi instrumen dengan prosedur yang tepat apabila diperlukan.

F. Sekilas Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Validitas menunjukkan sejauh mana instrumen benar-benar mengukur konsep yang dimaksud, sedangkan reliabilitas menunjukkan konsistensi hasil pengukuran ketika instrumen digunakan dalam kondisi yang serupa.

Dalam penelitian keperawatan, beberapa bentuk validitas yang sering dibahas adalah:

1. Validitas isi (content validity): kesesuaian isi instrumen dengan konsep yang diukur, biasanya dinilai oleh panel ahli.
2. Validitas konstruk (construct validity): sejauh mana instrumen mencerminkan struktur teoretik dari konsep yang diukur.

Reliabilitas sering diukur dengan koefisien Cronbach's alpha untuk instrumen berbentuk skala likert, di mana nilai yang lebih tinggi (misalnya ≥ 0,70) menunjukkan konsistensi internal yang baik. Penjelasan lebih mendalam mengenai teknik uji validitas dan reliabilitas biasanya diberikan pada mata kuliah metode penelitian lanjutan, namun pemahaman konsep dasarnya penting bagi perawat sebagai pengguna hasil penelitian.

G. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data harus dijelaskan secara runtut agar penelitian dapat direplikasi dan dinilai kelayakannya. Tahapan umum dalam penelitian kuantitatif keperawatan antara lain:

1. Menyusun rancangan penelitian dan memperoleh persetujuan etik.
2. Mengidentifikasi lokasi penelitian dan populasi sasaran.
3. Menentukan sampel dan teknik sampling.

4. Menyiapkan instrumen dan melakukan uji coba jika diperlukan.
5. Melaksanakan pengumpulan data sesuai protokol penelitian.
6. Menjaga kerahasiaan dan hak partisipan selama proses penelitian.

Pada desain quasi eksperimental, prosedur biasanya meliputi pengukuran awal (pretest), pelaksanaan intervensi, dan pengukuran ulang (posttest) pada kelompok intervensi dan, bila ada, kelompok pembanding.

H. Teknik Analisis Data Kuantitatif

Analisis data dalam penelitian kuantitatif dilakukan untuk merangkum informasi, menguji hipotesis, dan menjawab pertanyaan penelitian.

1. Statistik deskriptif

Digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden dan variabel, misalnya melalui nilai rata-rata, median, standar deviasi, serta distribusi frekuensi dan persentase.

2. Statistik inferensial

Digunakan untuk menguji hipotesis dan menarik kesimpulan yang melampaui data sampel. Teknik yang dipilih bergantung pada jenis data, distribusi data, dan desain penelitian. Contoh yang sering digunakan dalam keperawatan:

a. Uji t untuk membandingkan dua kelompok.
b. ANOVA untuk membandingkan lebih dari dua kelompok.
c. Uji chi-square untuk hubungan antarvariabel kategorik.
d. Korelasi Pearson atau Spearman untuk mengukur hubungan antarvariabel numerik atau ordinal.

Peneliti juga perlu memeriksa asumsi-asumsi statistik yang relevan, seperti normalitas distribusi data dan homogenitas varians, sebelum melakukan uji inferensial. Interpretasi hasil hendaknya tidak hanya berfokus pada nilai p, tetapi juga mempertimbangkan besar efek dan relevansi klinik bagi praktik keperawatan.

I. Konsep Dasar Desain Penelitian Kuantitatif dalam Keperawatan

Desain penelitian kuantitatif merupakan rencana menyeluruh yang mengatur bagaimana peneliti menyusun pertanyaan penelitian, memilih variabel yang akan dikaji, menentukan cara pengukuran, menyusun prosedur pengumpulan data, dan merencanakan analisis statistik. Dalam keperawatan, desain ini berperan sebagai kerangka yang memastikan bahwa penelitian dijalankan secara logis, sistematis, dan konsisten, sehingga hasilnya dapat

dipercaya dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan klinik maupun manajerial.

Hakikat desain penelitian adalah menjawab tiga pertanyaan utama: "Apa yang akan diukur?", "Dengan cara apa hal tersebut diukur?", dan "Bagaimana hasil pengukuran dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian?". Pada penelitian kuantitatif, jawaban ketiga pertanyaan ini diterjemahkan ke dalam pemilihan jenis desain (misalnya deskriptif, korelasional, eksperimen, quasi eksperimen), penentuan variabel independen dan dependen, penyusunan instrumen, serta pemilihan teknik analisis data. Dengan demikian, desain penelitian bukan sekadar format teknis, tetapi merupakan wujud konkret dari cara peneliti berpikir terhadap suatu masalah keperawatan.

J. Jenis-Jenis Desain Penelitian Kuantitatif dalam Keperawatan

1. Desain Deskriptif

Desain deskriptif digunakan ketika tujuan penelitian adalah menggambarkan suatu fenomena keperawatan secara apa adanya. Peneliti tidak memberikan intervensi khusus, melainkan mengamati dan mendeskripsikan karakteristik variabel pada kelompok tertentu.

Dalam praktik keperawatan, desain ini sering digunakan untuk:

a. Menggambarkan tingkat pengetahuan, sikap, atau perilaku pasien dan keluarga, misalnya pengetahuan keluarga tentang perawatan pasien stroke di rumah.
b. Menggambarkan kondisi klinik tertentu, seperti tingkat nyeri pada pasien pascaoperasi, kualitas tidur pasien di unit perawatan, atau persepsi pasien terhadap mutu pelayanan keperawatan.

Hasil penelitian deskriptif biasanya disajikan dalam bentuk tabel frekuensi, persentase, dan ukuran pemusatan (rata-rata, median) sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai fenomena yang diteliti. Desain ini penting sebagai langkah awal untuk memahami masalah keperawatan sebelum dirancang penelitian analitik atau intervensi lanjutan.

2. Desain Korelasional

Desain korelasional bertujuan mengkaji hubungan antara dua atau lebih variabel tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel-variabel tersebut. Peneliti ingin mengetahui apakah perubahan pada satu variabel berkaitan dengan perubahan pada variabel lain, baik searah maupun berlawanan arah.

Contoh penerapan desain korelasional di keperawatan antara lain:

a. Menilai hubungan antara beban kerja perawat dengan tingkat kelelahan emosional atau burnout.
b. Mengkaji hubungan antara dukungan keluarga dengan kepatuhan pasien menjalani terapi.
c. Menilai hubungan antara tingkat kecemasan pasien dan kualitas tidur selama dirawat.

Analisis data pada desain korelasional umumnya menggunakan koefisien korelasi, seperti korelasi Pearson atau Spearman, yang menunjukkan arah dan kekuatan hubungan. Temuan dari penelitian korelasional dapat digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang perlu mendapat perhatian khusus dalam perencanaan intervensi keperawatan.

3. Desain Eksperimental

Desain eksperimental digunakan ketika peneliti ingin menilai secara ketat pengaruh suatu intervensi keperawatan terhadap luaran tertentu. Desain ini ditandai oleh adanya kelompok intervensi dan kelompok kontrol, intervensi yang terstandar, serta penugasan subjek ke kelompok secara acak.

Ciri-ciri utama desain eksperimental meliputi:

a. Adanya perlakuan (treatment) yang jelas, misalnya pemberian jenis edukasi tertentu atau terapi nonfarmakologis.
b. Adanya kelompok pembanding yang tidak menerima perlakuan atau menerima perlakuan standar.
c. Adanya upaya untuk mengendalikan faktor perancu, salah satunya melalui penugasan acak.

Contoh penelitian eksperimental dalam keperawatan:

a. Menguji pengaruh terapi relaksasi napas dalam terhadap penurunan intensitas nyeri pada pasien pascaoperasi.
b. Menilai efektivitas program edukasi interaktif dibandingkan edukasi konvensional terhadap peningkatan pengetahuan pasien gagal jantung mengenai perawatan mandiri.

Desain eksperimental ditempatkan pada tingkat bukti yang tinggi karena mampu memberikan dukungan kuat terhadap hubungan sebab-akibat, meskipun penerapannya di setting klinik sering kali memerlukan sumber daya dan pengaturan yang lebih kompleks.

4. Desain Quasi Eksperimental

Desain quasi eksperimental memiliki tujuan serupa dengan desain eksperimental, yaitu menilai pengaruh intervensi, tetapi tidak menggunakan penugasan acak sepenuhnya. Peneliti bekerja dengan kelompok yang sudah terbentuk, seperti dua ruang rawat atau dua kelas mahasiswa yang berbeda.

Ciri desain quasi eksperimental antara lain:

a. Terdapat intervensi keperawatan yang diberikan kepada satu kelompok.
b. Terdapat kelompok pembanding yang tidak mendapatkan intervensi atau mendapatkan perlakuan berbeda.
c. Penugasan peserta ke dalam kelompok tidak dilakukan secara acak, sehingga peneliti perlu lebih waspada terhadap faktor perancu.

Contoh penelitian quasi eksperimental di keperawatan:

a. Mengkaji pengaruh program pencegahan jatuh yang baru diterapkan di satu unit perawatan dan membandingkannya dengan unit lain yang belum menerapkan program tersebut.
b. Menilai pengaruh pendidikan kesehatan tentang manajemen nyeri terhadap tingkat kecemasan pasien sebelum tindakan invasif, dengan membandingkan pasien di dua poliklinik yang menerapkan pendekatan edukasi berbeda.

Desain quasi eksperimental banyak digunakan dalam penelitian keperawatan karena lebih realistis diterapkan di lapangan, terutama ketika randomisasi sulit dilakukan karena pertimbangan etis atau operasional.

K. Variabel Penelitian dan Operasionalisasi dalam Keperawatan

Variabel penelitian merupakan unsur yang dapat berubah dan diukur dalam suatu penelitian. Dalam keperawatan, variabel dapat mencerminkan kondisi pasien, karakteristik perawat, proses asuhan, maupun luaran pelayanan.

Beberapa jenis variabel yang penting dipahami:

1. Variabel independen (bebas)

Variabel yang diduga menjadi penyebab atau faktor yang memengaruhi variabel lain, misalnya jenis intervensi edukasi, keberadaan program pencegahan jatuh, atau pelaksanaan terapi relaksasi.

2. Variabel dependen (terikat)

Variabel yang menjadi hasil atau luaran dari variabel independen, misalnya tingkat pengetahuan, intensitas nyeri, tingkat kecemasan, atau angka kejadian jatuh.

3. Variabel control

Variabel lain yang berpotensi memengaruhi hasil dan perlu dikendalikan, misalnya usia, jenis kelamin, diagnosis medis, atau lama perawatan.

Operasionalisasi variabel adalah proses mengubah konsep abstrak menjadi indikator yang dapat diamati dan diukur secara konsisten. Misalnya, konsep "kecemasan" dapat dioperasionalkan melalui skor pada kuesioner kecemasan yang telah terstandar, sedangkan "kejadian jatuh" dioperasionalkan sebagai jumlah insiden jatuh yang tercatat dalam periode tertentu.

Dalam penyusunan proposal atau laporan penelitian, operasionalisasi variabel biasanya disajikan dalam bentuk tabel yang memuat nama variabel, definisi operasional, indikator, skala pengukuran, dan instrumen yang digunakan. Tabel ini membantu pembaca memahami secara jelas bagaimana konsep keperawatan yang kompleks diterjemahkan menjadi data yang dapat dianalisis secara kuantitatif.

L. Instrumen Penelitian Kuantitatif dalam Keperawatan

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data sesuai dengan variabel yang ditetapkan. Dalam penelitian keperawatan, instrumen dapat berupa:

1. Kuesioner atau skala penilaian, misalnya skala nyeri numerik, kuesioner pengetahuan, skala kecemasan, atau skala kepuasan.
2. Lembar observasi, misalnya lembar observasi kepatuhan penggunaan alat bantu jalan atau pelaksanaan prosedur keperawatan.
3. Formulir audit dokumentasi, misalnya untuk menilai kelengkapan catatan asuhan keperawatan.
4. Alat ukur fisiologis, misalnya tensimeter, termometer, atau alat pemantau tanda vital lain yang hasilnya dicatat sebagai data numerik.

Penyusunan instrumen perlu memperhatikan beberapa prinsip:

1. Isi instrumen harus selaras dengan tujuan penelitian dan variabel yang diukur.
2. Bahasa yang digunakan harus jelas, tidak menimbulkan penafsiran ganda, dan sesuai dengan kemampuan responden.
3. Instrumen harus mempertimbangkan aspek budaya dan konteks lokal agar pertanyaan relevan dan tidak menyinggung nilai-nilai yang sensitif.

Peneliti keperawatan dianjurkan menggunakan instrumen yang sudah dikembangkan dan divalidasi dalam penelitian sebelumnya, terutama untuk mengukur konsep-konsep yang kompleks seperti kualitas hidup, kecemasan, atau depresi. Jika peneliti menyusun instrumen baru atau mengadaptasi instrumen

dari bahasa lain, perlu dilakukan proses uji validitas dan reliabilitas terlebih dahulu sebelum digunakan pada penelitian utama.

M. Sekilas Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Validitas dan reliabilitas merupakan dua kriteria utama yang harus dipenuhi oleh instrumen penelitian kuantitatif.

Validitas berkaitan dengan sejauh mana instrumen benar-benar mengukur konsep yang dimaksud. Misalnya, instrumen yang dirancang untuk mengukur "pengetahuan perawatan diabetes" harus berisi butir pertanyaan yang memang menggali pengetahuan tersebut, bukan sikap atau perilaku. Bentuk validitas yang sering dibahas di tingkat dasar antara lain:

1. Validitas isi (content validity), yaitu kesesuaian isi instrumen dengan domain konsep yang diukur, biasanya dinilai oleh panel ahli keperawatan.
2. Validitas konstruk (construct validity), yaitu sejauh mana instrumen mencerminkan struktur teoretik dari konsep yang diukur.

Reliabilitas menunjukkan konsistensi hasil pengukuran ketika instrumen digunakan berulang dalam kondisi yang relatif sama. Salah satu cara yang umum digunakan untuk menilai reliabilitas internal adalah koefisien Cronbach's alpha, terutama untuk instrumen berbentuk skala likert. Nilai koefisien yang tinggi menunjukkan bahwa butir-butir dalam instrumen tersebut saling berkorelasi dan mengukur aspek yang sama.

Pada tingkat buku ajar ini, penting bagi pembaca untuk memahami bahwa instrumen yang valid dan reliabel akan menghasilkan data yang lebih dapat dipercaya, sehingga kesimpulan penelitian keperawatan menjadi lebih kuat dan layak dijadikan dasar praktik.

N. Prosedur Pengumpulan Data dalam Penelitian Keperawatan

Prosedur pengumpulan data menjelaskan langkah-langkah operasional yang ditempuh peneliti sejak persiapan hingga pelaksanaan penelitian. Uraian yang jelas memudahkan pembaca menilai kelayakan dan etika penelitian, serta memungkinkan studi serupa direplikasi di tempat lain.

Secara umum, prosedur pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif keperawatan meliputi:

1. Penyusunan dan penelaahan rancangan penelitian, termasuk persetujuan dari komite etik bila penelitian melibatkan pasien atau keluarga.
2. Koordinasi dengan pihak institusi terkait, seperti rumah sakit, puskesmas, atau institusi pendidikan keperawatan.

3. Pemberian informasi kepada calon responden dan pengambilan persetujuan (informed consent).
4. Pelaksanaan pengukuran sesuai jadwal dan prosedur yang telah ditetapkan, misalnya pengisian kuesioner, pengukuran tanda vital, atau observasi klinik.
5. Pencatatan dan penyimpanan data secara rapi dan aman, dengan menjaga kerahasiaan identitas responden.

Pada desain quasi eksperimental, prosedur biasanya mencakup pengukuran awal (pretest), pelaksanaan intervensi keperawatan, dan pengukuran ulang (posttest) untuk menilai perubahan yang terjadi. Kedisiplinan dalam mengikuti prosedur sangat menentukan kualitas data yang dihasilkan dan keandalan temuan penelitian.

O. Teknik Analisis Data Kuantitatif Dasar

Analisis data kuantitatif bertujuan mengubah angka-angka hasil pengukuran menjadi informasi yang bermakna untuk menjawab pertanyaan penelitian.

1. Analisis deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden dan variabel yang diteliti. Dalam keperawatan, hal ini dapat berupa rata-rata usia pasien, distribusi tingkat pendidikan, rata-rata skor nyeri, atau persentase pasien yang mengalami kejadian tertentu. Analisis deskriptif membantu pembaca memahami konteks penelitian sebelum memasuki analisis yang lebih kompleks.

2. Analisis inferensial

Analisis inferensial digunakan untuk menguji hipotesis dan menarik kesimpulan yang melampaui data sampel. Pemilihan teknik analisis inferensial bergantung pada tujuan penelitian, jenis variabel, dan asumsi statistik yang dipenuhi. Beberapa teknik yang sering digunakan dalam penelitian keperawatan adalah:

a. Uji t untuk membandingkan rata-rata dua kelompok, misalnya membandingkan rata-rata skor nyeri antara kelompok yang mendapatkan intervensi dan yang tidak.
b. Analisis varians (ANOVA) untuk membandingkan rata-rata lebih dari dua kelompok.
c. Uji chi-square untuk menilai hubungan antara dua variabel kategorik, misalnya hubungan antara kategori tingkat pendidikan dan kepatuhan terapi.

d. Korelasi Pearson atau Spearman untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel numerik atau ordinal.

Peneliti perlu memahami bahwa hasil uji statistik harus diinterpretasikan secara hati-hati, dengan menyeimbangkan makna statistik (misalnya nilai p) dan makna klinik (relevansi temuan bagi praktik keperawatan). Dengan demikian, analisis data tidak hanya menghasilkan angka, tetapi juga rekomendasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan mutu asuhan keperawatan.

P. Latihan Soal

1. Tujuan utama penelitian kuantitatif dalam keperawatan adalah ….
   A. Menggali makna pengalaman pasien secara mendalam
   B. Menghasilkan data numerik untuk diuji secara statistic
   C. Mengembangkan teori keperawatan secara kualitatif
   D. Mendeskripsikan interaksi perawat–pasien secara naratif
   E. Menjelaskan fenomena sosial tanpa pengukuran
2. Ciri yang paling menonjol dari penelitian kuantitatif adalah ….
   A. Data utama berupa transkrip wawancara
   B. Analisis berfokus pada tema dan kategori
   C. Penggunaan instrumen terstandar dan analisis statistic
   D. Tidak memerlukan prosedur pengukuran yang sistematis
   E. Selalu menggunakan observasi partisipatif
3. Penelitian yang hanya bertujuan memotret "bagaimana gambaran tingkat nyeri pasien pascaoperasi hari pertama" termasuk desain ….
   A. Eksperimen
   B. Quasi eksperimen
   C. Korelasional
   D. Deskriptif
   E. Longitudinal
4. Penelitian yang ingin mengetahui "apakah terdapat hubungan antara dukungan keluarga dan kepatuhan minum obat" menggunakan desain ….
   A. Eksperimen
   B. Quasi eksperimen
   C. Deskriptif
   D. Korelasional
   E. Studi kasus

5. Penelitian yang menguji pengaruh intervensi keperawatan dengan kelompok intervensi dan kelompok kontrol yang dibentuk secara acak disebut desain ….
   A. Deskriptif
   B. Korelasional
   C. Eksperimen
   D. Quasi eksperimen
   E. Studi kohort
6. Seorang perawat menilai perubahan skor kecemasan pasien sebelum dan sesudah terapi relaksasi pada kelompok yang sama. Desain yang paling sesuai adalah ….
   A. Deskriptif potong lintang
   B. Korelasional
   C. Eksperimen dengan kontrol acak
   D. One group pretest–posttest (quasi eksperimen)
   E. Studi kasus kualitatif
7. Ciri utama desain quasi eksperimen adalah ….
   A. Selalu menggunakan randomisasi penuh
   B. Tidak menggunakan instrumen terstandar
   C. Tidak memiliki kelompok pembanding
   D. Menguji pengaruh intervensi tanpa penugasan acak penuh
   E. Hanya menggunakan data kualitatif
8. Penelitian yang dilakukan pada satu waktu pengukuran (satu kali datang) terhadap sekelompok responden disebut desain ….
   A. Longitudinal
   B. Cross sectional
   C. Case control
   D. Eksperimen
   E. Kohort prospektif
9. Penelitian "Gambaran tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan keperawatan di ruang rawat inap" paling tepat dikategorikan sebagai ….
   A. Penelitian eksperimen
   B. Penelitian quasi eksperimen
   C. Penelitian deskriptif
   D. Penelitian korelasional
   E. Penelitian kohort

10. Desain yang paling kuat untuk menyimpulkan hubungan sebab-akibat adalah ….
    A. Deskriptif
    B. Korelasional
    C. Eksperimen
    D. Studi potong lintang
    E. Studi kasus
11. Dalam penelitian "pengaruh edukasi pencegahan luka tekan terhadap tingkat pengetahuan keluarga pasien stroke", variabel independen adalah ….
    A. Tingkat pengetahuan keluarga
    B. Program edukasi pencegahan luka tekan
    C. Lama perawatan pasien
    D. Usia keluarga pasien
    E. Jenis kelamin pasien
12. Pernyataan yang paling tepat tentang variabel dependen adalah ….
    A. Variabel yang selalu diatur peneliti
    B. Variabel yang menjadi luaran atau respon dari perlakuan
    C. Variabel yang tidak perlu diukur
    D. Variabel yang hanya berbentuk ordinal
    E. Variabel yang tidak dipengaruhi variabel lain
13. Operasionalisasi variabel bertujuan untuk ….
    A. Mengurangi jumlah responden
    B. Mengubah variabel dependen menjadi independent
    C. Mengubah konsep abstrak menjadi indikator yang dapat diukur
    D. Menentukan ukuran sampel secara statistic
    E. Menghilangkan kebutuhan instrumen
14. Data "tingkat nyeri" yang diukur dengan skala numerik 0–10 termasuk ….
    A. Skala nominal
    B. Skala ordinal murni
    C. Skala interval/rasio (dapat dianalisis sebagai data numerik)
    D. Skala nominal dikotomi
    E. Skala kategorik tanpa urutan
15. Contoh definisi operasional yang tepat untuk variabel "kepatuhan minum obat" adalah ….
    A. Perasaan pasien setelah minum obat
    B. Sikap pasien terhadap obat yang dikonsumsi
    C. Pengetahuan pasien tentang efek samping obat
    D. Persentase dosis obat yang diminum sesuai resep dalam 1 bulan

E. Jumlah obat yang diresepkan dokter

16. Instrumen yang paling tepat untuk mengukur "tingkat kecemasan pasien praoperasi" adalah ….
    A. Skala nyeri visual analog
    B. Skala kecemasan yang terstandar
    C. Lembar observasi intake–output
    D. Formulir identitas pasien
    E. Buku catatan harian perawat
17. Pernyataan yang benar mengenai validitas instrumen adalah ….
    A. Validitas hanya penting pada penelitian kualitatif
    B. Instrumen valid pasti memiliki reliabilitas nol
    C. Validitas menunjukkan sejauh mana instrumen mengukur apa yang seharusnya diukur
    D. Instrumen valid tidak perlu uji coba
    E. Validitas ditentukan hanya oleh panjang kuesioner
18. Reliabilitas instrumen berkaitan dengan ….
    A. Banyaknya responden penelitian
    B. Konsistensi hasil pengukuran ketika instrumen digunakan berulang
    C. Banyaknya teori yang dikutip peneliti
    D. Kekuatan hubungan antarvariabel
    E. Jumlah hipotesis yang diuji
19. Uji reliabilitas internal untuk kuesioner skala likert paling sering dinyatakan dengan ….
    A. Nilai p
    B. Koefisien korelasi Pearson
    C. Koefisien Cronbach's alpha
    D. Nilai chi-square
    E. Odds ratio
20. Alasan penting melakukan uji coba (pilot test) instrumen sebelum penelitian utama adalah ….
    A. Mengurangi jumlah butir pertanyaan demi estetika
    B. Menilai kejelasan butir dan fungsi instrumen sebelum digunakan luas
    C. Menghindari proses uji validitas
    D. Mengubah variabel penelitian
    E. Menggantikan proses pengumpulan data utama

Kunci Jawaban :

1. B
2. C
3. D
4. D
5. C
6. D
7. D
8. B
9. C
10. C
11. B
12. B
13. C
14. C
15. D
16. B
17. C
18. B
19. C
20. B

Skenario Kasus

Di sebuah rumah sakit tipe B, angka kejadian jatuh pada pasien lansia di ruang rawat inap meningkat dalam enam bulan terakhir. Tim keperawatan telah menyusun program edukasi pencegahan jatuh yang ditujukan kepada keluarga pasien lansia. Program ini berisi penjelasan mengenai faktor risiko jatuh, langkah-langkah pengamanan lingkungan, cara membantu mobilisasi yang aman, dan tanda-tanda risiko tinggi jatuh. Edukasi diberikan oleh perawat edukator menggunakan media video dan booklet yang diputar dan dibagikan saat awal pasien dirawat.

Seorang perawat peneliti ingin mengetahui apakah program edukasi pencegahan jatuh tersebut berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan keluarga pasien lansia dan angka kejadian jatuh di ruang rawat inap. Perawat berencana membandingkan satu ruang rawat yang menerapkan program edukasi secara rutin dengan ruang rawat lain yang belum menerapkan program tersebut. Di

kedua ruang tersebut, pasien lansia dengan kriteria tertentu akan diikutsertakan dalam penelitian.

Sebelum menyusun proposal lengkap, perawat perlu merancang desain penelitian kuantitatif yang sesuai, menentukan variabel yang akan diukur, memilih instrumen yang tepat, serta merencanakan cara pengumpulan dan analisis data.

Pertanyaan

1. Berdasarkan skenario di atas, jelaskan jenis desain penelitian kuantitatif yang paling tepat digunakan. Sertakan alasan yang mendukung pilihan Anda.
2. Identifikasi:
   a. Variabel independent
   b. Variabel dependen (minimal dua)
   c. Satu contoh variabel kontrol yang perlu diperhatikan dalam penelitian ini.
3. Susunlah contoh **definisi operasional** untuk variabel "tingkat pengetahuan keluarga tentang pencegahan jatuh" (minimal memuat: definisi singkat, cara ukur, skala ukur).
4. Jelaskan secara singkat:
   a. Instrumen apa yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pengetahuan keluarga tentang pencegahan jatuh.
   b. Mengapa penting bagi peneliti untuk memastikan validitas dan reliabilitas instrumen tersebut sebelum digunakan dalam penelitian utama.
5. Peneliti ingin menganalisis data sebagai berikut:
   a. Menggambarkan rata-rata skor pengetahuan keluarga di ruang yang mendapatkan edukasi dan ruang yang belum mendapatkan edukasi.
   b. Menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata skor pengetahuan antara kedua kelompok.

   Sebutkan jenis analisis data yang sesuai untuk langkah (a) dan (b), serta jelaskan secara singkat tujuan masing-masing analisis.

Kunci Jawaban Singkat (untuk penulis/dosen)

1. Jenis desain penelitian

   a. Desain yang paling tepat adalah **quasi eksperimen** dengan kelompok intervensi dan kelompok pembanding (non-equivalent control group).
   b. Alasan: terdapat intervensi (program edukasi pencegahan jatuh) yang diberikan pada satu ruang, dibandingkan dengan ruang lain yang belum menerapkan program; penugasan pasien/keluarga ke ruang tidak

dilakukan secara acak, sehingga tidak memenuhi kriteria eksperimen murni.

2. Variabel penelitian

a. Variabel independen: Penerapan program edukasi pencegahan jatuh (ya: ruang dengan program; tidak: ruang tanpa program).
b. Variabel dependen (minimal dua):
   1) Tingkat pengetahuan keluarga tentang pencegahan jatuh.
   2) Angka kejadian jatuh pada pasien lansia (jumlah insiden jatuh dalam periode tertentu).
c. Contoh variabel kontrol: Usia pasien lansia, tingkat kemandirian/mobilitas, atau jumlah perawat di shift yang sama.

3. Definisi operasional variabel "tingkat pengetahuan keluarga"

a. Definisi: Tingkat pemahaman keluarga pasien lansia mengenai faktor risiko jatuh, langkah pencegahan, dan tindakan yang perlu dilakukan untuk menjaga keselamatan pasien.
b. Cara ukur: Diukur menggunakan kuesioner pengetahuan pencegahan jatuh yang berisi, misalnya, 20 butir pertanyaan pilihan ganda; jawaban benar diberi skor 1, jawaban salah skor 0, kemudian dijumlahkan.
c. Skala ukur: Skala interval; skor total dapat dikategorikan (misalnya rendah, sedang, tinggi) sesuai rentang yang ditentukan peneliti.

4. Instrumen dan validitas–reliabilitas

a. Instrumen:
   1) Kuesioner pengetahuan pencegahan jatuh yang disusun berdasarkan literatur dan panduan praktik klinik, dapat berupa instrumen baru atau adaptasi dari kuesioner yang sudah ada.
   b. Pentingnya validitas dan reliabilitas:
   2) Validitas memastikan bahwa kuesioner benar-benar mengukur pengetahuan tentang pencegahan jatuh, bukan aspek lain seperti sikap atau kecemasan.
   3) Reliabilitas menjamin bahwa kuesioner memberikan hasil yang konsisten bila digunakan pada kelompok dengan karakteristik serupa; instrumen yang tidak reliabel akan menghasilkan data yang sulit dipercaya dan melemahkan kesimpulan penelitian.

5. Analisis data

a. Untuk menggambarkan rata-rata skor pengetahuan keluarga di dua ruang:

1) Gunakan **analisis deskriptif**: mean, standar deviasi, dan distribusi frekuensi; tujuan: memberikan gambaran umum mengenai tingkat pengetahuan di masing-masing kelompok.
2) Untuk menguji perbedaan rata-rata skor pengetahuan antara dua kelompok:
3) Gunakan **uji t independen** (independent samples t-test), dengan asumsi data berdistribusi normal dan varians relatif homogen; tujuan: menilai apakah perbedaan rata-rata skor pengetahuan antara kelompok dengan edukasi dan tanpa edukasi bersifat signifikan secara statistik.

Q. Daftar Pustaka

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

Lobiondo-Wood, G., & Haber, J. (2022). *Nursing research: Methods and critical appraisal for evidence-based practice* (10th ed.). St. Louis, MO: Elsevier.

McKenna, L., & Copnell, B. (2018). *Fundamentals of nursing and midwifery research: A practical guide for evidence-based practice* (2nd ed.). Chatswood, NSW: Elsevier.

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2021). *Nursing research: Generating and assessing evidence for nursing practice* (11th ed.). Philadelphia, PA: Wolters Kluwer.

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2024). *Polit & Beck's nursing research: Generating and assessing evidence for nursing practice* (12th ed.). Philadelphia, PA: Wolters Kluwer.

Rao, N. J. (2020). Outcome-based education: An outline. *International Journal of Innovative Science and Research Technology, 5*(5), 1022–1027.

Sharma, S. K. (2024). Quantitative research designs, hierarchy of evidence and validity. *Journal of Family Medicine and Primary Care, 13*(12), 1234–1242. https://doi.org/10.4103/jfmpc.jfmpc_1234_24

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

BAB 6

POPULASI, SAMPEL DAN TEKNIK SAMPLING

Tabel CPL

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menguasai konsep riset keperawatan dan Evidence-Based Nursing (EBN), termasuk etika, integritas ilmiah, dan hirarki bukti sebagai landasan praktik.	CPMK-1; CPMK-7
CPL-2	Mampu mengidentifikasi masalah keperawatan/praktik, merumuskan pertanyaan penelitian/EBN, serta menetapkan tujuan yang terukur.	CPMK-2; CPMK-3
CPL-3	Mampu merancang metode penelitian (kuantitatif/kualitatif) termasuk desain, populasi–sampel, sampling, instrumen, dan prosedur pengumpulan/manajemen data secara sistematis.	CPMK-4; CPMK-5
CPL-4	Mampu melakukan analisis data dasar (kuantitatif/kualitatif) dan menyajikan temuan secara ilmiah, jelas, dan dapat ditindaklanjuti.	CPMK-6; CPMK-7
CPL-5	Mampu melakukan critical appraisal bukti dan merancang penerapan EBN di praktik dengan indikator evaluasi yang terukur dan kolaboratif.	CPMK-7; CPMK-1
CPL-6	Mampu menyusun proposal/skripsi/manuskrip ilmiah, mengelola referensi, dan menyampaikan hasil secara profesional untuk perbaikan mutu layanan.	CPMK-3; CPMK-7

Tabel CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan konsep dasar riset keperawatan dan EBN, termasuk etika–integritas ilmiah, keselamatan partisipan, dan prinsip penggunaan bukti.

CPMK-2	Merumuskan masalah, tujuan, dan pertanyaan penelitian/EBN yang fokus, terukur, dan feasible sesuai konteks keperawatan.
CPMK-3	Melakukan telaah pustaka sistematis sederhana, mengelola referensi, serta menyusun kerangka teori/konsep dan hipotesis/rumusan konseptual yang logis.
CPMK-4	Menentukan desain penelitian kuantitatif/kualitatif yang sesuai, termasuk populasi–sampel, teknik sampling, dan kontrol kualitas metodologis.
CPMK-5	Menyusun instrumen dan rencana pengukuran, prosedur pengumpulan data, serta manajemen data (keamanan, kerahasiaan, kualitas) yang dapat diaudit.
CPMK-6	Melakukan analisis data kuantitatif dasar dan analisis data kualitatif, serta menyajikan temuan dalam format ilmiah yang jelas.
CPMK-7	Melakukan critical appraisal dan menetapkan tingkat bukti, merancang implementasi EBN di praktik, serta menyusun proposal/skripsi/manuskrip sesuai kaidah ilmiah.

Tabel Pemetaan Bab–Sub-CPMK–CPMK

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 1. Konsep Dasar Riset Keperawatan dan Evidence-Based Nursing (EBN)	1.1 Menjelaskan langkah inti riset dan siklus EBN (ask–acquire–appraise–apply–assess) sebagai alur kerja berbasis bukti.	1.2 Mengidentifikasi prinsip etika, integritas ilmiah, dan perlindungan partisipan pada penelitian keperawatan.	CPMK-1	CPMK-7; CPMK-2
Bab 2. Menemukan Masalah dan Merumuskan Pertanyaan Penelitian	2.1 Mengidentifikasi gap praktik/masalah prioritas dan menyusun latar belakang berbasis data awal.	2.2 Merumuskan pertanyaan penelitian/EBN (mis. PICOT/SPIDER) dan tujuan yang terukur.	CPMK-2	CPMK-1; CPMK-3
Bab 3. Telaah Pustaka dan Manajemen Referensi	3.1 Menyusun strategi pencarian literatur (kata kunci, operator boolean, kriteria	3.2 Mengelola sitasi dan menyusun sintesis literatur ringkas (matriks	CPMK-3	CPMK-2; CPMK-7

	inklusi–eksklusi) yang dapat direplikasi.	temuan) secara konsisten.		
Bab 4. Kerangka Teori, Kerangka Konsep, dan Hipotesis	4.1 Menyusun kerangka teori/konsep dan definisi operasional konsep/variabel sesuai literatur.	4.2 Merumuskan hipotesis/rumusan konseptual dan arah hubungan antar-variabel/konsep secara logis.	CPMK-3	CPMK-4; CPMK-2
Bab 5. Desain Penelitian Kuantitatif	5.1 Membedakan desain kuantitatif utama dan memilih desain sesuai tujuan/pertanyaan.	5.2 Menetapkan variabel, outcome, dan strategi minimisasi bias sesuai desain yang dipilih.	CPMK-4	CPMK-5; CPMK-6
Bab 6. Desain Penelitian Kualitatif	6.1 Membedakan desain kualitatif utama dan memilih pendekatan sesuai tujuan eksplorasi pengalaman/konteks.	6.2 Menetapkan strategi kualitas kualitatif (kredibilitas, dependabilitas) melalui rencana prosedur dan dokumentasi jejak audit.	CPMK-4	CPMK-5; CPMK-6
Bab 7. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling	7.1 Menetapkan populasi sasaran, kriteria inklusi–eksklusi, dan kebutuhan ukuran sampel secara rasional.	7.2 Memilih teknik sampling (probability/non-probability) dan justifikasi kesesuaian dengan desain.	CPMK-4	CPMK-5; CPMK-2
Bab 8. Instrumen Penelitian dan Pengukuran	8.1 Memilih/menyusun instrumen sesuai konstruk dan skala ukur untuk menghasilkan data yang valid.	8.2 Menyusun rencana uji validitas–reliabilitas (atau trustworthiness untuk instrumen kualitatif) termasuk uji coba/pilot.	CPMK-5	CPMK-4; CPMK-6
Bab 9. Prosedur	9.1 Menyusun SOP pengumpulan data	9.2 Menetapkan manajemen data	CPMK-5	CPMK-1; CPMK-7

Pengumpulan Data dan Manajemen Data	(alur, peran, kontrol kualitas) termasuk persetujuan partisipan.	(coding, cleaning, penyimpanan aman, kerahasiaan) yang dapat diaudit.		
Bab 10. Analisis Data Kuantitatif Dasar	10.1 Memilih teknik analisis deskriptif dan uji dasar sesuai jenis data dan tujuan analisis.	10.2 Menginterpretasi output analisis dan melaporkan hasil secara ringkas (parameter kunci dan makna klinis).	CPMK-6	CPMK-4; CPMK-7
Bab 11. Analisis Data Kualitatif dan Penyajian Temuan	11.1 Melakukan coding dan membangun kategori/tema berdasarkan data kualitatif secara sistematis.	11.2 Menyajikan temuan (narasi, tabel/diagram) dengan keterlacakan data dan koherensi interpretasi.	CPMK-6	CPMK-3; CPMK-7
Bab 12. Critical Appraisal dan Hirarki Bukti	12.1 Melakukan critical appraisal menggunakan checklist yang relevan untuk menilai risiko bias dan kualitas studi.	12.2 Menetapkan tingkat bukti dan kekuatan rekomendasi untuk keputusan praktik/penelitian lanjutan.	CPMK-7	CPMK-1; CPMK-3
Bab 13. Implementasi Evidence-Based Nursing di Praktik	13.1 Menyusun sintesis bukti untuk menjawab pertanyaan praktik dan merumuskan rekomendasi berbasis bukti.	13.2 Merancang rencana implementasi EBN (stakeholder, indikator proses–hasil, audit–umpan balik) yang terukur.	CPMK-7	CPMK-6; CPMK-2
Bab 14. Penyusunan Proposal, Skripsi, dan Publikasi Ilmiah	14.1 Menyusun dokumen proposal/skripsi dengan konsistensi metodologis (latar–	14.2 Menyusun manuskrip/presentasi ilmiah dengan sitasi benar, struktur IMRAD, dan	CPMK-7	CPMK-3; CPMK-6

	metode–rencana analisis–etik).	kepatuhan etika publikasi.		

Tabel Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-1	Ujian tulis (CBT/essay terstruktur)	Persentase jawaban benar konsep inti EBN/etika dan ketepatan identifikasi isu etik pada skenario.	10	Nilai ujian; lembar jawaban
CPMK-2	Tugas perumusan masalah & pertanyaan (template PICOT/SPIDER)	Ketepatan struktur pertanyaan (komponen lengkap) dan keterukuran tujuan/outcome (skor rubrik).	10	Dokumen pertanyaan & tujuan
CPMK-3	Tugas telaah pustaka ringkas + matriks literatur	Reproducibility strategi pencarian (kriteria jelas) dan kualitas sintesis/kerangka konsep (skor rubrik).	15	Matriks literatur; kerangka konsep
CPMK-4	Ujian/penugasan rancangan metode (protocol brief)	Kesesuaian desain dengan pertanyaan dan ketepatan rencana sampling/ukuran sampel (skor rubrik).	15	Protocol brief metode
CPMK-5	Penugasan instrumen + SOP	Kesesuaian instrumen–skala ukur dan	15	Draft instrumen; SOP; data dictionary

	pengumpulan/manajemen data	kelengkapan SOP/manajemen data (checklist/rubrik).		
CPMK-6	Praktikum analisis data (dataset/skenario) + laporan singkat	Akurasi pemilihan analisis dan interpretasi output serta kualitas penyajian temuan (skor rubrik).	15	File/hasil analisis; laporan ringkas
CPMK-7	Proyek mini EBN + critical appraisal + draft proposal/manuskrip	Ketepatan appraisal (risiko bias/tingkat bukti) dan keterukuran rencana implementasi/struktur dokumen ilmiah (skor rubrik).	20	Form appraisal; rencana implementasi; proposal/manuskrip

Tabel Rubrik CPMK (skala 1–4)

Rubrik CPMK-1

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Ketepatan konsep inti riset/EBN (% benar)	<60% benar; miskonsepsi dominan	60–74% benar; miskonsepsi masih ada	75–89% benar; kesalahan minor	≥90% benar; konsisten
1.2 Ketepatan identifikasi isu etik pada skenario	Banyak isu kunci terlewat/keliru	Isu inti teridentifikasi; alasan lemah	Isu inti tepat; alasan logis	Isu lengkap; alasan kuat, mempertimbangkan risiko–mitigasi

Rubrik CPMK-2

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Kualitas struktur pertanyaan (kelengkapan komponen)	Komponen tidak lengkap; fokus tidak jelas	Komponen cukup; fokus masih melebar	Komponen lengkap; fokus jelas	Komponen sangat lengkap; sangat fokus dan operasional
2.2 Keterukuran tujuan/outcome & kelayakan (feasibility)	Tidak terukur; tidak feasible	Sebagian terukur; feasibility belum jelas	Terukur; feasibility logis	Sangat terukur; feasibility kuat dengan batasan jelas

Rubrik CPMK-3

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Reproducibility strategi pencarian & seleksi literatur	Tidak sistematis; tidak dapat diulang	Cukup sistematis; detail kurang	Sistematis; detail memadai untuk diulang	Sangat sistematis; transparan (query, kriteria, alur seleksi)
3.2 Kualitas sintesis & kerangka konsep/hipotesis	Sintesis lemah; kerangka tidak logis	Sintesis ada; kerangka kurang kuat	Sintesis baik; kerangka logis berbasis literatur	Sintesis sangat kuat; kerangka koheren dan menunjukkan gap jelas

Rubrik CPMK-4

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Kesesuaian desain dengan pertanyaan	Desain tidak sesuai; bias tidak dipertimbangkan	Desain cukup sesuai; kontrol bias terbatas	Desain sesuai; kontrol bias jelas	Desain sangat sesuai; kontrol bias komprehensif dan realistis

& kontrol bias				
4.2 Ketepatan rencana sampling (kriteria, ukuran, teknik)	Tidak jelas/keliru; tidak dapat dilaksanakan	Cukup jelas; masih ada kekurangan bermakna	Jelas; dapat dilaksanakan; justifikasi memadai	Sangat jelas; justifikasi kuat; mempertimbangkan keterbatasan dan mitigasi

Rubrik CPMK-5

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Kesesuaian instrumen & skala ukur terhadap konstruk	Tidak sesuai; indikator tidak jelas	Cukup sesuai; definisi operasional kurang	Sesuai; definisi operasional jelas	Sangat sesuai; indikator sangat tepat dan konsisten
5.2 Kelengkapan SOP pengumpulan & manajemen data	SOP tidak lengkap; risiko kualitas/kerahasiaan tinggi	SOP cukup; kontrol kualitas/keamanan belum konsisten	SOP lengkap; kontrol kualitas dan keamanan jelas	SOP sangat lengkap; audit trail kuat (coding, cleaning, storage, akses)

Rubrik CPMK-6

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Akurasi pemilihan analisis & interpretasi output kuantitatif	Salah memilih analisis;	Analisis cukup tepat; interpretasi terbatas	Analisis tepat; interpretasi jelas	Analisis sangat tepat; interpretasi kuat dan

	interpretasi keliru			bermakna klinis
6.2 Kualitas analisis kualitatif/penyajian temuan	Coding tidak sistematis; temuan tidak terlacak	Coding cukup; tema kurang koheren	Coding sistematis; tema koheren; penyajian jelas	Sangat sistematis; tema kuat; penyajian transparan dan meyakinkan

Rubrik CPMK-7

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Ketepatan critical appraisal & penetapan tingkat bukti	Penilaian bias keliru; tingkat bukti tidak tepat	Penilaian cukup; masih ada kekeliruan bermakna	Penilaian tepat; tingkat bukti sesuai	Penilaian sangat tepat; justifikasi kuat dan konsisten
7.2 Keterukuran rencana implementasi/struktur dokumen ilmiah	Rencana/dokumen tidak sistematis; indikator tidak terukur	Cukup sistematis; indikator sebagian terukur	Sistematis; indikator proses–hasil terukur	Sangat sistematis; indikator komprehensif (baseline–target–cara ukur) dan rencana audit jelas

A. Populasi

Penyusunan rancangan penelitian merupakan penentu besar sampel yang menjadi aspek krusial dalam menentukan kualitas dan kebermanfaatan hasil studi. Sebuah penelitian klinis baru dapat dikatakan memberikan kontribusi nyata apabila temuannya tidak hanya relevan secara klinis (*clinically important*), tetapi juga didukung oleh uji statistik yang bermakna (*statistically significant*).

Kelemahan dalam menentukan jumlah subjek sering kali berdampak pada kegagalan uji statistik, yang memicu munculnya bias publikasi. Fenomena ini terjadi karena banyak hasil penelitian "negatif" tidak diterbitkan, sehingga literatur kesehatan cenderung hanya menampilkan data yang signifikan secara statistik. Padahal, dalam banyak kasus, hasil yang tidak bermakna tersebut bukanlah disebabkan oleh ketiadaan efek medis, melainkan sekadar akibat dari kurangnya jumlah subjek yang dilibatkan dalam penelitian. Pemahaman yang mendalam mengenai konsep dan batasan populasi akan memastikan penentuan jumlah subjek yang tepat dan representatif, sehingga memperkuat validitas serta kualitas hasil penelitian secara menyeluruh.

Populasi adalah seluruh subyek atau data dengan karateristik tertentu yang akan diteliti. Populasi target adalah populasi yang memenuhi sampling kriteria dan menjadi sasaran akhir penelitian. Populasi terjangkau adalah populasi yang memenuhi kriteria dalam penelitian dan biasanya dapat dijangkau oleh peneliti. Literatur lain menyebutkan populasi terbagi menjadi populasi sampling dan populasi sasaran. Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai penerapan klasifikasi tersebut, berikut adalah ilustrasi kasus yang membedakan berbagai tipe populasi beserta cara menentukan ukuran populasinya secara statistik.

Perbedaan populasi sampling dan populasi sasaran sebagai contoh kita akan melakukan penelitian tentang "Hubungan antara Tingkat Stress Kerja dengan Kualitas Dokumentasi Asuhan Keperawatan". Apabila yang menjadi objek penelitian kita adalah seluruh perawat pelaksana yang bekerja di Rumah Sakit Tipe A di Provinsi Kalimantan Barat, tetapi yang diteliti (yang dijadikan sumber data) adalah seluruh perawat pelaksana di RSUD dr. Soedarso Pontianak yang bekerja di instalasi rawat inap. maka seluruh perawat pelaksana adalah Populasi Sampling dan seluruh perawat pelaksana yang bekerja di Rumah Sakit Tipe A adalah Populasi Sasaran.

Ukuran populasi dinotasikan dengan huruf N, menunjukkan banyaknya unsur atau elemen yang terdapat pada satu kategori populasi tertentu. Misalnya, populasi penelitian kita adalah seluruh mahasiswa Universitas X yang terdaftar

secara resmi pada semester genap 2007/2008 yang berjumlah 500 orang. Maka angka 500 adalah ukuran populasi (N=500).

B. Sampel

Sampel merupakan representasi dari populasi yang menjadi objek penelitian. Penentuan ukurannya dilakukan melalui berbagai metode yang disesuaikan dengan tujuan serta desain studi yang digunakan. Agar hasil penelitian kuantitatif valid secara statistik, diperlukan minimal 30 sampel yang memenuhi kriteria representatif. Langkah ini penting untuk menjaga homogenitas responden dan meminimalisir bias, terutama jika terdapat variabel kontrol yang berpotensi memengaruhi variabel utama. Untuk menjamin validitas data, peneliti menggunakan dua filter utama dalam pemilihan responden:

a. **Kriteria Inklusi:** Menentukan karakteristik layak dari populasi target. Contohnya, pada penelitian peristaltik usus pascaoperasi, variabel usia dan teknik anestesi wajib diperhitungkan karena pengaruhnya yang besar.
b. **Kriteria Eksklusi:** Mengeluarkan subjek dari studi berdasarkan alasan berikut:
    1. Adanya kondisi kesehatan yang dapat mengaburkan hasil pengukuran.
    2. Masalah teknis yang menghambat pelaksanaan (seperti subjek yang sulit dihubungi).
    3. Pelanggaran terhadap prinsip etika penelitian.
    4. Keputusan subjek untuk tidak bersedia ikut serta.

Penentuan Besar Sampel

a. Jika besar populasi ≥ 1000, maka sampel bisa diambil 20 – 30%.
b. Jika besar populasi <1000, maka:

$$n = \frac{N.z^2\,p.q}{d^2\,(N-1) + z^2.p.q}$$
$$= \frac{48\,(1{,}96)^2.05.0{,}5}{(0{,}05)(0{,}05)(48-1)+(1{,}96)^2.0{,}5.0{,}5}$$
$$= 37{,}03 = 37\ responden$$

Keterangan:

n: Perkiraan jumlah sampel
N: Perkiraan besar populasi
Z: Nilai standar normal α = 0,05 (1,96)
P: Perkiraan proporsi, jika tidak diketahui dianggap 50 %
q: 1 – p (100% - p)
d: Tingkat kesalahan yang dipilih (d = 0,05).

C. Teknik Sampling

Sampling adalah suatu proses dalam menyeleksi porsi dari populasi untuk dapat mewakili suatu populasi. Teknik sampling merupakan cara-cara yang ditempuh dalam pengambilan sampel, agar memperoleh sampel yang benar-benar sesuai dengan keseluruhan subjek penelitian. Cara pengambilan sampel dapat digolongkan menjadi dua, yaitu: probability sampling dan nonprobability sampling. Prinsip utama probability sampling adalah bahwa setiap subjek dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih atau tidak terpilih sebagai sampel penelitian. Setiap bagian populasi mungkin berbeda satu dengan lainnya tetapi menyediakan populasi parameter, mempunyai kesempatan menjadi sampel yang representatif. Probability sampling terdiri dari:

1. *Simple random sampling*

Pemilihan sampel dengan cara ini merupakan jenis probabilitas yang paling sederhana dan digunakan jika populasi homogen. Untuk mencapai sampling ini, setiap elemen diseleksi secara acak. Peneliti terlebih dahulu mempunya daftar/ list dari responden. Pengambilan sampel melalui undian atau menggunakan bilangan random, maka secara acak kita mengambil nomor undian kemudian disesuaikan dengan daftar responden.

2. *Stratified random sampling*

Stratified artinya strata atau kedudukan subyek (seseorang) di masyarakat. Jenis sampling ini digunakan peneliti untuk mengetahui beberapa variabel pada populasi yang merupakan hal yang penting untuk mencapai sampel yang representatif. Misalnya: jika kita merencanakan 100 sampel, peneliti mengelompokkan 25 subjek dengan tingkat pendidikan: SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Pada jenis ini harus diyakinkan bahwa semua variabel yang diidentifikasi akan mewakili populasi.

3. *Cluster sampling*

Cluster berarti pengelompokan sampel berdasarkan wilayah atau lokasi populasi, digunakan jika populasi heterogen. Dalam kelompok - kelompok (cluster/area/wilayah) tersebut masih mengandung unit populasi yang heterogen. Cluster/area yang terpilih ini kemudian diambil unit populasi 20 secara random, sehingga diperoleh sampel yang heterogenitasnya sama dengan heterogenitas populasinya.

4. *Systematic sampling*

Pada sampling sistematik ditentukan bahwa dari seluruh subjek yang dapat dipilih, setiap subjek nomor ke sekian dipilih sebagai sampel. Apabila kita ingin mengambil 1/n dari populasi, maka tiap pasien nomor ke-n dipilih sebagai sampel. Pengambilan sampel secara sistematik dapat dilaksanakan jika tersedia

daftar subjek yang dibutuhkan. Sebagai contoh jika jumlah populasi adalah N=1200 dan sampel yang dipilih 50, maka setiap kelipatan 24 orang akan menjadi sampel (1200:50= 24). Maka sampel yang dipilih didasarkan pada nomor kelipatan 24, 48, 72, dan seterusnya.

Nonprobability sampling merupakan cara pemilihan sampel yang lebih praktis dan lebih mudah dilakukan daripada probability sampling, karenanya dalam penelitian klinis lebih sering digunakan daripada probability sampling. Namun perlu diingat bahwa karena semua prosedur statistika berdasarkan pada asumsi bahwa sampel diambil secara probability sampling (khususnya random), maka kesahihan sampel nonprobability terletak pada seberapa benar karakteristik sampel yang dipilih menyerupai karakteristik sampel bila pemilihan dilakukan dengan cara probability sampling. Teknik pengambilan sampel nonprobability sampling terdiri dari:

1. ***Purposive sampling***

   Purposive sampling disebut juga judgment sampling. Teknik penetapan sampel dengan cara memilih sampel diantara populasi sesuai yang dikendaki peneliti. Pada cara ini peneliti memilih responden berdasarkan pada pertimbangan 21 subyektifnya, bahwa responden tersebut dapat memberikan informasi yang memadai untuk menjawab pertanyaan penelitian. Misalnya, untuk meneliti pendapat ibu tentang pemberian ASI dan susu formula, dipilih ibu-ibu yang pernah memberikan ASI dan pernah pula memberikan susu formula kepada bayinya, atau ibu yang pendidikannya cukup sehingga dapat memberi keterangan yang lebih akurat.

2. ***Consecutive sampling***

   Pemilihan sampel dengan menetapkan subyek yang memenuhi kriteria penelitian dimasukkan dalam penelitian sampai kurun waktu tertentu, sehingga jumlah pasien yang diperlukan terpenuhi. Pada consecutive sampling, semua subyek yang datang dan memenuhi kriteria pemilihan dimasukkan dalam penelitian sampai jumlah subyek yang diperlukan terpenuhi. Sampling ini merupakan jenis nonprobability yang paling baik, dan sering merupakan cara termudah. Agar hasil pemilihan dengan sampling ini dapat menyerupai hasil dengan probability sampling, maka jangka waktu pemilihan responden harus tidak terlalu pendek, terutama untuk penyakit yang dipengaruhi musim. Contoh: pengambilan sampel demam berdarah dengue pada bulan Agustus dan September mungkin tidak mewakili karakteristik pasien DBD pada umumnya, karena puncak insiden penyakit ini biasanya terjadi antara bulan April-Juni, dan karakteristik pasien pada puncak insiden tidak sama dengan bulan lain.

3. Convinience sampling

Pemilihan sampel dengan mencari subyek atas dasar hal - hal yang menyenangkan bagi peneliti. Subyek dijadikan sampel karena kebetulan 22 dijumpai di tempat dan waktu secara bersamaan pada pengumpulan data. Cara ini merupakan cara termudah untuk menarik sampel, namun sekaligus juga merupakan cara yang paling lemah. Pada cara ini sampel diambil tanpa sistematika tertentu, hingga jarang dapat dianggap dapat mewakili populasi terjangkau, apalagi populasi target.

4. Quota sampling

Penetapan subyek penelitian berdasarkan subjek yang mempunyai pengaruh besar terhadap populasi. Penetapan subyek berdasarkan daya tampung/kapasitas yang diperlukan dalam penelitian.

D. Aktivitas 1 — Knows How (Mini Case)

Kasus:

Seorang mahasiswa keperawatan ingin melakukan penelitian tentang "Hubungan Kualitas Tidur dengan Tekanan Darah pada Lansia di Panti Werdha X". Populasi terjangkau berjumlah 100 lansia.

Pertanyaan Diskusi:

1. Identifikasi karakteristik populasi target dan terjangkau.
2. Tentukan kriteria inklusi dan kriteria eksklusi.
3. Hitung estimasi jumlah sampel menggunakan rumus yang sesuai.
4. Pilih teknik sampling (misal: Simple Random Sampling) dan berikan justifikasinya.
5. Diskusikan jawaban bersama anggota kelompok dan presentasikan hasil diskusi di kelas.

E. Aktivitas 2 — Shows How (Praktikum)

Mahasiswa diminta mensimulasikan proses *screening* subjek berdasarkan kriteria kelayakan dan menunjukkan perilaku profesional.

Tugas: "Anda berperan sebagai perawat peneliti. Di depan Anda ada seorang klien standar (KS). Lakukan pengkajian singkat untuk menentukan apakah KS memenuhi kriteria inklusi penelitian atau harus dieksklusi"

Asesmen (Piramida Miller)

Level Miller	Metode
Knows / Knows How	Self-check + analisis mini-case
Shows How	OSCE Ringkas (Simulasi Klinis)

OSCE Ringkas + Critical Items

Critical Items (WAJIB LULUS)

- Identifikasi & Privasi
- Akurasi Seleksi
- Eskalasi / Red Flags
- Etik

Cuplikan Rubrik

Kriteria	4	3	2	1
Akurasi Sampling	Justifikasi teknik sampling sangat kuat dan realistis	Justifikasi memadai dan dapat dilaksanakan	Rencana sampling ada, namun masih ada kekurangan	Teknik keliru atau tidak dapat dilaksanakan.
Perilaku Profesional	Konsisten menjaga privasi, etik, dan sangat responsif	Berkomunikasi dengan baik dan menjaga keamanan pasien.	Komunikasi cukup jelas, namun kurang sistematis.	Tidak meminta persetujuan atau mengabaikan privasi.

Template Soal Osce Keperawatan

No.	Komponen	Isi
1	Nomor station	..... (Dikosongkan)
2	Judul station	Penentuan Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling pada Riset Klinik
3	Waktu yang dibutuhkan	13 menit
4	Tujuan station	Menilai kemampuan mahasiswa dalam menetapkan kriteria inklusi-eksklusi, menghitung besar sampel,

		menentukan teknik sampling, dan mendemonstrasikan komunikasi profesional saat rekrutmen subjek.
5	Kompetensi	1. Komunikasi, edukasi, dan konseling 2. Pengkajian kelayakan subjek 3. Analisis dan perencanaan sampling 4. Perilaku profesional
6	Kategori	Riset Keperawatan dan Manajemen Informasi
7	Instruksi untuk peserta ujian	SKENARIO KLINIK: Anda sedang menyusun proposal penelitian tentang *"Pengaruh Relaksasi Napas Dalam terhadap Tingkat Nyeri pada Pasien Post-Operasi Laparatomi"*. Data di RS menunjukkan terdapat rata-rata 40 pasien operasi laparatomi per bulan. Anda memiliki lembar data pasien (Klien Standar) yang berisi riwayat medis singkat. TUGAS: 1. Identifikasi kriteria inklusi dan eksklusi berdasarkan skenario. 2. Hitung jumlah sampel minimal jika populasi terjangkau (N) adalah 40 orang dengan *margin of error* (e) 5% menggunakan rumus Slovin. 3. Tentukan teknik sampling yang paling tepat untuk meminimalkan bias. 4. Lakukan wawancara singkat (screening) pada Klien Standar untuk menentukan apakah ia layak menjadi subjek penelitian atau harus dieksklusi.
8	Instruksi untuk penguji	SKENARIO KLINIK: Anda sedang menyusun proposal penelitian tentang *"Pengaruh Relaksasi Napas Dalam terhadap Tingkat Nyeri pada Pasien Post-Operasi Laparatomi"*. Data di RS menunjukkan terdapat rata-rata 40 pasien operasi laparatomi per bulan. Anda memiliki lembar data pasien (Klien Standar) yang berisi riwayat medis singkat. TUGAS: 1. Lakukan pengkajian fokus berdasarkan skenario tersebut pada KS.

		2. Tuliskan diagnosis keperawatan pada lembar jawab berdasarkan skenario di atas dan hasil validasi pengkajian fokus. 3. Tuliskan perencanaan keperawatan pada lembar jawab berdasarkan skenario. 4. Berikan umpan balik kepada subjek mengenai keputusan inklusi atau eksklusi secara etis dan komunikatif. INSTRUKSI PENGUJI: 1. Menilai ketepatan peserta dalam menentukan kriteria inklusi (pasien post-op laparatomi, sadar) dan kriteria eksklusi (pasien dengan gangguan kognitif atau komplikasi berat). 2. Menilai hasil perhitungan sampel (Jawaban benar: n= 36 responden). 3. Menilai ketepatan pemilihan teknik sampling (Jawaban: Consecutive Sampling atau Simple Random Sampling). 4. Menilai kemampuan komunikasi peserta saat melakukan *screening* pada KS (memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan, dan mengecek kriteria secara teliti). 5. Monitor perilaku profesional (etik, privasi, dan ketelitian).
9	Instruksi untuk klien standar	Hal-hal yang perlu dicantumkan di antaranya: 1. Identitas Pasien: Tn. A, usia 45 tahun, hari ke-1 post-operasi laparatomi. 2. Riwayat: Pasien mengeluh nyeri luka operasi, kesadaran compos mentis, namun pasien juga memiliki riwayat gangguan pendengaran berat (sebagai data kriteria eksklusi). 3. Peran: KS menjawab pertanyaan peneliti dengan jujur. Jika ditanya tentang pendengaran, KS menunjukkan kesulitan mendengar kecuali bicara sangat keras/dekat. KS bersikap kooperatif namun pasif.

10	Setting station	**Ruang Simulasi Riset:** 1. Meja dan kursi untuk peneliti dan KS. 2. Lembar kerja (kertas kosong) dan kalkulator. 3. Alat tulis. 4. Lembar kriteria inklusi/eksklusi.
11	Peralatan yang dibutuhkan	Peralatan: 1 Kalkulator. 2. Lembar status klinis pasien (Klien Standar). 3. Alat tulis dan lembar jawab peserta. 4. Handrub (untuk perilaku profesional). Peran laboran: merapikan ulang alat-alat setelah digunakan peserta, dan memastikan set ujian siap untuk peserta selanjutnya sebelum peserta masuk ruang ujian.
12	Penulis	Septina Boru Saragih, S.Kep., Ners., M.Kep
13	Referensi	Polit, D. F., & Beck, C. T. (2021). *Nursing Research*.

SOP REKRUTMEN SUBJEK DAN TEKNIK SAMPLING

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
A	Persiapan (Pra interaksi)				
1	Siapkan lembar rencana penelitian (Judul, Tujuan, Kriteria Inklusi/Eksklusi).				
2	Siapkan kalkulator dan alat tulis untuk perhitungan sampel.				
3	Cuci tangan menggunakan *handrub* sebelum menyentuh dokumen atau berinteraksi dengan pasien (Klien Standar).				
B	Analisis Data & Perhitungan				
4	Baca skenario dengan teliti: Identifikasi jumlah populasi terjangkau (N).				
5	Lakukan perhitungan besar sampel (n) menggunakan rumus Slovin secara presisi.				
6	Tentukan teknik sampling yang paling sesuai (contoh: *Simple Random* jika ada daftar nama, atau *Consecutive* jika pasien datang berurutan).				
C	Tahap Orientasi (Interaksi)				
7	Ketuk pintu, beri salam, dan perkenalkan diri (Nama dan Peran sebagai Peneliti).				
8	Jelaskan maksud dan tujuan penelitian dengan bahasa yang sederhana/non-medis.				

9	Jamin kerahasiaan identitas pasien (Anonimitas).				
D	Tahap Kerja (Screening)				
10	Lakukan wawancara singkat untuk memverifikasi kriteria inklusi (misal: "Apakah Bapak bersedia diwawancara?", "Apakah Bapak merasa nyeri?").				
11	**Penting:** Lakukan observasi/pertanyaan kritis untuk mengecek kriteria eksklusi (misal: mengecek kesadaran, pendengaran, atau komplikasi medis yang menghalangi intervensi).				
12	Ambil keputusan klinis: Apakah pasien "Layak" atau "Tidak Layak" menjadi sampel.				
D	Tahap Terminasi				
13	Sampaikan keputusan hasil screening kepada pasien secara sopan.				
14	Jika layak, minta persetujuan (*Informed Consent*). Jika tidak, ucapkan terima kasih atas waktunya				
E	Tahap Dokumentasi				
15	Dokumentasikan hasil rekrutmen pada lembar kerja yang tersedia.				
F	Penampilan Profesional				

16	Aman, nyaman, teliti, cermat, tepat, responsif				

FORM PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN

Station: Riset Keperawatan dan Evidance Based Nursing

1. Form Penilaian

No.	KOMPETENSI	INDIKATOR PENILAIAN	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S x B)
1	Analisi Sampling	Menentukan kriteria inklusi/eksklusi dan menghitung sampel secara akurat.					3	
2	Pengkajian Kelayakan	Melakukan screening pada KS secara sistematis untuk memvalidasi data inklusi.					3	
3	Komunikasi & Etik	Menjelaskan maksud penelitian dan meminta persetujuan (informed consent) dengan bahasa yang mudah dipahami.					2	
4	Perilaku Profesional	Sistematis, teliti, menjaga privasi, dan menunjukkan sikap etik peneliti.					2	
	Jumlah						10	

Keterangan skor:

- 0 = tidak dilakukan
- 1 = dilakukan tetapi tidak tepat/tidak lengkap
- 2 = dilakukan cukup tepat namun masih kurang lengkap
- 3 = dilakukan dengan tepat, lengkap, dan sistematis

RUBRIK PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN

Station: Riset Keperawatan dan Evidance Based Nursing

1. Rubrik

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S X B)
1. Analisis dan Perencanaan Sampling Aspek ini mengukur kemampuan kognitif dan analitis mahasiswa dalam merancang "siapa" yang akan diteliti. • Kriteria Inklusi & Eksklusi: Mahasiswa harus mampu menentukan batasan yang logis. Inklusi bukan sekadar "yang mau diteliti", tapi yang memiliki karakteristik klinis yang tepat. Eksklusi harus fokus pada faktor yang dapat mengganggu hasil (misal: penyakit penyerta) atau masalah etik (misal: pasien tidak sadar dalam penelitian mandiri). • Perhitungan Sampel: Mahasiswa dinilai ketepatannya dalam memasukkan angka ke rumus (Slovin/Isaac Michael). Kesalahan dalam menghitung menunjukkan ketidaksiapan dalam presisi riset. • Justifikasi Teknik Sampling: Mahasiswa tidak hanya menyebutkan nama teknik (misal: *Simple Random Sampling*), tetapi harus mampu menjelaskan mengapa teknik itu dipilih (misal: untuk meminimalkan bias seleksi).					3	
2. Pengkajian Kelayakan (Screening) Aspek ini mengukur kemampuan klinis mahasiswa dalam memvalidasi teori ke realita pasien (Klien Standar). • Ketelitian Data: Mahasiswa harus mampu menemukan "data tersembunyi" pada pasien yang					3	

membuatnya tidak layak menjadi subjek. Contoh dalam soal: Jika pasien memiliki gangguan pendengaran, padahal intervensinya adalah edukasi audio, maka mahasiswa yang kompeten harus berani memutuskan untuk mengeksklusi pasien tersebut demi validitas data. • Sistematika Pengkajian: Penilaian dilakukan pada cara mahasiswa memeriksa kondisi pasien secara berurutan, mulai dari identitas hingga kondisi fisik/psikis yang relevan dengan riset.						
3. Komunikasi & Etik Penelitian Aspek ini mengukur aspek afektif dan kemampuan menjembatani bahasa ilmiah menjadi bahasa yang dimengerti pasien. • Penyampaian Informasi: Mahasiswa harus mampu menjelaskan maksud penelitian tanpa membuat pasien merasa tertekan atau takut. Penggunaan istilah medis yang terlalu berat akan mengurangi poin. • Informed Consent: Fokus penilaian adalah pada cara mahasiswa meminta persetujuan. Mahasiswa harus menekankan bahwa partisipasi bersifat sukarela dan pasien berhak mengundurkan diri kapan saja tanpa sanksi (prinsip etik *autonomy*). • Kerahasiaan: Mahasiswa harus menyebutkan bagaimana data pasien akan dijaga (anonimitas).					2	
4. Perilaku Profesional Aspek ini menilai Kompetensi ini mengukur integritas dan kepribadian					2	

mahasiswa sebagai calon peneliti/perawat profesional. • Etika Dasar: Meliputi hal-hal mendasar namun krusial seperti mengetuk pintu, memperkenalkan diri, menjaga kontak mata, dan tidak melakukan tindakan yang merendahkan martabat pasien. • Ketelitian Dokumentasi: Bagaimana mahasiswa mencatat hasil screening secara rapi dan benar pada lembar kerja yang disediakan. • Keamanan & Higiene: Dalam konteks keperawatan, hal ini termasuk mencuci tangan atau menggunakan *handrub* sebelum dan sesudah berinteraksi dengan pasien/subjek.						

2. Deskripsi Performa Tiap Skor

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
1. Analisis dan Perencanaan Sampling	Tidak mampu menentukan kriteria inklusi/eksklusi dan tidak melakukan perhitungan sampel.	Menentukan kriteria inklusi/eksklusi tetapi tidak relevan dengan kasus; perhitungan sampel salah atau tidak menggunakan rumus.	Menentukan kriteria inklusi/eksklusi dengan cukup tepat; perhitungan sampel benar namun tidak menyertakan teknik sampling yang logis.	Menetapkan kriteria inklusi/eksklusi secara lengkap, menghitung besar sampel dengan rumus Slovin secara akurat (n = 36), dan menjustifikasi teknik sampling secara logis .
2. Pengkajian Kelayakan (Screening)	Tidak melakukan pengkajian fokus pada Klien Standar (KS) atau pengkajian tidak relevan	Melakukan pengkajian sangat terbatas, gagal mengidentifikasi data eksklusi (misal: gangguan pendengaran pada KS).	Melakukan pengkajian fokus cukup baik, namun interpretasi terhadap kelayakan subjek masih ragu-ragu	Melakukan pengkajian fokus secara lengkap dan sistematis; berhasil mengidentifikasi bahwa KS harus dieksklusi karena gangguan pendengaran
3. Komunikasi & Etik Penelitian	Tidak menjelaskan tujuan penelitian, tidak meminta persetujuan, dan tidak melakukan komunikasi terapeutik	Menjelaskan tujuan secara terbatas, penggunaan bahasa terlalu teknis (medis) sehingga sulit dipahami keluarga/KS	Melakukan komunikasi dengan cukup baik dan meminta persetujuan, namun urutan penjelasan kurang sistematis. penjelasan atau teknik demonstrasi.	Melakukan komunikasi terapeutik yang baik, menjelaskan hak subjek (anonimitas/kerahasiaan), dan meminta persetujuan tanpa paksaan sesuai prinsip otonomi.
4. Perilaku Profesional	Tidak menunjukkan perilaku profesional, tidak memperkenalkan diri, tidak meminta persetujuan, tidak menjaga privasi, dan tidak memperhatikan keamanan maupun kenyamanan pasien.	Menunjukkan sebagian kecil perilaku profesional, tetapi masih kurang dalam komunikasi terapeutik, persetujuan tindakan, privasi, atau keselamatan pasien.	Menunjukkan perilaku profesional yang cukup baik, komunikasi terapeutik cukup jelas, memperhatikan privasi, kenyamanan, dan keamanan pasien, namun masih ada kekurangan kecil dalam sikap atau sistematika tindakan.	Menunjukkan perilaku profesional secara konsisten, meliputi komunikasi terapeutik yang baik, memperkenalkan diri, meminta persetujuan, menjaga privasi, memperhatikan keamanan dan kenyamanan anak serta ibu, bersikap teliti, hati-hati, responsif, dan etis selama tindakan.

3. Keterangan Skor

Skor	Keterangan
0	Tidak dilakukan / seluruh tindakan tidak sesuai
1	Dilakukan tetapi sangat kurang tepat, tidak lengkap, atau tidak sistematis
2	Dilakukan cukup tepat dan cukup lengkap, tetapi masih ada kekurangan
3	Dilakukan dengan tepat, lengkap, sistematis, aman, dan sesuai tujuan

4. Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS (Skor Total < 60%)	BORDERLINE (Skor Total 60-70%)	LULUS (Skor Total 71-85%)	SUPERIOR (Skor Total 86-100%)

$$\text{Nilai akhir} = \frac{\text{Jumlah total skore}}{30} \times 100 =$$

(Kota), ...

.....

Penguji :.....

DOPS (Does)

1. Observasi langsung
2. Checklist + umpan balik singkat
3. Keputusan: kompeten / supervisi / remedial

Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

Komponen	Deskripsi	DOPS dalam Riset keperawatan dan EBN
Persiapan Analitis	Mahasiswa menunjukkan kesiapan dokumen riset, alat hitung, dan pemahaman parameter populasi sebelum berinteraksi dengan subjek.	Mahasiswa menyiapkan kalkulator dan lembar protokol riset. Ia mampu menyebutkan bahwa populasi terjangkau di Ruang Rawat Inap adalah 40 pasien pasca-operasi.
Akurasi Perhitungan	Kemampuan menghitung besar sampel minimal secara presisi menggunakan rumus yang relevan (misal: Slovin atau G*Power)..	Dengan N = 40 dan e = 0.05 mahasiswa menghitung: $n = 40 / (1 + 40(0,05)^2) = 36,36$. Mahasiswa membulatkan subjek menjadi 37 orang.
Fase Orientasi & Etik	Cara mahasiswa membuka interaksi, menjelaskan tujuan riset, menjamin anonimitas, dan meminta persetujuan.	"Selamat pagi Ibu S, saya perawat A. Saya sedang meneliti efektivitas terapi musik untuk nyeri. Identitas Ibu akan kami samarkan (kode) dan Ibu bebas menolak tanpa pengaruh pada perawatan."
Screening Kriteria (Inklusi)	Keterampilan melakukan wawancara/observasi untuk memastikan subjek memenuhi kriteria masuk penelitian.	Mahasiswa memvalidasi: "Apakah Ibu baru saja menjalani operasi laparatomi kemarin?" dan "Apakah saat ini Ibu merasa nyeri pada luka operasi?"
Identifikasi Red Flags (Eksklusi)	Kepekaan mahasiswa menemukan kondisi pada subjek yang dapat merusak validitas data atau membahayakan subjek.	Kasus: Mahasiswa menemukan bahwa Ibu S ternyata memiliki gangguan pendengaran berat. Mahasiswa memutuskan untuk mengeksklusi Ibu S karena intervensi musik tidak akan efektif.

Keputusan Sampling	Ketepatan dalam menentukan status akhir subjek (Layak/Tidak Layak) dan mencatatnya dalam logbook rekrutmen.	Mahasiswa mencatat: *"Subjek 004 Eksklusi (Gangguan Pendengaran)"*. Ia kemudian melanjutkan mencari kandidat subjek berikutnya sesuai teknik *Consecutive Sampling*.
Perilaku Profesional	Penampilan umum, ketelitian, empati, posisi tubuh, dan ketaatan pada protokol pencegahan infeksi (*hand hygiene*).	Mahasiswa menjaga kontak mata, melakukan *handrub* sebelum memegang dokumen pasien, dan bersikap tenang meskipun pasien bertanya banyak hal.

F. Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

1. OSCE + DOPS
2. Catatan kasus singkat
3. Feedback CI/dosen

Tabel. Portofolio pada Populasi Sampel dan Teknik Sampling.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Populasi Sampel dan Teknik Sampling
Lembar Analisis Populasi	Menentukan batasan kelompok yang akan diteliti agar hasil riset dapat diterapkan secara tepat.	Kemampuan mahasiswa mengidentifikasi Populasi Target: Seluruh pasien post-operasi laparatomi. Populasi Terjangkau: Pasien post-op laparatomi di RSUD Kota X yang berjumlah rata-rata 40 orang per bulan.
Matriks Kriteria Kelayakan	Menetapkan syarat siapa yang boleh masuk (Inklusi) dan siapa yang harus ditolak (Eksklusi).	Mahasiswa dapat menetapkan kritria Inklusi: Pasien post-op laparatomi hari ke-1, sadar penuh (Compos Mentis), skala nyeri sedang (4-6). Kriteria eksklusi: Pasien dengan komplikasi perdarahan hebat atau pasien yang terpasang ventilator.
Justifikasi Besar Sampel	Melakukan perhitungan matematis untuk menentukan jumlah responden minimal agar data valid.	Menggunakan rumus Slovin (N=40, e=0,05): $= \frac{40}{1 + 40(0,05)^2} = \frac{40}{1,1} = 36,36$ Keputusan: Sampel minimal adalah 37 responden.

Peta Alur Teknik Sampling	Menjelaskan metode pemilihan subjek agar tidak terjadi subjektivitas/bias peneliti	Mahasiswa dapat menetukan Teknik: *Consecutive Sampling*. Prosedur: Semua pasien yang datang memenuhi kriteria diambil sebagai sampel sampai jumlah 37 terpenuhi dalam kurun waktu ±1 bulan. .
Logbook Rekrutmen (Simulasi)	Catatan harian proses penyaringan pasien di lapangan	Mahasiswa mencatat bahwa Subjek 01 (Tn. A): Masuk (Sesuai inklusi). Subjek 02 (Ny. B): Eksklusi. Alasan: Pasien mengalami penurunan kesadaran pasca-anestesi (tidak bisa diajak relaksasi) .
Bukti Informed Consent	Dokumen persetujuan subjek yang telah disamarkan identitasnya	Lembar persetujuan yang ditandatangani oleh Tn. A (disamarkan sebagai Responden 01) tertanggal 31 Maret 2026.
Refleksi Diri	Analisis kritis mahasiswa terhadap pengalaman melakukan sampling.	Mahasiswa belajar refleksi dengan mengatakan "Saya belajar bahwa dalam kasus laparatomi, jumlah populasi yang kecil (40) mengharuskan saya mengambil hampir seluruh populasi sebagai sampel agar hasil penelitian kuat secara statistik."
Karakteristik penilaian	Portofolio bukan penilaian sekali selesai, tetapi kumpulan bukti yang dibangun secara berulang dan berkesinambungan. Penekanan utamanya adalah konsistensi performa mahasiswa.	Mahasisawa mampu memilah subjek yang aman dan mampu mengikuti instruksi napas dalam. Akurasi Matematis: Ketepatan hasil hitung (n = 37) untuk menjamin kekuatan data. Objektivitas: Meminimalkan bias pemilihan subjek oleh peneliti. Ketelitian Prosedural: Kemampuan melakukan verifikasi data riil di lapangan. Integritas Etik: Menghargai hak otonomi pasien dan kerahasiaan data. Kedalaman Berpikir: Kemampuan mengevaluasi proses dan merencanakan perbaikan.
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio memperlihatkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan mutu performa pada berbagai kesempatan	Kompetensi tidak boleh hanya muncul sekali. Bukti ini menunjukkan bahwa mahasiswa secara konsisten menerapkan teori ke dalam dokumen kerja (Matriks, Hitungan, Logbook) hingga tindakan nyata. • Matriks kriteria inklusi & eksklusi yang tertulis di draf proposal.

	praktik dan pada waktu yang berbeda.	• Lembar kerja perhitungan manual yang menunjukkan langkah-langkah rumus Slovin • Narasi pada bab metodologi yang menjelaskan alasan pemilihan teknik sampling non-acak. • Tabel harian rekrutmen yang mencantumkan status "Lolos/Tidak Lolos" setiap kandidat. • Contoh lembar persetujuan yang ditandatangani subjek dengan kode anonim. • Narasi reflektif minimal 1 halaman mengenai pembelajaran selama proses sampling.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tidak hanya dimiliki secara teoritis, tetapi benar-benar tampak dalam performa yang berulang, berkembang, dan terdokumentasi.	Constructive Alignment: Subjek yang dipilih dipastikan mampu mencapai target *outcome* (penurunan nyeri). Scientific Integrity: Menjamin penelitian memiliki dasar kuantitatif yang kuat (tidak asal pilih jumlah). Process Accountability: Prosedur pemilihan responden transparan dan dapat diaudit oleh orang lain. Authentic Assessment: Membuktikan mahasiswa memiliki performa nyata (bukan sekadar teori). Ethical Standard: Memastikan lulusan memiliki karakter perawat peneliti yang menjunjung hak asasi manusia. Continuous Improvement: Mahasiswa sadar akan limitasi risetnya dan mampu memberikan saran perbaikan

G. Rangkuman Materi

Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling

Populasi dalam riset keperawatan merupakan keseluruhan subjek atau satuan analisis yang memiliki karakteristik tertentu yang ingin dipelajari oleh peneliti. Dalam konteks klinis, peneliti harus mampu membedakan antara populasi target yang bersifat umum dan populasi terjangkau yang bersifat spesifik. Sebagai contoh, pada penelitian mengenai "Pengaruh Relaksasi Napas Dalam terhadap Tingkat Nyeri pada Pasien Post-Operasi Laparatomi", populasi targetnya adalah

seluruh pasien pasca-bedah abdomen, namun populasi terjangkaunya dibatasi pada pasien di rumah sakit tempat penelitian dalam kurun waktu tertentu, misalnya 40 pasien per bulan di RSUD X.

Penentuan sampel yang representatif menjadi kunci utama agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan (memiliki validitas eksternal yang kuat). Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih melalui prosedur tertentu untuk mewakili karakteristik seluruh populasi. Untuk memastikan kualitas sampel, peneliti menetapkan kriteria inklusi, yaitu karakteristik utama yang wajib dimiliki subjek seperti pasien post-op hari pertama yang memiliki kesadaran penuh. Sebaliknya, kriteria eksklusi ditetapkan untuk mengeluarkan subjek yang berisiko mengalami komplikasi atau memiliki hambatan komunikasi yang dapat mengganggu intervensi relaksasi napas dalam.

Aspek kuantitatif dalam penentuan ukuran sampel tidak boleh diabaikan demi menjaga kekuatan statistik (*power of study*). Menggunakan Rumus Slovin, peneliti dapat menghitung jumlah minimal responden yang dibutuhkan berdasarkan total populasi terjangkau dan tingkat kesalahan yang ditoleransi (biasanya 5%). Pada skenario dengan populasi 40 orang, perhitungan Slovin menghasilkan angka minimal 37 responden. Prinsip utama dalam riset keperawatan adalah melakukan pembulatan ke atas jika ditemukan angka desimal, guna menjamin bahwa jumlah sampel tidak berada di bawah ambang batas minimal yang disyaratkan untuk keakuratan data.

Pemilihan teknik sampling merupakan langkah prosedural untuk meminimalkan bias peneliti dalam memilih subjek. Terdapat dua kategori besar, yaitu Probability Sampling yang memberikan peluang sama bagi setiap anggota populasi melalui proses acak, dan Non-Probability Sampling yang lebih fleksibel digunakan pada populasi klinis yang terbatas. Dalam kasus pasien pasca-operasi, teknik *Consecutive Sampling* sering menjadi pilihan utama karena peneliti mengambil semua pasien yang memenuhi kriteria secara berurutan hingga kuota terpenuhi. Hal ini menjamin bahwa proses pemilihan subjek tetap objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam kerangka *Evidence-Based Nursing*.

H. Tabel Red Flags & Eskalasi

Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling

Red flags	Makna	Tindakan Eskalasi
Jumlah sampel di bawah target minimal (< n)	*Under-powered study*; Penelitian tidak memiliki kekuatan statistik yang cukup untuk mendeteksi perbedaan atau pengaruh intervensi yang nyata.	Perpanjang durasi waktu pengumpulan data *(extended recruitment)* atau perluas populasi terjangkau ke unit/bangsal lain yang memiliki karakteristik serupa.
Seluruh sampel berasal dari satu karakteristik ekstrem	*Selection Bias*; Sampel tidak representatif. Misal: Semua responden post-op adalah kelas VIP, sehingga tidak menggambarkan profil pasien secara umum.	Lakukan audit terhadap prosedur sampling; terapkan teknik *Stratified Random Sampling* untuk memastikan semua kelompok (strata) terwakili secara adil.
Kriteria eksklusi terlalu luas/banyak	*Low Generalizability*; Peneliti terlalu "takut" terhadap variabel pengganggu sehingga hasil riset hanya berlaku untuk kelompok yang sangat sempit dan sulit diaplikasikan di lapangan.	Tinjau ulang kriteria bersama pakar/pembimbing; hapus kriteria eksklusi yang tidak memiliki dasar ilmiah kuat terhadap variabel dependen.
Angka Drop-out / Loss to follow up > 20%	*Attrition Bias*; Banyak responden yang mengundurkan diri di tengah jalan sehingga merusak komposisi sampel awal dan hasil analisis.	Lakukan analisis penyebab ketidakhadiran; gunakan teknik *Intention-to-Treat* (ITT) analysis dan tambahkan cadangan sampel (*buffer*) sebanyak 10-20% sejak awal.
Ketidaksesuaian Inklusi saat intervensi berjalan	*Ineligible Subject*; Peneliti menemukan subjek yang tidak memenuhi syarat saat tindakan dimulai (misal: pasien tiba-tiba tidak sadar saat akan diajarkan napas dalam).	Segera keluarkan subjek dari data analisis (*excluded post-randomization*); dokumentasikan alasan pengeluaran secara transparan dan cari subjek pengganti sesuai protokol.
Sampling Frame (Daftar Nama) tidak *update*	*Coverage Bias*; Ada anggota populasi yang memiliki hak menjadi sampel tetapi tidak terdaftar dalam rekam medis/buku register saat pemilihan.	Lakukan validasi ulang data populasi terjangkau dengan berkoordinasi bersama kepala ruang atau administrasi rumah sakit sebelum proses pengundian dilakukan.

Form Checklist "Saya sudah bisa..."

Bab Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya mampu menjelaskan perbedaan antara populasi target dan populasi terjangkau dalam konteks pasien pasca-bedah.	☐	☐	_____
2	Saya mampu menetapkan kriteria inklusi dan eksklusi yang logis untuk menjaga validitas data penelitian	☐	☐	_____
3	Saya mampu menghitung jumlah sampel minimal secara akurat menggunakan rumus Slovin (Target: 37 responden).	☐	☐	_____
4	Saya mampu menjelaskan alasan (justifikasi) pemilihan teknik *Consecutive Sampling* pada penelitian di ruang bedah.	☐	☐	_____
5	Saya mampu melakukan screening klinis pada subjek untuk mengidentifikasi "*Red Flags*" (faktor yang membuat subjek harus dieksklusi).	☐	☐	_____
6	Saya mampu mendemonstrasikan cara memberikan penjelasan riset (*informed consent*) dengan bahasa yang mudah dipahami pasien.	☐	☐	_____
7	Saya mampu menjaga etika riset, termasuk menjaga kerahasiaan identitas pasien (anonimitas) dalam dokumen kerja.	☐	☐	_____
8	Saya mampu mengidentifikasi hambatan dalam proses rekrutmen subjek dan merumuskan solusi eskalasinya.	☐	☐	_____
9	Saya mampu menggunakan alat bantu (kalkulator/aplikasi/tabel) untuk menentukan ukuran sampel tanpa bantuan dosen.	☐	☐	_____

10	Saya mampu menjelaskan dampak jika penelitian dilakukan dengan jumlah sampel yang terlalu sedikit (under-sampling)..	☐	☐	_____
11	Saya mampu mendeteksi adanya sampling bias jika subjek hanya diambil dari satu lokasi atau satu waktu saja.	☐	☐	_____
12	Saya mampu menyusun lembar Screening (Checklist Inklusi-Eksklusi) yang siap digunakan di lapangan.	☐	☐	_____
13	Saya mampu mensimulasikan penanganan subjek yang tiba-tiba menolak berpartisipasi sesuai dengan prinsip etik otonomi	☐	☐	_____
14	Saya mampu menentukan kapan harus menggunakan teknik *Probability* vs *Non-Probability* berdasarkan keterbatasan populasi yang ada.	☐	☐	_____
15	Saya mampu mengaitkan hubungan antara teknik sampling yang saya pilih dengan tingkat generalisasi hasil penelitian (Validitas Eksternal)	☐	☐	_____
16	Saya mampu melakukan dokumentasi (*Logbook*) proses rekrutmen secara rapi, sistematis, dan dapat diverifikasi.	☐	☐	_____

Refleksi singkat mahasiswa:

I. Daftar Pustaka

Arifin, M. Z., & Kusumaningrum, T. (2022). Strategi penentuan besar sampel dalam uji klinis keperawatan: Sebuah tinjauan literatur. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 25(1), 34-45.

Campbell, S., et al. (2020). Purposive sampling: Complex or simple? Research case examples. *Journal of Research in Nursing*, 25(8), 652–661.

Dahlan, M. S. (2019). *Besar Sampel dan Cara Pengambilan Sampel dalam Penelitian Kedokteran dan Kesehatan* (Edisi 5). Epidemiologi Indonesia.

Haryanto, T., & Setiawan, A. (2023). Validitas internal dan eksternal dalam metodologi riset keperawatan di Indonesia: Systematic Review. Journal of Health Science and Prevention, 7(2), 88-102.

Nurdin, N., & Hartati, S. (2024). Analisis Teknik Sampling pada Penelitian Keperawatan Anak di Indonesia: Systematic Review. Jurnal Ilmiah Keperawatan Indonesia, 15(2), 45-58.

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2021). Nursing Research: Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice (11th ed.). Wolters Kluwer.

Pradana, A., et al. (2026). Efektivitas Power Analysis dalam Menentukan Ukuran Sampel pada Uji Klinis Keperawatan: Studi Literatur. Meditek Journal, 32(1), 102-115.

Sari, K., & Wijaya, I. (2025). Implementasi kriteria inklusi dan eksklusi pada penelitian intervensi keperawatan post-operasi: Tantangan di lapangan. Jurnal Riset Kesehatan Nasional, 9(1), 12-25.

Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

Turner, K., et al. (2021). Sampling and recruitment in nursing research: Lessons from the field. *Nursing Standard*, 36(5), 45-52.

PROFIL PENULIS



Ns. Ni Luh Kompyang Sulisnadewi, M.Kep., Sp.Kep.An. Lahir di Mengwitani, 22 Juni 1974. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Brawijaya tahun 2003. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Indonesia dan lulus tahun pada tahun 2011. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1996 sebagai perawat di RS Surya Husada, tahun 1997 perawat di RSUP Sanglah dan tahun 1998 memulai karir sebagai dosen di jurusan keperawatan Poltekkes Kemenkes Denpasar. Saat ini penulis bekerja di Poltekkes Kemenkes Denpasar Jurusan Keperawatan mengampu mata kuliah Keperawatan anak. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar focus bada bidang anak. Penulis juga aktif dalam organisasi yang bergerak di bidang keperawatan anak. Saat ini penulis menjabat sebagai ketua Ikatan Perawat Anak Indonesia (IPANI) Propinsi Bali**.** Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: sulisnadewi337@gmail.com
Motto: "Melayani dengan Hati, Mengabdi dengan Ilmu, Menginspirasi Sepanjang Hayat."



Nur Fadhilah, S.Kep., M.Kes., Ph,D. lahir di Gisting Kabupaten Tanggamus, 20 Juli 1975 dari seorang ayah bernama Khozin Abdullah dan ibu Fairah Marhamah. Menikah dengan M.Yusup dan dikarunia 2 orang putra (M. Haeqal Phasa & M. Zidane Al-Ghifarry) dan seorang putri (Keysha Yasmine Asshafira). Pendidikan terakhir S3 diselesaikan di Mahsa University Malaysia tahun 2023. Kariernya dimulai pada tahun 1998 sebagai perawat pelaksana di RSUAM Propinsi Lampung, di tahun yang sama penulis bekerja di Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung.
Aktif sebagai dosen pengajar pada tahun 2000 sampai dengan sekarang dengan kekhususan Mata Kuliah; Keperawatan Komunitas, Keperawatan Keluarga, Keperawatan Gerontik, Promosi Kesehatan, dan Matodologi Penelitian. Sebagai bentuk dedikasi penulis dalam dunia pendidikan, penulis telah menghasilkan berbagai buku dan karya ilmiah, program Pencegahan dan Penanggulangan TBC adalah satu aktivitas sosial berbasis Masyarakat yang dilakukan penulis bersinergi dengan dinas terkait. Selain itu penulis aktif dalam pembinaan dan penyelenggaraan Sekolah Lansia. Saat ini penulis menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan PPNI Kabupaten Pringsewu, Kood. Indonesia Ramah Lansia (IRL) Kota, sebagai ketua Majelis Kesehatan Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA) Kota Bandar Lampung, dan sebagai anggota MPKSDU PWM Lampung. Penghagaan Dosen Terinsipiratif pernah diperoleh tahun 2024.
"Don't stop when you're tired, stop when you're done"

PROFIL PENULIS



Dr. Aemilianus Mau, S.Kep., Ns., M.Kep. lahir di Malaka pada 27 Mei 1972. Pendidikan tinggi yang ditempuh diawali di Akademi Keperawatan Kupang dan lulus pada tahun 1996. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan Sarjana Keperawatan (S.Kep.) dan Profesi Ners (Ns.) pada Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Airlangga, Surabaya, dan menyelesaikannya pada tahun 2003. Penulis kemudian meraih gelar Magister Keperawatan (M.Kep.) di Universitas Airlangga pada tahun 2010. Pendidikan formal tertinggi diselesaikan pada Program Doktor (S3) Ilmu Keperawatan di Universitas Indonesia dan memperoleh gelar Doktor (Dr.) pada tahun 2023.

Karier profesional penulis diawali sebagai perawat sekaligus dosen di Pendidikan Ahli Madya Kesehatan (PAM-KT) Dili, Timor Timur, pada periode 1996–1998. Sejak bergabung dengan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kupang, penulis mengabdikan diri sebagai dosen pada Jurusan Keperawatan dan saat ini dipercaya menjabat sebagai Ketua Program Studi Profesi Ners. Di samping aktivitas akademik, penulis aktif dalam organisasi profesi sebagai Ketua Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPW PPNI) Provinsi Nusa Tenggara Timur, anggota Kolegium Keperawatan Indonesia, serta anggota Bidang Pendidikan dan Pelatihan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPP PPNI).

Dalam bidang pendidikan, penulis mengampu berbagai mata kuliah, antara lain Falsafah dan Teori Keperawatan, Komunikasi dalam Keperawatan, Manajemen dan Kepemimpinan dalam Keperawatan, Caring, Etika Keperawatan, Metodologi Penelitian, Evidence-Based Nursing, dan Keperawatan Jiwa. Penulis juga aktif membimbing mahasiswa pada penyusunan tugas akhir, karya ilmiah, dan penelitian di bidang keperawatan.

Sebagai bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, penulis aktif melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Berbagai karya ilmiah telah dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional bereputasi. Selain itu, penulis telah menghasilkan sejumlah buku ajar dan *book chapter* di bidang keperawatan, menjadi narasumber dalam seminar, pelatihan, dan workshop ilmiah, serta berperan sebagai reviewer pada beberapa jurnal ilmiah nasional dan internasional. Bidang keilmuan yang menjadi fokus penulis meliputi pengembangan model praktik keperawatan berbasis caring, etik dan budaya, pendidikan keperawatan, pemberdayaan masyarakat, pengendalian tuberkulosis, mutu dan keselamatan pasien di RS.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: aemilianusmau58@gmail.com.

Motto: *"Terus Belajar agar Ilmunya Dapat Bermanfaat bagi Banyak Orang"*

PROFIL PENULIS



Dr. Ina Debora Ratu Ludji, SKp., M.Kes Lahir di Pulau Timor, Kabupaten Belu, Perbatasan dengan Negara Timor Leste dari Ayah dan Ibu Suku Sabu, Suami Suku Bunak, memiliki 4 orang anak: 2 Perempuan dan 2 Laki-laki. Menghabiskan studi dari TK sampai SMA di Kabupaten Belu, Atambua. Tahun 1986 melanjutkan pendidikan Keperawatan di AKPER Denpasar tamat tahun 1989, sebagai tenaga sukarela di RSU Atambua dan Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, menjadi PNS Bekerja di Puskesmas Oesao sejak 1990 sd tahun 1994 sebagai Perawat kemudian melanjutkan pendidikan di PSIK Universitas Indonesia Jakarta Tamat Tahun 1997, Bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang kemudian pada tahun 1998 menjadi Dosen pada AKPER MSA Kupang (Saat ini Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Kupang). Melanjutkan pendidikan di S2 Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, llmu Kesehatan Masyarakat Minat Epidemologi, tamat tahun 2005. Menyelesaikan Pendidikan Doktor di Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesehatan Ibu dan Anak/KIA dan Kespro), tamat tahun 2013. Saat ini aktif sebagai dosen tetap di Poltekkes Kemenkes Kupang, Dosen tidak tetap S2 Pasca Sarjana di Universitas Nusa Cendana (Undana Kupang), Dosen tamu di Universitas Da Paz Timor Leste, sebagai Tim *Expert* Covid 19 Provinsi NTT, Tim Pakar IAKMI Pengda NTT, Fasilitator Nasional MTBS, Konsultan KIA Kespro serta pencegahan Stunting, Konsultan Pembuatan PERDA Sistem Kesehatan Daerah (SKD), Pendamping Teknis Kampanye Immunisasi *Measles Rubella* (MR), dan Filariasis, Penanggung Jawab Teknis (PJT) Riset Tenaga Kesehatan (Risnakes) Tahun 2017 dan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2018. Mengasuh Mata Kuliah Metodologi Penelitian/Riset, Biostatistik, Epidemiologi, Keperawatan Maternitas, Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Home Care, Manajemen Penyakit Infeksi, HIV AIDS, Pemberdayaan Masyarakat, Kebijakan Kesehatan Nasional, Keperawatan Keluarga serta Mata Kuliah Penunjang Lainnya: Etika Keperawatan, Komunikasi Keperawatan dan Caring dalam Keperawatan, Antropologi Kesehatan, Aktif menulis buku antara lain : Asuhan Keperawatan Maternitas: Kehamilan Risiko Tinggi dan Asuhan Keperawatan Maternitas: Pasca Partum, Buku Ajar Prinsip Konseling Perawatan dan Pengobatan Pasien TB HIV/AIDS Positif, Buku Ajar Pengantar Riset Keperawatan. Buku Ajar Etika Keperawatan, Buku Ajar Riset Keperawatan,, Buku Bunga Rampai Perawatan Kehamilan dan Persalinan, Buku Bunga Rampai Keperawatan Anak: Keperawatan Neonatal dan bayi Baru lahir, Buku Praktek Profesi Ners Mata Ajar Keperawatan Maternitas, Menulis Book chapter: Manajemen Laktasi, Manajemen Mutu dalam Pelayanan Keperawatan, Konsep Pelayanan Kontrasepsi dan KB, Konsep dan Aplikasi Keperawatan Berbasis *Evidence -Based Practice,* Monograf *Social Ecological Model of Health Behavior* Ina Djayaku Abadi untuk Penurunan Angka Kematian Ibu, Buku Referensi Antropologi Terapan, menulis artikel di jurnal dan koran, KBRN, menjadi nara sumber di radio swasta, RRI dan TVRI, menulis *Policy Brief* dan advokasi kebijakan kesehatan di Provinsi NTT terkait Penyakit Menular dan Tidak Menular dalam rangka pencapaian Target RPJMN dan RPJMD, Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting serta perumusan RAD Pencegahan dan penanggulangan stunting. *Reviewer* Nasional Simlitabkes Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Dosen Poltekkes Kemenkes se Indonesia, Reviewer *Ethical Clearance*, Assesor Laporan Kinerja Dosen dan Beban Kerja Dosen (BKD). Sebagai *Keynote Speaker* dan nara sumber dalam seminar Internasional dan nasional dan berbagai *event* di bidang Epidemiologi, KIA, Kespro dan Stunting. Aktif dalam penelitian dan pengabdian masyarakat dosen di Poltekkes Kemenkes Kupang maupun dengan mitra perguruan tinggi negeri lain, swasta dan Filantropi. Demikian sekilas info. Selamat membaca. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi acuan bagi pengembangan ilmu pengetahuan. penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Serta menjadi input dan inovasi untuk penelitian dan pengabdian masyarakat ke depan. Email : deboraina91@gmail.com dan Hp: 081339294324 Terima Kasih.

PROFIL PENULIS



Ns. Mellia Silvy Irdianty, M.PH. lahir di Rembang, 13 Juli 1990. Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana Keperawatan di Universitas Diponegoro dan Magister Public Health di Universitas Gadjah Mada. Penulis memulai karier sebagai dosen pada tahun 2016 dan hingga saat ini aktif dalam dunia pendidikan tinggi. Saat ini, penulis mengabdi sebagai dosen Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD), UIN Raden Mas Said Surakarta. Penulis aktif melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Bidang yang menjadi fokus penulis meliputi kesehatan ibu dan anak, tumbuh kembang dan gizi anak, kesehatan reproduksi, serta pemanfaatan teknologi dalam bidang kesehatan. Selain mengajar, penulis juga aktif melakukan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi ilmiah pada jurnal nasional dan internasional, serta penulisan buku. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: silvy.irdianty@gmail.com.
Motto: "**Long Live Education**"



Ns. Septina Boru Saragih, S,Kep., M.Kep. Lahir di Batu Ampar, 02 September 1987. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 dan Profesi Ners pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Muhammadiyah Jakarta dan lulus tahun pada tahun 2018. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2012 di STIKes Yarsi Pontianak sampai dengan tahun 2018. Saat ini penulis bekerja di STIKes Kapuas Raya Sintang pada tahun 2024 mengampu mata kuliah Manajemen Bencana, Kejadian Luar Biasa dan beberapa mata kuliah lainnya. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar**.** Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: ns.septinasaragih@gmail.com
Motto: "Mendidik dengan hati, mengabdi dengan aksi, berkarya untuk literasi kesehatan negeri."

Sinopsis

Buku Ajar Riset Keperawatan dan Evidence-Based Nursing merupakan buku ajar yang membahas dasar-dasar riset keperawatan serta penerapan *Evidence-Based Nursing* dalam praktik dan pengembangan ilmu keperawatan. Buku ini disusun untuk membantu mahasiswa memahami pentingnya riset sebagai landasan ilmiah dalam pengambilan keputusan keperawatan, peningkatan mutu pelayanan, serta pengembangan praktik klinis yang aman, etis, dan berbasis bukti. Pada bagian awal, pembaca diperkenalkan dengan konsep dasar riset keperawatan, prinsip *Evidence-Based Nursing*, etika penelitian, dan integritas ilmiah sebagai fondasi utama dalam menghasilkan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pembahasan buku ini berlanjut pada tahapan awal penyusunan penelitian, mulai dari menemukan masalah penelitian, mengenali sumber masalah di berbagai area keperawatan, merumuskan pertanyaan dan tujuan penelitian, hingga menilai kelayakan masalah menggunakan kriteria FINER. Buku ini juga menguraikan telaah pustaka dan manajemen referensi, termasuk jenis dan sumber referensi ilmiah, pemanfaatan database literatur, teknik sitasi, perangkat lunak manajemen referensi, format RIS dan BibTeX, pencegahan plagiarisme, integrasi referensi dengan Microsoft Word, strategi pencarian literatur, serta sintesis literatur yang relevan dengan praktik *Evidence-Based Nursing*.

Selain membahas dasar dan tahapan awal penelitian, buku ini juga menyajikan materi mengenai kerangka teori, kerangka konsep, hipotesis, desain penelitian kuantitatif, variabel, operasionalisasi, instrumen penelitian, validitas dan reliabilitas, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data kuantitatif dasar, populasi, sampel, serta teknik sampling. Setiap bab dilengkapi dengan rangkuman materi, latihan, studi kasus berbasis *Case-Based Learning*, aktivitas *Knows How* dan *Shows How*, praktikum, portofolio, tabel *red flags* dan eskalasi, glosarium, serta daftar pustaka. Dengan struktur tersebut, buku ini dapat menjadi panduan belajar yang aplikatif bagi mahasiswa keperawatan, dosen, peneliti pemula, dan praktisi yang ingin mengembangkan kemampuan riset serta menerapkan bukti ilmiah dalam pelayanan keperawatan.

Buku Ajar Riset Keperawatan dan Evidence-Based Nursing merupakan buku ajar yang membahas dasar-dasar riset keperawatan serta penerapan Evidence-Based Nursing dalam praktik dan pengembangan ilmu keperawatan. Buku ini disusun untuk membantu mahasiswa memahami pentingnya riset sebagai landasan ilmiah dalam pengambilan keputusan keperawatan, peningkatan mutu pelayanan, serta pengembangan praktik klinis yang aman, etis, dan berbasis bukti. Pada bagian awal, pembaca diperkenalkan dengan konsep dasar riset keperawatan, prinsip Evidence-Based Nursing, etika penelitian, dan integritas ilmiah sebagai fondasi utama dalam menghasilkan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pembahasan buku ini berlanjut pada tahapan awal penyusunan penelitian, mulai dari menemukan masalah penelitian, mengenali sumber masalah di berbagai area keperawatan, merumuskan pertanyaan dan tujuan penelitian, hingga menilai kelayakan masalah menggunakan kriteria FINER. Buku ini juga menguraikan telaah pustaka dan manajemen referensi, termasuk jenis dan sumber referensi ilmiah, pemanfaatan database literatur, teknik sitasi, perangkat lunak manajemen referensi, format RIS dan BibTeX, pencegahan plagiarisme, integrasi referensi dengan Microsoft Word, strategi pencarian literatur, serta sintesis literatur yang relevan dengan praktik Evidence-Based Nursing.

Selain membahas dasar dan tahapan awal penelitian, buku ini juga menyajikan materi mengenai kerangka teori, kerangka konsep, hipotesis, desain penelitian kuantitatif, variabel, operasionalisasi, instrumen penelitian, validitas dan reliabilitas, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data kuantitatif dasar, populasi, sampel, serta teknik sampling. Setiap bab dilengkapi dengan rangkuman materi, latihan, studi kasus berbasis Case-Based Learning, aktivitas Knows How dan Shows How, praktikum, portofolio, tabel red flags dan eskalasi, glosarium, serta daftar pustaka. Dengan struktur tersebut, buku ini dapat menjadi panduan belajar yang aplikatif bagi mahasiswa keperawatan, dosen, peneliti pemula, dan praktisi yang ingin mengembangkan kemampuan riset serta menerapkan bukti ilmiah dalam pelayanan keperawatan.

Penerbit:
PT OPTIMAL UNTUK NEGERI
Kencana Tower Lt. Mezzanine
Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005
Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

ISBN 978-634-7756-80-0 (PDF)
9 786347 756800